

Bunga Rampai
**PERAN PERAWAT
DALAM MANAJEMEN
HALUSINASI**
Pada Pasien Skizofrenia

Akbar Suseno • Reta Renylda • Isak JH Tukayo

Editor: Arni Kusuma Dewi



BUNGA RAMPAI PERAN PERAWAT DALAM MANAJEMEN HALUSINASI PADA PASIEN SKIZOFRENIA

Penulis:

Ns. Akbar Suseno, M.Kep.

Ns. Reta Renylda, M.Kep.

Dr. Isak JH Tukayo, S.Kp., M.Sc.

Editor:

Dr. Arni Kusuma Dewi, dr., M.Si.



Bunga Rampai Peran Perawat dalam Manajemen Halusinasi pada Pasien Skizofrenia

Penulis:

Ns. Akbar Suseno, M.Kep.

Ns. Reta Renylda, M.Kep.

Dr. Isak JH Tukayo, S.Kp., M.Sc.

Editor: Dr. Arni Kusuma Dewi, dr., M.Si.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7756-24-4

Cetakan Pertama: Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku bunga rampai berjudul **“Peran Perawat dalam Manajemen Halusinasi pada Pasien Skizofrenia.”** Buku ini disusun sebagai salah satu referensi akademik dan praktis dalam bidang keperawatan jiwa, khususnya terkait pemahaman dan penatalaksanaan halusinasi pada pasien skizofrenia. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang dapat memengaruhi proses pikir, persepsi, emosi, perilaku, serta fungsi sosial pasien. Salah satu gejala yang sering muncul adalah halusinasi, yang apabila tidak ditangani secara tepat dapat berdampak pada keselamatan pasien, hubungan sosial, kepatuhan terapi, dan proses pemulihan.

Buku ini membahas secara sistematis konsep dasar skizofrenia dan halusinasi, meliputi pengertian, tanda dan gejala, jenis halusinasi, rentang respons, penatalaksanaan, serta rencana tindakan keperawatan. Pembahasan dilanjutkan dengan pengkajian keperawatan jiwa pada pasien dengan halusinasi, mencakup konsep dasar pengkajian, faktor predisposisi dan presipitasi, pengkajian status mental, pengkajian terfokus pada halusinasi, pengkajian risiko, teknik komunikasi terapeutik, hingga analisis data dan perumusan masalah keperawatan. Materi tersebut diharapkan dapat membantu perawat dalam memahami kondisi pasien secara komprehensif serta merancang intervensi yang aman, tepat, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Selain berfokus pada peran perawat dalam pengkajian dan manajemen halusinasi, buku ini juga menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dalam mendukung kepatuhan terapi dan perawatan pasien skizofrenia. Dukungan keluarga, kolaborasi antarprofesi, kebijakan pemerintah, serta peran masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan perawatan dan mencegah kekambuhan. Penulis berharap buku bunga rampai ini dapat menjadi sumber rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat jiwa, tenaga kesehatan, keluarga pasien, serta pihak-pihak yang peduli terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 KONSEP DASAR SKIZOFRENIA DAN HALUSINASI..... 1

Ns. Akbar Suseno, M.Kep.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Konsep Dasar Skizofrenia.....	1
C. Konsep Dasar Halusinasi	8
D. Tanda dan Gejala Halusinasi	13
E. Jenis Halusinasi	14
F. Rentang Respon	15
G. Penatalaksanaan Halusinasi	16
H. Rencana Tindakan Keperawatan.....	17
I. Simpulan	18
J. Referensi.....	19
K. Glosarium.....	21

CHAPTER 2 PENGKAJIAN KEPERAWATAN JIWA PADA PASIEN DENGAN HALUSINASI.....23

Ns. Reta Renylda, M.Kep.....	23
A. Pendahuluan/Prolog	23
B. Konsep Dasar Pengkajian Keperawatan Jiwa	26
C. Konsep Dasar Halusinasi	31
D. Tanda dan Gejala Pasien dengan Halusinasi.....	36
E. Faktor Predisposisi dan Presipitasi Halusinasi	40
F. Pengkajian Status Mental pada Pasien Halusinasi.....	45
G. Pengkajian Terfokus pada Halusinasi	51
H. Pengkajian Risiko pada Pasien dengan Halusinasi	56
I. Teknik Komunikasi Terapeutik dalam Pengkajian Halusinasi	62
J. Analisis Data dan Perumusan Masalah Keperawatan	68
K. Simpulan	74
L. Referensi.....	74
M. Glosarium.....	76

CHAPTER 3 PERAN KELUARGA DALAM MENDUKUNG KEPATUHAN TERAPI DAN PERAWATAN PASIEN SCHIZOPHRENIA	79
Dr. Isak JH. Tukayo, M.Sc.	79
A. Pendahuluan	79
B. Fenomena Global dan Nasional	80
C. Tren Dukungan Kepatuhan Terapi.....	81
D. Peran Perawat Jiwa	82
E. Peran Profesi Lain, Kebijakan Pemerintah, Dan Masyarakat	83
F. Studi Kasus Dan Cara Penanganan.....	84
G. Tantangan.....	86
H. Simpulan	88
I. Referensi.....	89
PROFIL PENULIS	95

CHAPTER 1

KONSEP DASAR SKIZOFRENIA DAN HALUSINASI

Ns. Akbar Suseno, M.Kep.

A. Pendahuluan

Gangguan jiwa merupakan sindrom atau pola psikologis perilaku yang secara klinis ada pada individu dan berhubungan dengan kecemasan, kecacatan atau peningkatan risiko yang signifikan menyebabkan hilangnya kemandirian, kecacatan, sakit atau bahkan kehilangan nyawanya (Yanti, et.al., 2020). Banyak orang masih belum menganggap masalah kesehatan jiwa sebagai sebuah penyakit, padahal, jika gangguan jiwa tidak ditangani, hal ini dapat membahayakan kehidupan penderita maupun orang di sekitarnya (Widyaningrum & Wulandari, 2019). Setiap orang berpotensi mengalami masalah kesehatan jiwa, tetapi penderita gangguan jiwa sering mendapat diskriminasi, cemoohan, dan dianggap aib karena kurangnya pemahaman masyarakat (Zaman, et.al., 2024).

Menurut *Global Burden Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborator* (2018), karena sering muncul pada usia produktif, gangguan ini termasuk salah satu dari 20 penyebab utama disabilitas di dunia. Prevalensi skizofrenia di Indonesia berada pada angka 1,7 permil dan mengalami peningkatan signifikan menjadi 6,7 permil (Kemenkes RI, 2018).

Halusinasi merupakan tanda dan gejala skizofrenia. Halusinasi merupakan salah satu manifestasi dari masalah mental dimana pasien mengalami perubahan persepsi sensori, perasaan palsu seperti ada suara, kadang-kadang seperti penglihatan, juga dapat berupa rasa, kontak atau bau (Patimah, 2021). Klien dengan diagnosa skizofrenia menunjukkan 70% halusinasi pendengaran, 20% halusinasi penglihatan, dan 10% halusinasi penciuman, pengecapan dan perabaan (Famela et.al., 2022).

B. Konsep Dasar Skizofrenia

1. Definisi

Skizofrenia berasal dari Bahasa Yunani, "*schizo*" yang berarti terbelah atau pecah, dan "*phrenia*" yang artinya pikiran. Skizofrenia merupakan suatu bentuk psikososial fungsional dengan gangguan utama pada proses pikir serta disharmoni (keretakan, perpecahan) antara proses pikir, afek/emosi, kemauan

dan psikomotor disertai distorsi kenyataan. Skizofrenia menjadi penyakit yang serius yang mengakibatkan perilaku psikotik, gangguan dalam memproses informasi dan berhubungan interpersonal (Sihombing, 2019). Secara sederhana, *skizofrenia* menggambarkan kondisi pikiran seseorang terasa terpecah, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi cara berpikir seseorang tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi emosi dan kepribadian.

Skizofrenia adalah penyakit kronis yang membutuhkan strategi manajemen jangka panjang dan keterampilan dalam mengatasi, serta merupakan penyakit otak, sindrom klinis yang ditandai dengan pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku seseorang (Videbeck, 2020). Skizofrenia adalah kondisi psikotik yang berpengaruh terhadap fungsi individu termasuk berpikir, berkomunikasi, menerima, menafsirkan kenyataan, merasakan, dan menunjukkan emosi yang ditandai dengan pikiran kacau, delusi, halusinasi, dan perilaku maladaptif (Pardede et.al., 2020)

2. Epidemiologi

Menurut *Global Burden Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborator* (2018), karena sering muncul pada usia produktif, gangguan ini termasuk salah satu dari 20 penyebab utama disabilitas di dunia. Angka prevalensi skizofrenia bervariasi namun hampir sama di berbagai negara yaitu antara 0.5-1% populasi, estimasi 24 juta orang di dunia. World Health Organization, menyatakan bahwa ada 24 juta penderita skizofrenia di seluruh dunia atau 0,32% dari populasi global (WHO, 2022). Di Indonesia, gangguan jiwa berat skizofrenia diperkirakan 2,6 juta orang. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan prevalensi mencapai 630.827 jiwa yang memiliki anggota rumah tangga (ART) psikosis/skizofrenia di Indonesia sebanyak 4 per 1.000 rumah tangga, sedangkan prevalensi skizofrenia di Indonesia menurut data (Riskesmas, 2018) meningkat secara signifikan, yakni 6,7 per 1000 penduduk. Bali memiliki prevalensi 1,4% yang anggota rumah tangganya mengalami gangguan jiwa akibat skizofrenia (Kemenkes RI, 2024).

Sekitar 50% orang di rumah sakit jiwa memiliki diagnosis skizofrenia. Namun hanya 31,3% orang dengan psikosis yang menerima perawatan kesehatan jiwa spesialistik. Organisasi kesehatan dunia (WHO, 2022) melaporkan terdapat bukti yang jelas bahwa rumah sakit tidak efektif dalam memberikan perawatan yang dibutuhkan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi orang dengan skizofrenia (ODS). Hasil SKI tahun 2023 juga menyebutkan sebanyak 62.9% pengidap skizofrenia/psikosis di Indonesia telah berobat. Namun masih ada yang minum

obat secara tidak rutin sebesar 10,6% dalam 1 bulan terakhir. Sebanyak 25,4% penderita yang tidak rutin minum obat beralasan merasa sudah sehat, serta 27,5% penderita merasa bosan/malas/sering lupa. Terdapat masalah lain dimana pengidap skizofrenia/psikosis dipasung oleh keluarganya. Proporsi rumah tangga yang memiliki ART pengidap skizofrenia/psikosis yang pernah dipasung sebesar 6,6% (Kemenkes RI, 2024).

3. Klasifikasi

Menurut Putri (2020) menyatakan bahwa terdapat 7 tipe skizofrenia, antara lain:

a. Skizofrenia paranoid (F20.0)

Skizofrenia paranoid merupakan jenis skizofrenia yang paling umum terjadi, di mana beberapa gejala utamanya adalah delusi dan halusinasi terhadap ketakutan tertentu. Penderita kondisi ini sering kali memiliki kecurigaan berlebih pada orang-orang di sekitarnya sehingga sulit mengendalikan emosi atau keinginannya. Biasanya penderita sangat peka (sensitif), emosional dan mudah sekali cemas. Penderita juga kurang percaya diri dan kualitas hidupnya juga menurun, serta sering diserang penyakit depresi. Seseorang yang mengalami skizofrenia paranoid biasanya menunjukkan beberapa gejala seperti delusi, merasa dirinya lebih hebat dari kenyataan, halusinasi, rasa cemas, curiga, dan suka menyendiri, mengalami perasaan cemburu tidak realistis, mempunyai gangguan persepsi.

b. Skizofrenia hebefrenik (F20.1)

Memenuhi kriteria umum skizofrenia, diagnosis hebefrenik hanya ditegakkan pertama kali pada usia remaja atau dewasa muda (15-25 tahun), gejala bertahan sampai 2-3 minggu, afek dangkal dan tidak wajar, senyum sendiri, dan mengungkapkan sesuatu dengan di ulang-ulang.

c. Skizofrenia katatonik (F20.2)

Memenuhi kriteria umum skizofrenia, stupor (reaktifitas rendah dan tidak mau bicara, gaduh – gelisah (tampak aktifitas motorik yang tidak bertujuan untuk stimuli eksternal), rigiditas (kaku tubuh), diagnosis katatonik bisa tertunda apabila diagnosis skizofrenia belum tegak dikarenakan klien tidak komunikatif.

Skizofrenia katatonik, kekakuan motorik, atau kegembiraan katatonik adalah ciri khas skizofrenia jenis ini. Pasien tidak dapat berbicara, bereaksi atau bahkan bergerak. Dalam kasus lain, mereka menunjukkan kegembiraan atau mania yang kuat. Tanda-tanda kegembiraan katatonik termasuk menggelegak atau meronta-ronta. Selain itu, skizofrenia katatonik juga dapat

mencakup echolalia dan echopraxia. Hal ini disebabkan oleh karakteristik khusus dari gerakan tak sadar, seperti: postur tubuh yang aneh, meringis, atau gerakan stereotip (misal. gemetar, melambai, menggigit kuku).

d. Skizofrenia tak terinci (F20.3)

Memenuhi kriteria umum diagnosis skizofrenia, tidak memenuhi kriteria untuk diagnosis skizofrenia paranoid, hebefrenik, dan katatonik, tidak memenuhi diagnosis skizofrenia residual atau depresi pasca skizofrenia. Pada pasien ini didiagnosis sebagai skizofrenia tak terinci tidak didiagnosis sebagai skizofrenia paranoid karena waham dan halusinasi yang kurang merujuk pada diagnosis tersebut. Pasien tidak mengalami regresi dan juga tidak mengalami rigiditas serta posturing sehingga menyingkirkan skizofrenia hebefrenik dan katatonik.

e. Depresi pasca skizofrenia (*post-schizophrenic depression*) (F20.4)

Klien menderita skizofrenia 12 bulan terakhir, beberapa gejala skizofrenia masih tetap ada namun tidak mendominasi, gejala depresif menonjol dan mengganggu.

f. Skizofrenia residual (F20,5)

Gejala negatif menonjol (psikomotorik lambat, aktivitas turun, berbicara kacau), riwayat psikotik (halusinasi dan waham) dan tidak terdapat gangguan mental organik.

g. Skizofrenia simpleks F20.6)

Gejala negatif yang khas tanpa didahului riwayat halusinasi, waham, atau manifestasi lain dari episode psikotik, disertai dengan perubahan perilaku pribadi yang bermakna.

4. Etiologi

Menurut Videbeck (2016); Mawaddah, Sari, & Prasetya (2020), terdapat dua faktor utama yang berkontribusi terhadap munculnya skizofrenia, yaitu:

a. Faktor Prediposisi

1) Faktor Biologis

a) Faktor Genetik

Faktor genetik menjadi penyebab utama dalam perkembangan skizofrenia. Anak yang lahir dari orangtua penderita skizofrenia tetap memiliki risiko genetik terhadap gangguan ini, meskipun mereka dibesarkan dalam keluarga tanpa riwayat skizofrenia. Penelitian menunjukkan bahwa anak dengan salah satu orangtua penderita skizofrenia memiliki risiko 15% untuk mengalami gangguan serupa.

Risiko ini meningkat hingga 35% apabila kedua orangtua biologis menderita skizofrenia.

b) Faktor Neuroanatomi

Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan *skizofrenia* memiliki jumlah jaringan otak yang lebih sedikit, yang dapat mengindikasikan kegagalan perkembangan atau kehilangan jaringan pada tahap selanjutnya. Hasil *Computerized Tomography (CT Scan)* menunjukkan adanya pembesaran ventrikel otak serta atrofi pada korteks otak. Sementara itu, pemeriksaan *Positron Emission Tomography (PET)* mengungkapkan adanya penurunan kadar oksigen dan glukosa di korteks frontal otak. Secara konsisten, penelitian menunjukkan adanya penurunan volume otak serta gangguan fungsi di area temporal dan frontal pada pasien skizofrenia. Beberapa bagian otak yang menjadi fokus penelitian meliputi sistem limbik dan ganglia basalis.

Struktur otak penderita skizofrenia tampak berbeda dibandingkan individu normal, dengan ventrikel yang melebar, berkurangnya massa abu-abu, serta perubahan aktivitas metabolik di beberapa area. Pemeriksaan mikroskopis terhadap jaringan otak menunjukkan adanya perubahan kecil dalam distribusi sel otak yang terjadi sejak masa prenatal. Selain itu, tidak ditemukan keberadaan sel glia, yang biasanya muncul akibat trauma otak setelah kelahiran (Mashudi, 2021).

c) Faktor Neurokimia

Studi neurokimia secara konsisten menunjukkan adanya perubahan dalam sistem neurotransmitter pada otak penderita skizofrenia. Pada individu normal, mekanisme pengalihan sinyal di otak berfungsi dengan baik, memungkinkan sinyal persepsi yang diterima untuk dikirim kembali tanpa gangguan. Hal ini menghasilkan respons yang sesuai dalam bentuk perasaan, pemikiran, dan tindakan yang selaras dengan kebutuhan saat itu. Namun, pada otak penderita skizofrenia, terjadi gangguan dalam transmisi sinyal, menyebabkan sinyal yang dikirim tidak mencapai sambungan sel yang seharusnya.

2) Faktor Psikologis

Skizofrenia dapat terjadi akibat perkembangan psikososial yang tidak optimal sejak dini, misalnya ketika seorang anak gagal membangun hubungan yang didasari rasa percaya. Hal ini dapat menyebabkan konflik intrapsikis yang berlangsung sepanjang hidup. Pada kasus skizofrenia yang berat, individu mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai

permasalahan. Gangguan dalam membangun identitas, kesulitan dalam mengelola citra diri, serta ketidakmampuan dalam mengendalikan diri juga menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan dalam terapi.

3) Faktor Sosiokultural dan Lingkungan

Faktor sosiokultural dan lingkungan berkontribusi terhadap tingginya prevalensi akizofrenia pada individu dari kelas sosial ekonomi rendah dibandingkan mereka yang berasal dari kelas sosial ekonomi tinggi. Kondisi ini berkaitan dengan berbagai faktor, seperti kemiskinan, lingkungan perumahan yang padat, asupan nutrisi yang tidak mencukupi, kurangnya perawatan selama kehamilan, keterbatasan sumber daya untuk menghadapi stres, serta perasaan putus asa.

b. Faktor Presipitasi

Menurut Mashudi (2021) menyatakan bahwa faktor presipitasi skizofrenia, sebagai berikut:

1) Biologis

Stressor biologis yang berhubungan dengan respons neurobiologis yang maladaptif mencakup gangguan pada mekanisme umpan balik otak yang berperan dalam mengatur komunikasi serta pemrosesan informasi. Selain itu, terdapat kelainan pada sistem penerimaan rangsangan di otak, yang menyebabkan ketidakmampuan dalam merespons rangsangan secara selektif.

2) Lingkungan

Toleransi terhadap stres yang dipengaruhi oleh faktor biologis berinteraksi dengan stressor lingkungan, sehingga berperan dalam menentukan kemungkinan terjadinya gangguan pada proses berpikir (Mashudi 2021).

5. Patofisiologi

Skizofrenia merupakan penyakit dengan penyebab multifaktor. Patofisiologi skizofrenia belum diketahui secara pasti dan sangat bervariasi seperti halnya etiologi, terdapat beberapa hipotesis yang telah diajukan, antara lain: (Kemenkes RI, 2021)

a. Faktor genetik

Individu dengan keluarga penderita skizofrenia memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit skizofrenia. Pada anak dengan orang tua menderita skizofrenia berisiko 5% untuk mengalami penyakit serupa. Pada

individu dengan kembar dizigot yang mengalami skizofrenia beresiko 10% dan pada kembar monozigot resiko mengalami skizofrenia sebesar 40%.

b. Gangguan neurotransmitter

Pada hipotesis dopamin, ditemukan yaitu terdapat hiperaktivitas dopamin pusat. Peningkatan aktivitas dopamin di sistem limbik diasosiasikan dengan gejala positif. Antipsikotik yang bekerja sebagai antagonis reseptor dopamine pascasinaps (D2) diketahui efektif menangani gejala positif skizofrenia. Hipotesis serotonin mengatakan jika serotonin berlebih dapat menimbulkan gejala positif dan negatif. Neurotransmitter lain yang diduga terkait dengan patofisiologi skizofrenia yaitu asetilkolin, glutamat, norepinefrin, aminobutyric acid (GABA) dan sebagainya.

c. Gangguan Morfologi dan Fungsi Otak

Gangguan struktur dan fungsi otak yang sering ditemukan pada penderita skizofrenia adalah pelebaran ventrikel ke-3 dan lateral, atrofi lobus temporal dan medial, gangguan girus hipokampus, parahipokampus, dan amigdala. Namun tidak ada gangguan yang khas pada penderita skizofrenia.

6. Penatalaksanaan

Berdasarkan *American Psychiatric Association's Practice Guidelines for the Treatment of Patients with Schizophrenia* (2020), pengobatan harus dilakukan secara menyeluruh, menggunakan berbagai macam pendekatan, dan didasarkan pada bukti ilmiah. Cara penanganan skizofrenia melibatkan pengobatan dengan obat-obatan, terapi psikologis, rehabilitasi serta dapat dari dukungan masyarakat, guna untuk mengurangi risiko penyakit dan kematian, memperbaiki kondisi pasien, serta dapat membantu memperbaiki kualitas hidup.

Menurut Utami (2020) bahwa penatalaksanaan pada pasien skizofrenia, sebagai berikut:

a. Farmakologi

Menurut Ridwan (2023) bahwa antipsikotik yang dikenal sebagai neuroleptic, efektif dalam mengurangi gejala psikotik. Obat-obatan ini tidak dapat menyembuhkan *skizofrenia*, tetapi digunakan untuk mengatasi gejala-gejala tersebut, yaitu:

1) Antipsikotik generasi pertama

Antipsikotik generasi pertama adalah antipsikotik yang memblokir reseptor dopamin D2. Antipsikotik ini memblokir sekitar 65-80% reseptor D2 di striatum dan saluran dopamin lainnya di otak.

2) Antipsikotik generasi kedua

Antipsikotik generasi kedua ini, seperti risperidone, olanzapine, quetiapine, lurasidone, dan clozapine, memiliki afinitas yang lebih besar terhadap reseptor serotonin daripada reseptor dopamin. Sebagian besar antipsikotik generasi kedua menimbulkan efek samping berupa penambahan berat badan dan metabolisme lipid.

Farmakoterapi, baik antipsikotik oral, merupakan terapi andalan dalam penatalaksanaan skizofrenia. Ini direkomendasikan untuk pasien dengan kepatuhan rendah. Pasien yang beralih dari antipsikotik oral (aripiprazole, olanzapine, quetiapine, risperidone, dan paliperidone extended-release) ke paliperidone sekali selama 1 bulan menunjukkan respon dan tolerabilitas yang baik. Ini memberikan efek terapeutik yang lama dengan memaksimalkan pemberian obat, kontak obat dan jadwal pengobatan

b. Rehabilitasi Psikososial

1) Terapi kognitif

Terapi kognitif sangat meningkatkan fungsi sosial dan memperbaiki beberapa gejala, seperti delusi dan halusinasi. Terapi kognitif lebih aman dan efektif bila diberikan kepada penderita skizofrenia yang tidak mau minum antipsikotik.

2) Sosial Skill Training (SST)

Menunjukkan bahwa SST memiliki potensi untuk meningkatkan fungsi kognitif melalui pengalaman belajar yang meningkatkan memori dan perhatian yang memengaruhi kehidupan sosial. Jurnal penelitian juga menyebutkan bahwa SST meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pasien skizofrenia.

C. Konsep Dasar Halusinasi

1. Pengertian

Halusinasi adalah distorsi persepsi palsu yang terjadi pada respons biologis maladaptif. Klien sebenarnya mengalami distorsi sensorik sebagai hal yang nyata dan meresponnya. Pada halusinasi, tidak ada stimulus eksternal atau internal yang diidentifikasi (Stuart, 2016).

Halusinasi adalah persepsi seperti pengalaman yang terjadi tanpa stimulus eksternal. Mereka terang dan jelas, dengan kekuatan penuh dan mempengaruhi persepsi normal, dan tidak berada di bawah kendali. Mereka mungkin terjadi dalam sensor modalitas apapun, tapi halusinasi pendengaran adalah yang paling umum terjadi pada skizofrenia dan gangguan terkait. Halusinasi pendengaran adalah biasanya ditandai sebagai suara, apakah akrab atau asing, dan dirasakan berbeda dari pikiran individu sendiri. Halusinasi terjadi di

konteks sensorium yang jelas; itu terjadi pada jatuh tertidur (*hipnagogik*) atau bangun (*hypnopompic*) adalah dianggap dalam pengalaman normal (Llorca et.al., 2016).

2. Tahapan Halusinasi

Menurut tahapan terjadinya halusinasi pada individu yang mengalaminya, sebagai berikut: (Fahrizal & Saputri, 2023)

a. Tahap 1

Disebut juga dengan fase *comforting* yaitu fase yang menyenangkan. Pada tahap ini masuk dalam golongan non psikotik. Menenangkan, ansietas tingkat sedang. Secara umum menyenangkan. Karakteristik : Merasa bersalah dan takut serta mencoba memusatkan pada penenangan pikiran untuk mengurangi ansietas. Individu mengetahui bahwa pikiran dan sensori yang dialaminya dapat dikendalikan dan bisa diatasi (non psikotik). Klien mengalami stress, cemas, perasaan perpisahan, rasa bersalah, kesepian yang memuncak, dan tidak dapat diselesaikan. Klien mulai melamun dan memikirkan hal - hal yang menyenangkan.

Perilaku yang teramati : Menyeringai / tertawa yang tidak sesuai, Menggerakkan bibirnya tanpa menimbulkan suara, respon verbal yang lambat, diam dan dipenuhi oleh sesuatu yang mengasikan .

b. Tahap II

Disebut dengan fase *condemning* atau ansietas berat yaitu halusinasi menjadi menjijikkan, termasuk dalam psikotik ringan. Menyalahkan, ansietas tingkat berat. Halusinasi menjijikkan. Karakteristik : pengalaman sensori bersifat menjijikkan dan menakutkan, orang yang berhalusinasi mulai merasa kehilangan kendali mungkin berusaha untuk menjauhkan dirinya dari sumber yang dipersepsikan, individu mungkin merasa malu karena pengalaman sensorinya dan menarik diri dari orang lain (non psikotik). Mulai dirasakan ada bisikan yang tidak jelas. Klien tidak ingin orang lain tahu dan dia tetap dapat mengontrolnya.

Perilaku klien yang teramati: peningkatan sistem syaraf otonom yang menunjukkan ansietas, misalnya peningkatan nadi, tekanan darah dan pernafasan, penyempitan kemampuan konsentrasi, dipenuhi dengan pengalaman sensori mungkin kehilangan kemampuan untuk membedakan antara halusinasi dan realita.

c. Tahap III

Adalah fase *controlling* atau ansietas berat yaitu pengalaman sensori menjadi berkuasa. Termasuk dalam gangguan psikotik. Pengendalian,

ansietas tingkat berat. Pengalaman sensori menjadi penguasa. Karakteristik : Orang yang berhalusinasi menyerah untuk melawan pengalaman halusinasi dan membiarkan halusinasi menguasai dirinya. Isi halusinasi dapat berupa permohonan, individu mungkin mengalami kesepian jika pengalaman tersebut berakhir (psikotik).

Perilaku klien yang teramati: lebih cenderung mengikuti petunjuk yang diberikan oleh halusinasinya dari pada menolak, kesulitan berhubungan dengan orang lain, rentang perhatian hanya beberapa menit atau detik, gejala fisik dari ansietas berat seperti: berkeringat, tremor, ketidak mampuan mengikuti petunjuk .

d. Tahap IV

fase conquering atau panik klien lebur dengan halusinasinya. Termasuk dalam psikotik berat. Menakutkan, ansietas tingkat panik. Secara umum halusinasi menjadi lebih rumit dan saling terkait dengan delusi. Karakteristik : pengalaman sensori mungkin menakutkan jika individu tidak mengikuti perintah, halusinasi bisa berlangsung dalam beberapa jam atau hari apabila tidak diintervensi terapeutik (psikotik). Halusinasinya berubah menjadi mengancam, memerintah, dan memarahi klien. Klien menjadi takut tidak berdaya, hilang kontrol, dan tidak dapat berhubungan secara nyata dengan orang lain di lingkungan

Perilaku yang teramati : Perilaku menyerang-teror seperti panik, aangat potensial melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain, Kegiatan fisik yang merefleksikan isi halusinasi seperti : amuk, agitasi, menarik diri, tidak mampu berespon terhadap petunjuk yang kompleks, tidak mampu berespon terhadap lebih dari satu orang.

3. Faktor Predisposisi dan Presipitasi

a. Biologis

Riwayat masuk RS sebelumnya, berapa kali dirawat, riwayat pengobatan sebelumnya, riwayat minum obat, teratur atau tidak minum obat, kapan terakhir minum obat, riwayat kejang, jatuh/trauma, riwayat penggunaan NAPZA/penggunaan obat halusinogen, riwayat anggota keluarga dengan gangguan jiwa, diturunkan melalui kromosom orang tua, lesi pada daerah frontal, temporal dan limbic, neurotransmitter dopamine berlebihan, tidak seimbang dengan kadar serotonin;adanya riwayat gangguan nutrisi ditandai dengan penurunan berat badan, rambut rontok, anoreksia, bulimia nervosa dan kelemahan

b. Sosio kultural

Riwayat pendidikan, riwayat putus sekolah dan gagal sekolah, riwayat pekerjaan, kecukupan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan, siapa yang menanggung biaya hidup selama dirawat, tinggal dengan siapa, berapa saudara, siapa orang yang paling berarti, apakah pernah mengalami kehilangan orang yang dicintai, perceraian, kehilangan harta benda, penolakan dari masyarakat, riwayat tugas perkembangan yang tidak sesuai; riwayat ketidakjelasan identitas; riwayat kegagalan peran gender; pendidikan yang rendah; penghasilan rendah; pekerjaan stressfull; pekerjaan beresiko tinggi.

c. Psikologis

Perasaan klien setelah perawatan, komentar negatif orang-orang di sekitarnya, peran yang terganggu akibat dirawat, pengalaman tidak menyenangkan, kepribadian klien misalnya mudah kecewa, kecemasan tinggi, mudah putus asa dan menutup diri, konsep diri : adanya riwayat ideal diri yang tidak realistis, identitas diri tak jelas, harga diri rendah, krisis peran dan gambaran diri negative. Motivasi: riwayat kurangnya penghargaan dan riwayat kegagalan. Pertahanan psikologi: ambang toleransi terhadap stres rendah dan adanya riwayat gangguan perkembangan. Self control: adanya riwayat tidak bisa mengontrol stimulus yang datang, misalnya suara, rabaan, penglihatan, penciuman, pengecap; riwayat tinggal di lingkungan yang dapat mempengaruhi moral individu misal di lingkungan *broken home*, konflik dan lapas.

d. Respons

1) Respons Kognitif

Tidak dapat memfokuskan pikiran, mudah lupa, tidak mampu mengambil keputusan, tidak mampu memecahkan masalah, tidak dapat berfikir logis, inkoheren, disorientasi, blocking, daya tilik diri jelek, mendengar suara-suara, melihat bayangan atau sinar, mendengar suara hati, menghidu bau-bauan, merasakan rasa pahit, asam, asin di lidah, merasakan sensasi tidak nyaman dikulit, ambivalen, sirkumstansial, *flight of idea*, tidak mampu mengontrol perilaku kekerasan, punya pikiran negatif terhadap stressor, mendominasi pembicaraan

2) Respons Afektif

Senang, sedih, merasa terganggu, marah, ketakutan, khawatir, merasa terbelenggu, afek datar/ tumpul, afek labil, marah, kecewa, kesal, curiga, mudah tersinggung

3) Respons Fisiologis

Sulit tidur, kewaspadaan meningkat, tekanan darah meningkat, denyut nadi meningkat, frekuensi pernafasan meningkat, muka tegang, keringat dingin, pusing, kelelahan/keletihan.

4) Respons Perilaku

Berbicara dan tertawa sendiri, Berperilaku aneh sesuai dengan isi halusinasi, menggerakkan bibir/komat kamit, menyeringai, diam sambil menikmati halusinasinya, perilaku menyerang, kurang mampu merawat diri, memalingkan muka ke arah suara, menarik diri

5) Respons Sosial

Tidak tertarik dengan kegiatan sehari-hari, tidak mampu komunikasi secara spontan, acuh terhadap lingkungan, tidak dapat memulai pembicaraan, tidak dapat mempertahankan kontak mata, menarik diri

4. Sumber Koping dan Mekanisme Koping

a. Sumber Koping

Sumber koping merupakan suatu evaluasi terhadap pilihan koping dan strategi seseorang, individu dapat mengatasi stress dan ansietas dengan menggunakan sumber koping yang ada di lingkungannya. Sumber koping tersebut dijadikan sebagai model untuk menyelesaikan masalah. Dukungan sosial dan keyakinan budaya dapat membantu seseorang mengintegrasikan pengalaman yang menimbulkan stress dan mengadopsi strategi koping yang efektif (Yosep, 2018).

1) *Personal ability*

Kemampuan apa yang sudah dilakukan, kemampuan yang sudah dilatih. Kemampuan yang seharusnya dimiliki klien :

- Menghardik halusinasi
- Minum obat
- Bercakap-cakap
- Melakukan aktivitas terjadwal

2) *Social support*

Caregiver klien, kemampuan *caregiver* / keluarga dalam merawat, kelompok/*peer group* dengan penyakit yang sama, kader kesehatan jiwa di lingkungan tempat tinggal.

3) *Material asset* (finansial)

Pekerjaan klien sebelum dirawat, penghasilan sebelum dirawat, siapa yang menanggung biaya berobat klien, apakah memiliki tabungan, jaminan kesehatan yang digunakan

4) Fasilitas kesehatan

Jika kontrol/kambuh berobat kemana, fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat dengan tempat tinggal.

5) *Positif belief*

Keyakinan terhadap kesembuhan diri sendiri dan keyakinan terhadap petugas kesehatan

b. Mekanisme Koping

Mekanisme koping merupakan tiap upaya yang diarahkan pada pengendalian stress, termasuk upaya penyelesaian masalah secara langsung dan mekanisme pertahanan lain yang digunakan untuk melindungi diri (Rochmah, 2018). Pasien dengan halusinasi biasanya mengungkapkan masalah dengan: regresi, proyeksi, denial, withdrawal.

D. Tanda dan Gejala Halusinasi

Menurut Azizah et.al., (2016) tanda dan gejala halusinasi penting perlu diketahui oleh perawat agar dapat menetapkan masalah halusinasi, antara lain:

1. Berbicara, tertawa dan tersenyum sendiri
2. Bersikap seperti mendengarkan sesuatu
3. Berhenti berbicara sesaat ditengah-tengah kalimat untuk mendengarkan sesuatu.
4. Disorientasi
5. Tidak mampu atau kurang konsentrasi
6. Cepat berubah pikiran
7. Alur pikir kacau
8. Respon yang tidak sesuai
9. Menarik diri
10. Suka marah dengan tiba-tiba dan menyerang orang lain tanpa sebab
11. Sering melamun

E. Jenis Halusinasi

Menurut Prabowo (2017), bahwa gangguan halusinasi terdiri atas beberapa jenis, antara lain:

1. Halusinasi pendengaran (akustik, audiotorik)

Gangguan stimulus dimana pasien mendengar suara - suara orang, biasanya pasien mendengar suara orang yang sedang membicarakan apa yang sedang dipikirkannya dan memerintahkan untuk melakukan sesuatu.

2. Halusinasi penglihatan (visual)

Stimulus visual dalam bentuk beragam seperti bentuk pancaran cahaya, gambaran geometrik, gambar kartun dan atau panorama yang luas dan kompleks. Bayangan bisa menyenangkan atau menakutkan.

3. Halusinasi penghidu (Olfaktori)

Gangguan stimulus pada penghidu, yang ditandai dengan adanya bau busuk, amis, dan bau yang menjijikkan seperti : darah, urine, atau feses. Kadang – kadang terhidu bau harum. Biasanya berhubungan dengan stroke, tumor, kejang dan demensia.

4. Halusinasi peraba (Taktil, Kinestetik)

Gangguan stimulus yang ditandai dengan adanya rasa sakit atau tidak enak tanpa stimulus yang terlihat. Contoh : merasakan sensasi listrik datang dari tanah, benda mati atau orang lain.

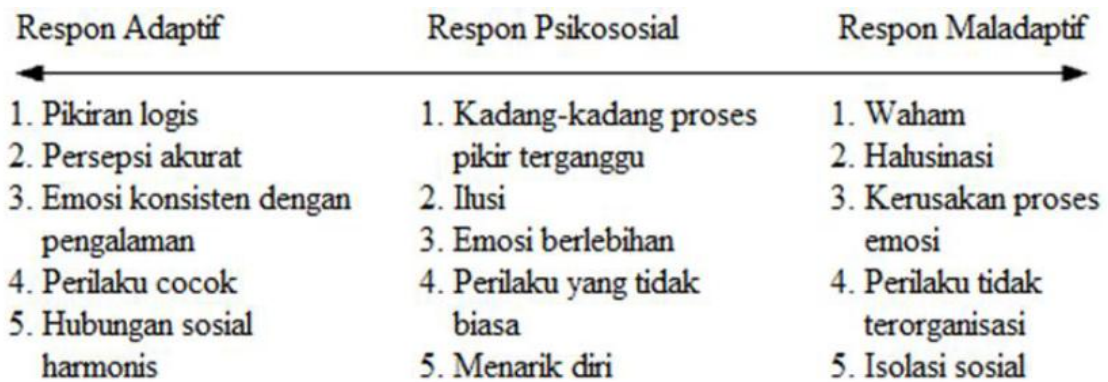
5. Halusinasi pengecap (Gustatorik)

Gangguan stimulus yang ditandai dengan merasakan sesuatu yang busuk, amis, dan menjijikkan.

6. Halusinasi kinestetik

Gangguan stimulus yang ditandai dengan merasakan fungsi tubuh seperti darah mengalir melalui vena atau arteri, makanan dicerna, pembentukan urine.

F. Rentang Respon



Gambar 1.1: Rentang Respon

Sumber: Yusuf (2015)

Keterangan:

1. Respon adaptif

Respon adaptif adalah respon yang dapat diterima norma-norma sosial budaya yang berlaku.

- Pikiran logis adalah pandangan yang mengarah pada kenyataan.
- Persepsi akurat adalah pandangan yang tepat pada kenyataan.
- Emosi konsisten dengan pengalaman yaitu perasaan yang timbul dari pengalaman asli.
- Perilaku sosial adalah sikap dan tingkah laku yang masih dalam batas kewajaran.
- Hubungan sosial adalah proses suatu interaksi dengan orang lain dan lingkungan.

2. Respon psikososial

Respon psikososial meliputi:

- Proses pikir terganggu adalah proses pikir yang menimbulkan gangguan
- Ilusi adalah miss interpretasi yang salah penerapan yang benar-benar terjadi (objek nyata) karena rangsangan panca indera.
- Emosi berlebihan atau berkurang.
- Perilaku tidak biasa adalah sikap dan tingkah laku yang melebihi batas kewajaran.
- Menarik diri adalah percobaan untuk menghindari interaksi dengan orang lain.

3. Respon maladaptif

Respon maladaptif adalah respon individu dalam menyelesaikan masalah yang menyimpang dari norma-norma sosial budaya dan lingkungan, adapun respon maladaptif meliputi:

- a. Kelainan pikiran adalah keyakinan yang secara kokoh dipertahankan walaupun tidak diyakini oleh orang lain dan bertentangan dengan kenyataan sosial. Halusinasi merupakan persepsi sensoru yang salah atau persepsu eksternal yang tidak realita atau tidak ada.
- b. Kerusakan proses emosi adalah perubahan sesuatu yang timbul dari hati.
- c. Perilaku tidak teroganisir merupakan suatu yang tidak teratur.
- d. Isolasi sosial adalah kondisi kesendirian yang dialami oleh individu dan diterima sebagai ketentuan oleh orang lain dan sebagai suatu kecelakaan yang negatif mengancam.

G. Penatalaksanaan Halusinasi

Penatalaksanaan pada pasien halusinasi, sebagai berikut: (Ridwan, 2023)

1. Psikofarmakoterapi

Gejala halusinasi sebagai salah satu gejala psikotik/skizofrenia biasanya diatasi dengan menggunakan obat-obatan anti psikotik, antara lain:

- a. Golongan butirefenon: Haldol, serenace, ludomer.
- b. Golongan fenotiazine: chlorpromazine/largactile/promactile

2. Psikoterapi

Psikoterapi suportif individual atau kelompok sangat karena berhubungan dengan praktis dengan maksud mempersiapkan pasien kembali ke masyarakat, selain itu terapi kerja sangat baik untuk mendorong pasien bergaul dengan orang lain, pasien lain, perawata dan dokter. Supaya pasien tidak mengasingkan diri karena dapat membentuk kebiasaan yang kurang baik, dianjurkan untuk mengadakan permainan atau latihan bersama, antara lain:

- a. Terapi aktivitas
 - Terapi musik
 - Terapi seni
 - Terapi menari
 - Terapi relaksasi
- b. Terapi sosial
- c. Terapi Kelompok
 - Terapi group (terapi kelompok terapeutik)
 - Terapi lingkungan

3. Terapi kejang listrik/ *Electroconvulsive therapy (ECT)*

Terapi kejang listrik adalah pengobatan untuk menimbulkan kejang grandmall secara artificial dengan melewati aliran listrik melalui electrode yang dipasang pada satu atau dua temples. Terapi kejang listrik diberikan pada

skizofrenia yang tidak mempan dengan terapi neurolapitika oral atau injeksi, dosis terapi kejangan listrik 4 - 5 joule per detik (Prabowo, 2017)

4. Terapi aktivitas kelompok

a. Terapi aktivitas kelompok stimulasi kognitif/persepsi

Pasien dilatih mempresepsikan stimulus yang pernah dialami. Kemampuan persepsi pasien harus dievaluasi dan ditingkatkan pada tiap sesi, stimulus yang disediakan: baca artikel/majalah/buku/puisi, menonton acara tv.

b. Terapi aktivitas kelompok sensori

Aktivitas digunakan sebagai stimulus pada sensori pasien. Kemudian di observasi reaksi sensori pasien terhadap stimulus yang disediakan, berupa ekspresi perasaan secara nonverbal (ekspresi wajah, gerakan tubuh).

5. Rehabilitasi

Terapi kerja baik untuk mendorong penderita bergaul dengan orang lain, penderita lain, perawat dan dokter.

H. Rencana Tindakan Keperawatan

1. Pasien

a. Generalis : SP 1-4 Halusinasi dan TAK

Tindakan keperawatan yang dapat diberikan pada pasien dengan Halusinasi dapat berupa tindakan generalis dan juga tindakan spesialis. Terapi generalis individu yaitu strategi pelaksanaan 1 sampai 4 yaitu menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan melakukan aktivitas terjadwal. Terapi generalis kelompok yaitu dengan Terapi Aktifitas kelompok (TAK) stimulasi persepsi.

Hasil penelitian Nur Halimatus Sa'diyah, Anik Yulianti, Eddi Sudjarwo (2013) menyatakan bahwa ada pengaruh terapi aktivitas individu menghardik terhadap kemampuan mengontrol halusinasi pendengaran. Menurut Stuart (2016) intervensi yang diberikan pada pasien halusinasi bertujuan menolong mereka meningkatkan kesadaran tentang gejala yang mereka alami dan mereka bisa membedakan halusinasi dengan dunia nyata dan mampu mengendalikan atau mengontrol halusinasi yang dialami.

b. Terapi Spesialis

Salah satu terapi spesialis yaitu CBT. Terapi perilaku kognitif (CBT) merupakan salah satu bentuk psikoterapi yang mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Pikiran negatif muncul disebabkan oleh adanya pengalaman yang tidak menyenangkan yang terjadi pada klien. Pengalaman berupa ancaman yang terjadi pada diri seseorang dapat menyebabkan hilangnya kemampuan memproses informasi secara efektif dikenal dengan

distorsi kognitif (Keliat et.al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Nyumirah (2013) menyatakan bahwa klien yang mendapat terapi generalis dan terapi perilaku mengalami peningkatan kemampuan klien dalam melakukan perilaku positif ketika halusinasi muncul.

2. Kelompok

Kemampuan pasien mengontrol halusinasi dapat ditingkatkan dengan pemberian asuhan keperawatan yang komprehensif dan terus menerus disertai dengan terapi modalitas seperti Terapi Aktivitas Kelompok. Menurut Purwaningsih dan Karlina (2010) Terapi Aktivitas Kelompok memberikan hasil yang lebih besar terhadap perubahan perilaku pasien, meningkatkan perilaku adaptif serta mengurangi perilaku maladaptif.

Terapi aktivitas kelompok (TAK) bertujuan memberikan fungsi terapi bagi anggotanya, yang setiap anggota berkesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik terhadap anggota yang lain, mencoba cara baru untuk meningkatkan respons sosial, serta harga diri. Keuntungan lain yang diperoleh anggota kelompok yaitu adanya dukungan pendidikan, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan meningkatkan hubungan interpersonal (Yusuf, 2015). Didalam kelompok terjadi dinamika dimana setiap anggota kelompok saling bertukar informasi dan berdiskusi tentang Pengalaman serta membuat kesepakatan untuk mengatasi masalah anggota kelompok. TAK stimulasi persepsi juga bertujuan untuk mendiskusikan pengalaman dan kehidupan dan hasil diskusi berupa kesepakatan persepsi dan alternatif penyelesaian masalah. Terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi dapat menurunkan tingkat halusinasi pasien dan meningkatkan kemampuan pasien mengontrol halusinasi.

I. Simpulan

Skizofrenia dapat menyebabkan gangguan fungsi pada individu, dimana terjadi gangguan berpikir, berkomunikasi, menerima, menafsirkan kenyataan, merasakan, dan menunjukkan emosi yang ditandai dengan pikiran kacau, delusi, halusinasi, dan perilaku maladaptif. Skizofrenia terbagi dalam berbagai jenis dengan penyebab yang dapat berasal dari faktor predisposisi dan presipitasi. Skizofrenia dapat ditangani dengan memberikan terapi farmakoterapi dan rehabilitasi psikososial.

Pasien halusinasi mengalami distorsi sensorik sebagai hal yang nyata dan meresponnya. Pada halusinasi, tidak ada stimulus eksternal atau internal yang diidentifikasi. Halusinasi dapat disebabkan karena adanya gangguan fakto biologis,

psikologis dan sosiokultural. Halusinasi dapat diberikan rencana tindakan keperawatan dengan melakukan terapi keperawatan generalis dan spesialis.

J. Referensi

- American Psychiatric Association Guideline. (2020). The American Psychiatric Association Practice Guideline for The Treatment of Patients with Schizophrenia. Washington : American Psychiatric Publishing
- Azizah et.al., (2016). Aplikasi asuhan keperawatan generalis dan psikoreligius pada klien gangguan sensori persepsi: Halusinasi pendengaran. *Jurnal Riset Kesehatan Nasional*, volume 2 No.2, pp. 1–9. <https://doi.org/10.37294/jrkn.v2i2.106>
- Doenges, M.E, Townsend, M.C dan Moorhouse, M.F. (2007). *Rencana asuhan keperawatan psikiatri*. Edisi 3. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Famela, F., Kusumawaty, I., Martini, S., & Yunike, Y. (2022). Implementasi keperawatan teknik bercakap-cakap pada pasien halusinasi pendengaran. *Jurnal 'Aisyiyah Medika*, volume 7, No.2, pp. 205–214. <https://doi.org/10.36729/jam.v7i2.869>
- Fahrizal, Y., & Saputri, R. N. (2023). Effect of psycho-religious group therapy on hallucination in schizophrenia patient. *Medisains*, volume 21 No.1, pp.13. <https://doi.org/10.30595/medisains.v21i1.16982>
- Keliat, B.A dan Akemat. (2010). *Model praktik keperawatan profesional jiwa*. Cetakan I. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Keliat, B. A., Kep, H. S. M., Achir, P., Hamid, Y. S., Kep, F. M., Daulima, N. H. C., ... Keliat, B. A. (2019). *Asuhan keperawatan jiwa*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Kemenkes RI. (2024). *Survei kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI
- Mashudi. (2021). *Buku ajar asuhan keperawatan skizofrenia*. Surabaya : Penerbit Global Aksara Pres
- Mawaddah, N., Sari, I. P., & Prasetya, A. (2020). Faktor predisposisi dan presipitasi terjadinya gangguan jiwa di Desa Sumbertebu Bangsal Mojokerto, Hospital Majapahit. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto*, volume 12 No. 2, pp. 116–123.
- NANDA, (2011). *Diagnosa keperawatan definisi dan klasifikasi 2009-2011*. Cetakan 2011. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Llorca, P. M., Pereira, B., Jardri, R., Chereau-Boudet, I., Brousse, G., Misdrahi, D., ... De Chazeron, I. (2016). Hallucinations in schizophrenia and parkinson's disease: An analysis of sensory modalities involved and the repercussion on

- patients. *Scientific Reports*, 6 (December), 1–10. <https://doi.org/10.1038/srep38152>
- Patimah. (2021). Aplikasi terapi bercakap - cakap pada Tn. N dengan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran di Jampang Kulon. *Jurnal Lentera*, volume 4, No.1, pp. 6–10. <https://doi.org/10.37150/jl.v4i1.1382>
- Pardede, (2020). Decreasing symptoms of risk of violent behavior in schizophrenia patient through group activity therapy. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 3(3), 291-300. <https://doi.org/10.26714/jkj.8.3.2020.223-234>
- Prabowo, E. (2017). Konsep & aplikasi asuhan keperawatan jiwa. Yogyakarta : Nuha Medika
- Putri, V. S. (2020). Pengaruh terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi halusinasi terhadap kemampuan mengontrol halusinasi pada pasien skizofrenia di ruang rawat Inap Arjuna Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. *Riset Informasi Kesehatan*, volume 6 No. 2, pp. 174. <https://doi.org/10.30644/rik.v6i2.95>
- Ridwan. (2023). *Intervensi generalis pada halusinasi*. Bandung : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
- Sihombing. (2019). *Gambaran pengetahuan pasien skizofrenia tentang cara mengontrol halusinasi pendengaran di RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Medan tahun 2019*. 1–11.
- Stuart, W. G. (2016). Keperawatan Kesehatan jiwa. Indonesia: Elsevier
- Utami. (2020). Penerapan strategi pelaksanaan (SP) 1-4 dengan masalah halusinasi pada penderita skizofrenia : Studi kasus. *Jurnal Ners Indonesia*, volume 8 No.1, pp. 79–88.
- Videbeck. (2016). *Buku Ajar keperawatan jiwa*. Jakarta: Penerbit Buku EGC.
- WHO. (2022). WHO. (2019). *Mental disorders*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>
- Widyaningrum & Wulandari. (2019). Edukasi kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan keluarga dalam merawat pasien halusinasi. *Jurnal Keperawatan*, volume 12, No.2, pp. 7–13. <https://e-journal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/45>
- Yanti, et.al., (2020). Efektivitas terapi musik klasik terhadap penurunan tingkat halusinasi pada pasien halusinasi pendengaran di Rumah Sakit Prof. Dr. M. Ilderm Medan tahun 2020. *Jurnal Keperawatan Dan Fisioterapi (JKF)*, volume 3, No.1, pp. 125-131, <https://doi.org/10.35451/jkf.v3il.527>.
- Yosep, I. (2018). *Buku ajar keperawatan jiwa* (Edisi Revi). Bandung : PT. Refika Aditama
- Yusuf, AH., (2015). *Buku Ajar keperawatan kesehatan jiwa*. Jakarta: Salemba Medika

Zaman, et.al., (2024). Upaya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pentingnya Kesehatan Jiwa. *Beujroh : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Pada Masyarakat*, volume 2, No.2, pp. 355–364. <https://doi.org/10.61579/beujroh.v2i2.185>

K. Glosarium

TAK	= Terapi Aktivitas Kelompok
ECT	= <i>Electrocompulsive therapy</i>
SST	= <i>Social Skill Training</i>
ART	= Anggota Rumah Tangga
WHO	= World Health Organization
ODGJ	= Orang Dengan Gangguan Jiwa
ODS	= Orang Dengan Skizofrenia

CHAPTER 2

PENGKAJIAN KEPERAWATAN JIWA PADA PASIEN DENGAN HALUSINASI

□ Ns. Reta Renylda, M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Pengkajian keperawatan jiwa pada pasien dengan halusinasi merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses pemberian asuhan keperawatan. Hal ini disebabkan karena halusinasi bukan hanya sekadar keluhan subjektif yang dialami pasien, tetapi juga merupakan kondisi yang dapat memengaruhi cara pasien berpikir, merasakan, berperilaku, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam praktik keperawatan jiwa, pengkajian yang tepat menjadi dasar bagi perawat untuk memahami kondisi pasien secara menyeluruh, mulai dari jenis halusinasi yang dialami, isi halusinasi, waktu kemunculan, frekuensi, faktor pencetus, hingga respons pasien terhadap halusinasi tersebut. Tanpa pengkajian yang komprehensif, perawat akan mengalami kesulitan dalam menentukan masalah keperawatan, menyusun rencana intervensi, serta mengevaluasi keberhasilan tindakan yang telah diberikan.

Halusinasi termasuk salah satu bentuk gangguan persepsi sensori yang sering ditemukan pada pasien dengan gangguan jiwa. Gangguan persepsi sensori terjadi ketika seseorang mengalami perubahan dalam menerima, menafsirkan, atau merespons rangsangan dari lingkungan. Pada pasien dengan halusinasi, persepsi yang muncul tidak berasal dari stimulus nyata, tetapi dirasakan seolah-olah benar-benar terjadi. Misalnya, pasien mendengar suara yang memanggil, menyuruh, mengancam, atau mengomentari dirinya, padahal suara tersebut tidak terdengar oleh orang lain. Selain halusinasi pendengaran, pasien juga dapat mengalami halusinasi penglihatan, penciuman, pengecapan, atau perabaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa halusinasi bukan hanya gangguan pada satu aspek sensori, tetapi dapat melibatkan berbagai bentuk pengalaman persepsi yang memengaruhi kenyataan subjektif pasien.

Pentingnya pengkajian pada pasien dengan halusinasi juga berkaitan dengan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap perilaku pasien. Pasien yang mengalami halusinasi dapat menunjukkan perilaku berbicara sendiri, tertawa tanpa sebab yang jelas, tampak mendengarkan sesuatu, menutup telinga, menoleh ke arah tertentu,

gelisah, mondar-mandir, atau bahkan mengikuti perintah dari halusinasinya. Apabila isi halusinasi bersifat mengancam atau memerintah, pasien dapat terdorong melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, pengkajian tidak hanya bertujuan untuk mengetahui keberadaan halusinasi, tetapi juga untuk menilai tingkat risiko yang mungkin muncul akibat pengalaman halusinasi tersebut. Perawat perlu mengidentifikasi apakah halusinasi yang dialami pasien bersifat netral, menakutkan, mengganggu, atau memerintah pasien untuk melakukan tindakan tertentu.

Selain berdampak pada perilaku, halusinasi juga dapat memengaruhi kondisi emosional pasien. Pasien yang mengalami halusinasi sering kali merasa takut, cemas, bingung, marah, malu, atau tidak berdaya. Perasaan tersebut dapat muncul karena pasien tidak mampu membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman halusinatif. Pada sebagian pasien, halusinasi dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berat karena suara atau bayangan yang muncul dianggap mengancam keselamatan dirinya. Dalam kondisi tertentu, pasien mungkin merasa dikendalikan oleh halusinasinya sehingga kehilangan kemampuan untuk mengontrol pikiran dan tindakannya. Oleh sebab itu, dalam pengkajian, perawat perlu menggali bagaimana perasaan pasien ketika halusinasi muncul, apakah pasien merasa takut, terganggu, marah, atau justru merasa nyaman dengan halusinasi tersebut.

Halusinasi juga memberikan dampak yang besar terhadap hubungan sosial pasien. Pasien yang sering mengalami halusinasi cenderung menarik diri dari lingkungan, mengurangi komunikasi dengan keluarga, menghindari interaksi sosial, dan lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena pasien lebih fokus pada stimulus internal yang dialaminya daripada pada lingkungan nyata di sekitarnya. Selain itu, perilaku pasien yang tampak berbicara sendiri atau menunjukkan respons yang tidak sesuai sering kali menimbulkan kesalahpahaman, stigma, atau penolakan dari keluarga dan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat memperburuk isolasi sosial, menurunkan harga diri pasien, dan menghambat proses pemulihan. Oleh karena itu, pengkajian keperawatan jiwa perlu mencakup aspek hubungan sosial, dukungan keluarga, kemampuan komunikasi, serta penerimaan lingkungan terhadap kondisi pasien.

Keselamatan pasien menjadi salah satu alasan utama mengapa pengkajian pada pasien dengan halusinasi harus dilakukan secara cermat dan berkelanjutan. Halusinasi yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko perilaku kekerasan, mencederai diri sendiri, mencederai orang lain, ketidakpatuhan minum obat, hingga kekambuhan berulang. Risiko ini semakin tinggi apabila pasien mengalami halusinasi perintah, yaitu halusinasi yang menyuruh pasien melakukan tindakan

tertentu. Dalam situasi seperti ini, perawat harus mampu menilai tingkat bahaya melalui pengkajian yang terarah, misalnya dengan menanyakan isi suara yang didengar, seberapa sering suara tersebut muncul, apakah pasien percaya pada suara itu, serta apakah pasien pernah mengikuti perintah dari halusinasi tersebut. Informasi ini sangat penting untuk menentukan tindakan pengamanan dan intervensi keperawatan yang sesuai.

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam mengenali tanda dan gejala halusinasi sejak dini. Sebagai tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dan terus-menerus dengan pasien, perawat berada pada posisi strategis untuk mengamati perubahan perilaku, ekspresi emosi, pola komunikasi, dan kemampuan pasien dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Perawat tidak hanya mengandalkan informasi yang disampaikan pasien, tetapi juga melakukan observasi terhadap tanda objektif yang muncul selama proses perawatan. Misalnya, pasien tampak tersenyum sendiri, berbicara tanpa lawan bicara, tampak ketakutan, sulit berkonsentrasi, atau tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas. Dengan kemampuan observasi dan komunikasi terapeutik yang baik, perawat dapat membantu pasien mengungkapkan pengalaman halusinasinya secara lebih terbuka.

Dalam melakukan pengkajian, perawat perlu membangun hubungan saling percaya terlebih dahulu agar pasien merasa aman untuk menceritakan pengalamannya. Pasien dengan halusinasi sering kali merasa takut dianggap aneh, disalahkan, atau tidak dipercaya oleh orang lain. Oleh karena itu, perawat harus menggunakan pendekatan yang empatik, tenang, tidak menghakimi, dan menghargai pengalaman subjektif pasien. Perawat tidak perlu membenarkan isi halusinasi, tetapi juga tidak boleh langsung membantah secara keras pengalaman yang dirasakan pasien. Sikap yang tepat adalah mengakui perasaan pasien, membantu pasien mengenali bahwa pengalaman tersebut merupakan gejala yang dapat dikendalikan, serta mengarahkan pasien pada realitas secara perlahan. Pendekatan ini penting agar pengkajian dapat berjalan efektif dan pasien bersedia bekerja sama dalam proses asuhan keperawatan.

Pembahasan mengenai pengkajian keperawatan jiwa pada pasien dengan halusinasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai langkah-langkah awal dalam proses asuhan keperawatan jiwa. Melalui bab ini, pembaca diharapkan mampu memahami pentingnya pengkajian sebagai dasar dalam mengidentifikasi masalah keperawatan, menentukan prioritas, merencanakan intervensi, melaksanakan tindakan, dan mengevaluasi hasil keperawatan. Pengkajian yang baik akan membantu perawat memberikan asuhan yang lebih tepat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dengan demikian,

pengkajian bukan hanya proses mengumpulkan data, tetapi juga merupakan bentuk pendekatan profesional yang membantu pasien memperoleh perawatan yang manusiawi, terarah, dan mendukung pemulihan kesehatan jiwa secara optimal.

B. Konsep Dasar Pengkajian Keperawatan Jiwa

Pengkajian keperawatan jiwa merupakan tahap awal dalam proses asuhan keperawatan jiwa yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh mengenai kondisi biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan lingkungan pasien. Pengkajian ini tidak hanya berfokus pada keluhan fisik, tetapi juga menggali pikiran, perasaan, perilaku, persepsi, hubungan sosial, kemampuan coping, serta riwayat kehidupan pasien yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan jiwanya. Dalam konteks pasien dengan gangguan jiwa, pengkajian menjadi sangat penting karena gejala yang muncul sering kali tidak hanya tampak secara langsung, tetapi juga tersembunyi dalam bentuk perubahan perilaku, gangguan komunikasi, perubahan emosi, atau pengalaman subjektif yang hanya dapat diketahui melalui pendekatan terapeutik.

Pengkajian keperawatan jiwa berbeda dengan pengkajian keperawatan pada umumnya karena perawat harus mampu memahami kondisi pasien secara lebih mendalam, termasuk aspek mental dan emosional yang sedang dialami. Pada pasien dengan halusinasi, misalnya, pengkajian tidak cukup hanya menanyakan keluhan utama, tetapi juga perlu menggali jenis halusinasi yang dialami, isi halusinasi, waktu muncul, frekuensi, durasi, faktor pencetus, respons pasien, serta kemampuan pasien dalam mengontrol halusinasinya. Pengkajian juga mencakup pemeriksaan status mental, seperti penampilan, pembicaraan, suasana perasaan, afek, proses pikir, isi pikir, persepsi, orientasi, memori, konsentrasi, kemampuan mengambil keputusan, dan daya tilik diri. Semua data tersebut membantu perawat memahami kondisi pasien secara utuh.

Tujuan utama pengkajian dalam proses keperawatan jiwa adalah memperoleh data yang akurat sebagai dasar untuk menentukan masalah keperawatan. Data yang diperoleh dari pengkajian akan digunakan untuk merumuskan diagnosis keperawatan, menyusun rencana intervensi, melaksanakan tindakan keperawatan, dan mengevaluasi hasil asuhan. Dengan pengkajian yang tepat, perawat dapat mengetahui masalah utama pasien, faktor penyebab atau pencetus masalah, tingkat keparahan gejala, kemampuan pasien dalam menghadapi masalah, serta dukungan yang tersedia dari keluarga atau lingkungan. Pada pasien dengan halusinasi, tujuan pengkajian juga mencakup identifikasi risiko

keselamatan, seperti risiko mencederai diri sendiri, mencederai orang lain, perilaku kekerasan, atau ketidakpatuhan terhadap pengobatan.

Selain sebagai dasar penentuan masalah, pengkajian keperawatan jiwa juga bertujuan membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Hubungan saling percaya sangat penting karena pasien dengan gangguan jiwa sering kali mengalami ketakutan, kecurigaan, rasa malu, atau kesulitan dalam mengungkapkan pengalaman batinnya. Apabila pasien merasa diterima dan tidak dihakimi, ia akan lebih mudah menceritakan keluhan, perasaan, dan pengalaman yang dialami. Dalam pengkajian pasien halusinasi, hubungan saling percaya memungkinkan pasien untuk mengungkapkan pengalaman mendengar suara, melihat sesuatu, atau merasakan sensasi tertentu yang tidak dialami orang lain. Tanpa hubungan terapeutik yang baik, pasien dapat menolak berbicara, menyembunyikan gejala, atau memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Prinsip pertama yang harus diperhatikan dalam pengkajian keperawatan jiwa adalah empati. Empati berarti kemampuan perawat untuk memahami perasaan dan pengalaman pasien dari sudut pandang pasien, tanpa larut secara emosional atau kehilangan sikap profesional. Pada pasien dengan halusinasi, perawat perlu memahami bahwa pengalaman yang dirasakan pasien tampak nyata bagi dirinya, meskipun tidak nyata bagi orang lain. Oleh karena itu, perawat tidak boleh mengejek, meremehkan, atau langsung membantah pengalaman pasien. Sikap empatik dapat ditunjukkan melalui nada bicara yang tenang, kontak mata yang wajar, sikap tubuh yang terbuka, serta respons verbal yang menunjukkan bahwa perawat memahami perasaan pasien. Misalnya, perawat dapat mengatakan bahwa ia memahami pasien merasa takut ketika suara itu muncul, meskipun perawat tidak mendengar suara tersebut.

Prinsip berikutnya adalah objektivitas. Objektif berarti perawat harus mengumpulkan dan mencatat data berdasarkan fakta yang ditemukan, bukan berdasarkan prasangka, asumsi, atau penilaian pribadi. Dalam pengkajian keperawatan jiwa, objektivitas sangat penting karena gejala pasien sering kali dapat disalahartikan. Sebagai contoh, pasien yang tampak berbicara sendiri tidak langsung disimpulkan sebagai mengalami halusinasi sebelum perawat menggali data lebih lanjut. Perawat perlu mencatat data subjektif dari pernyataan pasien dan data objektif dari hasil observasi. Data subjektif misalnya pasien mengatakan mendengar suara yang memanggil namanya, sedangkan data objektif misalnya pasien tampak menoleh ke arah tertentu, berbicara sendiri, atau tampak gelisah. Pemisahan data subjektif dan objektif membantu perawat melakukan analisis secara lebih tepat.

Keamanan juga menjadi prinsip penting dalam pengkajian keperawatan jiwa. Pengkajian harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pasien, perawat, keluarga, dan lingkungan sekitar. Pada pasien dengan halusinasi, terutama halusinasi yang berisi perintah atau ancaman, risiko perilaku berbahaya dapat meningkat. Oleh karena itu, perawat perlu menilai kondisi pasien sebelum dan selama pengkajian. Bila pasien tampak sangat gelisah, marah, membawa benda berbahaya, atau menunjukkan tanda-tanda perilaku kekerasan, perawat harus menjaga jarak aman, memastikan lingkungan bebas dari benda berisiko, dan melibatkan tim kesehatan bila diperlukan. Keamanan juga mencakup pemilihan tempat pengkajian yang tenang, tidak terlalu ramai, memiliki akses keluar yang mudah, dan tetap menjaga privasi pasien.

Prinsip kerahasiaan juga harus dijaga dalam setiap pengkajian keperawatan jiwa. Pasien dengan gangguan jiwa sering menyampaikan pengalaman pribadi, riwayat trauma, konflik keluarga, penggunaan zat, masalah hubungan sosial, atau pikiran yang sensitif. Semua informasi tersebut harus diperlakukan sebagai data rahasia yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Perawat tidak boleh membicarakan kondisi pasien kepada pihak yang tidak berkepentingan. Kerahasiaan ini penting untuk menjaga martabat pasien dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap perawat. Namun, apabila terdapat informasi yang menunjukkan risiko serius, seperti keinginan bunuh diri, rencana mencederai orang lain, atau ancaman keselamatan, maka perawat perlu menyampaikan informasi tersebut kepada tim kesehatan sesuai prosedur untuk mencegah bahaya.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah sikap tidak menghakimi. Pasien dengan gangguan jiwa sering mengalami stigma, penolakan, dan perlakuan negatif dari lingkungan. Jika perawat menunjukkan sikap menyalahkan, merendahkan, atau tidak percaya, pasien dapat merasa semakin tertekan dan menutup diri. Dalam pengkajian, perawat harus menerima pasien sebagai individu yang sedang membutuhkan bantuan, bukan sebagai orang yang harus disalahkan atas kondisinya. Sikap tidak menghakimi ditunjukkan dengan mendengarkan secara aktif, tidak memotong pembicaraan, tidak memberikan komentar yang merendahkan, dan tidak memaksakan pendapat. Pada pasien dengan halusinasi, perawat perlu menghargai bahwa pengalaman tersebut benar-benar dirasakan pasien, meskipun perawat tetap membantu pasien untuk membedakan antara halusinasi dan kenyataan.

Sumber data dalam pengkajian keperawatan jiwa dapat berasal dari pasien, keluarga, rekam medis, dan observasi langsung. Pasien merupakan sumber data utama karena pasienlah yang mengalami langsung keluhan, perasaan, pikiran, dan

perubahan persepsi. Dari pasien, perawat dapat memperoleh data subjektif mengenai apa yang dirasakan, didengar, dilihat, dipikirkan, dan dialami. Namun, pada beberapa kondisi, pasien mungkin sulit memberikan informasi secara jelas karena bingung, curiga, menarik diri, tidak kooperatif, atau mengalami gangguan proses pikir. Oleh karena itu, perawat perlu menggunakan komunikasi yang sederhana, sabar, dan berulang bila diperlukan agar pasien dapat memberikan informasi sesuai kemampuannya.

Keluarga juga menjadi sumber data yang sangat penting dalam pengkajian keperawatan jiwa. Keluarga biasanya mengetahui perubahan perilaku pasien sebelum masuk rumah sakit atau sebelum mendapat pelayanan kesehatan. Informasi dari keluarga dapat mencakup kapan gejala mulai muncul, bagaimana pola perilaku pasien di rumah, apakah pasien pernah mengalami gangguan jiwa sebelumnya, apakah pasien patuh minum obat, bagaimana hubungan pasien dengan anggota keluarga, serta faktor stres yang mungkin memicu kekambuhan. Pada pasien dengan halusinasi, keluarga dapat membantu menjelaskan perilaku yang tampak, seperti pasien sering berbicara sendiri, sulit tidur, marah tanpa sebab, mengurung diri, atau menolak makan. Data dari keluarga membantu perawat melengkapi informasi yang tidak dapat diperoleh langsung dari pasien.

Rekam medis juga merupakan sumber data penting karena berisi riwayat kesehatan, diagnosis medis, hasil pemeriksaan, riwayat pengobatan, riwayat perawatan sebelumnya, respons terhadap terapi, dan catatan perkembangan pasien. Melalui rekam medis, perawat dapat mengetahui apakah pasien pernah mengalami kekambuhan, obat apa yang pernah diberikan, efek samping yang muncul, serta intervensi apa yang sebelumnya efektif. Data ini sangat membantu dalam menyusun rencana asuhan yang lebih tepat dan berkelanjutan. Selain itu, rekam medis membantu perawat menghindari pengulangan tindakan yang tidak perlu serta meningkatkan koordinasi antaranggota tim kesehatan.

Observasi langsung merupakan sumber data yang sangat penting dalam keperawatan jiwa karena tidak semua kondisi pasien dapat diungkapkan melalui kata-kata. Perawat perlu mengamati penampilan pasien, ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, pola bicara, respons terhadap lingkungan, interaksi sosial, aktivitas harian, dan tanda-tanda perilaku yang mengarah pada halusinasi. Misalnya, pasien tampak tersenyum sendiri, bergumam, tiba-tiba terdiam seperti mendengarkan sesuatu, menutup telinga, atau tampak takut tanpa stimulus yang jelas. Observasi langsung membantu perawat memperoleh data objektif yang dapat memperkuat atau memvalidasi data subjektif dari pasien dan keluarga.

Tahapan pengkajian keperawatan jiwa dimulai dari pengumpulan data. Pada tahap ini, perawat mengumpulkan data subjektif dan objektif melalui wawancara,

observasi, pemeriksaan fisik sederhana, pemeriksaan status mental, penelusuran rekam medis, serta komunikasi dengan keluarga atau orang terdekat pasien. Data yang dikumpulkan harus mencakup identitas pasien, keluhan utama, riwayat gangguan jiwa, riwayat kesehatan fisik, riwayat penggunaan obat atau zat, riwayat keluarga, status mental, pola hubungan sosial, mekanisme koping, aspek spiritual, serta risiko keselamatan. Pada pasien dengan halusinasi, pengumpulan data harus lebih terarah pada pengalaman halusinasi, seperti jenis, isi, waktu, frekuensi, durasi, pencetus, dan respons pasien terhadap halusinasi.

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah validasi data. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar, konsisten, dan dapat dipercaya. Perawat perlu membandingkan data dari pasien, keluarga, observasi, dan rekam medis. Misalnya, pasien mengatakan tidak pernah mendengar suara, tetapi keluarga melaporkan pasien sering berbicara sendiri dan perawat mengamati pasien tampak menoleh serta menjawab sesuatu yang tidak terdengar. Perbedaan data seperti ini perlu dikaji lebih lanjut dengan pendekatan yang hati-hati. Validasi penting agar perawat tidak salah menyimpulkan kondisi pasien. Validasi juga dapat dilakukan dengan mengulang pertanyaan menggunakan kalimat yang berbeda, meminta klarifikasi, atau mengamati pasien dalam beberapa situasi.

Tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini, perawat mengelompokkan data yang telah diperoleh untuk menemukan pola masalah. Data subjektif dan objektif dianalisis untuk melihat hubungan antara keluhan, tanda, gejala, faktor penyebab, dan risiko yang muncul. Misalnya, pasien mengatakan mendengar suara yang menyuruhnya marah, tampak gelisah, sering mengepalkan tangan, dan pernah memukul orang di rumah. Data tersebut dapat menunjukkan adanya gangguan persepsi sensori disertai risiko perilaku kekerasan. Analisis data memerlukan kemampuan berpikir kritis agar perawat dapat menentukan masalah utama dan masalah penyerta secara tepat.

Tahap akhir dalam pengkajian adalah perumusan masalah keperawatan. Masalah keperawatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis data dan menjadi dasar untuk menyusun intervensi. Pada pasien dengan halusinasi, masalah keperawatan yang mungkin muncul antara lain gangguan persepsi sensori, risiko perilaku kekerasan, isolasi sosial, ansietas, harga diri rendah, defisit perawatan diri, gangguan pola tidur, atau ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Perumusan masalah harus dilakukan secara jelas dan sesuai dengan data yang ditemukan. Masalah yang paling mengancam keselamatan pasien perlu menjadi prioritas utama dalam perencanaan asuhan.

C. Konsep Dasar Halusinasi

Halusinasi merupakan salah satu bentuk gangguan persepsi sensori, yaitu keadaan ketika seseorang merasakan adanya rangsangan melalui pancaindra, padahal rangsangan tersebut sebenarnya tidak ada secara nyata. Dengan kata lain, pasien mengalami pengalaman sensori yang terasa sangat nyata bagi dirinya, meskipun orang lain di sekitarnya tidak mengalami atau menangkap rangsangan yang sama. Halusinasi dapat muncul dalam bentuk suara, bayangan, bau, rasa, sentuhan, atau sensasi tubuh tertentu yang tidak memiliki sumber nyata dari lingkungan. Pada pasien dengan gangguan jiwa, pengalaman halusinasi sering kali dianggap benar-benar terjadi sehingga pasien dapat meresponsnya dengan berbicara sendiri, tertawa sendiri, merasa takut, marah, gelisah, atau mengikuti perintah dari halusinasi tersebut.

Dalam keperawatan jiwa, halusinasi dipahami sebagai masalah yang penting karena dapat memengaruhi kemampuan pasien dalam menilai kenyataan. Pasien yang mengalami halusinasi dapat kesulitan membedakan antara pengalaman yang nyata dengan pengalaman yang berasal dari gangguan persepsi. Misalnya, pasien mendengar suara yang menyuruhnya melakukan sesuatu, padahal tidak ada orang yang berbicara. Bagi perawat atau orang lain, suara tersebut tidak nyata, tetapi bagi pasien suara itu dapat terdengar jelas, berulang, dan sangat meyakinkan. Oleh karena itu, perawat tidak boleh langsung menyalahkan atau menertawakan pengalaman pasien, karena hal tersebut dapat membuat pasien merasa tidak dipahami dan semakin menarik diri. Perawat perlu memahami bahwa halusinasi merupakan gejala yang benar-benar dirasakan oleh pasien, meskipun stimulusnya tidak berasal dari kenyataan objektif.

Halusinasi perlu dibedakan dengan ilusi, waham, dan fantasi karena keempat istilah tersebut sering dianggap sama, padahal memiliki makna yang berbeda. Ilusi adalah kesalahan dalam menafsirkan rangsangan nyata. Pada ilusi, stimulus dari luar sebenarnya ada, tetapi dipersepsikan secara keliru oleh seseorang. Misalnya, pasien melihat bayangan baju yang tergantung di kamar lalu mengira bayangan tersebut sebagai seseorang yang sedang berdiri. Berbeda dengan halusinasi, pada ilusi masih terdapat rangsangan nyata, hanya saja interpretasi pasien terhadap rangsangan tersebut tidak tepat. Sementara itu, halusinasi terjadi tanpa adanya rangsangan nyata sama sekali, misalnya pasien mendengar suara yang memanggil namanya, padahal tidak ada suara di lingkungan sekitarnya.

Waham juga berbeda dengan halusinasi. Waham merupakan keyakinan yang salah, menetap, dan tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi diyakini kuat oleh pasien meskipun telah diberikan penjelasan logis. Waham berkaitan dengan gangguan isi pikir, sedangkan halusinasi berkaitan dengan gangguan persepsi

sensori. Sebagai contoh, pasien dengan waham kejar merasa yakin bahwa dirinya sedang diikuti atau diawasi oleh orang tertentu, meskipun tidak ada bukti nyata. Pada pasien dengan halusinasi, gangguan yang muncul lebih berhubungan dengan pengalaman indra, seperti mendengar, melihat, mencium, merasakan, atau menyentuh sesuatu yang tidak ada. Walaupun berbeda, halusinasi dan waham dapat muncul bersamaan. Misalnya, pasien mendengar suara yang mengatakan bahwa dirinya akan dicelakai, kemudian pasien meyakini bahwa semua orang di sekitarnya berniat jahat kepadanya.

Fantasi juga berbeda dengan halusinasi. Fantasi merupakan hasil imajinasi atau khayalan yang biasanya masih disadari oleh individu sebagai sesuatu yang tidak nyata. Seseorang dapat membayangkan berada di tempat yang menyenangkan, membayangkan masa depan, atau menciptakan gambaran tertentu dalam pikirannya, tetapi ia masih mampu membedakan bahwa hal tersebut hanya khayalan. Pada halusinasi, pengalaman yang muncul tidak dianggap sebagai khayalan oleh pasien, melainkan dirasakan sebagai sesuatu yang nyata. Perbedaan ini penting dalam pengkajian keperawatan jiwa karena respons dan penanganannya berbeda. Fantasi tidak selalu menunjukkan gangguan jiwa, sedangkan halusinasi dapat menjadi tanda adanya gangguan persepsi yang memerlukan perhatian dan intervensi keperawatan.

Jenis halusinasi yang paling sering ditemukan pada pasien gangguan jiwa adalah halusinasi pendengaran. Pada halusinasi pendengaran, pasien mendengar suara, bisikan, panggilan, percakapan, atau perintah yang tidak didengar oleh orang lain. Suara tersebut dapat bersifat netral, menyenangkan, mengejek, mengancam, atau memerintah. Halusinasi pendengaran yang berisi perintah perlu mendapat perhatian khusus karena dapat mendorong pasien melakukan tindakan berisiko, seperti menyakiti diri sendiri, menyerang orang lain, menolak makan, atau melakukan perilaku yang membahayakan. Dalam pengkajian, perawat perlu menanyakan isi suara yang didengar pasien, seberapa sering suara itu muncul, kapan biasanya muncul, dan bagaimana respons pasien terhadap suara tersebut.

Halusinasi penglihatan terjadi ketika pasien melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Bentuknya dapat berupa bayangan, cahaya, orang, hewan, benda, atau kejadian tertentu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Pasien dapat merasa takut, terkejut, atau berusaha menghindari sesuatu yang dilihatnya. Halusinasi penglihatan dapat menyebabkan pasien berperilaku seolah-olah sedang berinteraksi dengan objek tertentu, misalnya menunjuk ke arah kosong, menatap satu titik dalam waktu lama, atau berusaha mengusir bayangan yang dianggap mengganggu. Pada kondisi tertentu, halusinasi penglihatan dapat membuat

pasien mengalami kecemasan berat karena apa yang dilihat terasa menakutkan atau mengancam.

Halusinasi penciuman adalah keadaan ketika pasien mencium bau tertentu tanpa adanya sumber bau yang nyata. Bau yang dirasakan dapat berupa bau busuk, asap, darah, bunga, makanan, obat, atau bau lain yang hanya dirasakan oleh pasien. Meskipun tampak sederhana, halusinasi penciuman dapat memengaruhi perilaku pasien. Misalnya, pasien menolak makan karena merasa makanan berbau racun, menutup hidung terus-menerus, atau merasa lingkungan sekitarnya tidak aman karena mencium bau tertentu. Dalam pengkajian, perawat perlu menggali apakah bau tersebut muncul pada waktu tertentu, apakah pasien menghubungkannya dengan perasaan takut atau curiga, serta apakah halusinasi tersebut memengaruhi pola makan atau aktivitas pasien.

Halusinasi pengecapan terjadi ketika pasien merasakan rasa tertentu di mulut tanpa adanya makanan, minuman, atau rangsangan nyata. Pasien dapat merasakan rasa pahit, asam, manis, asin, logam, atau rasa tidak enak lainnya. Halusinasi jenis ini dapat menyebabkan pasien menolak makan atau minum karena merasa makanan telah berubah rasa atau dicampur sesuatu. Pada beberapa pasien, halusinasi pengecapan dapat berkaitan dengan kecurigaan atau waham, misalnya pasien merasa makanannya diberi racun karena merasakan rasa yang aneh. Oleh karena itu, perawat perlu mengkaji perubahan pola makan, penurunan nafsu makan, penolakan terhadap makanan, serta keyakinan pasien terhadap rasa yang dialaminya.

Halusinasi perabaan adalah pengalaman merasakan sentuhan, tekanan, panas, dingin, nyeri, gatal, atau sensasi lain pada tubuh tanpa adanya rangsangan nyata. Pasien dapat merasa ada serangga berjalan di kulit, merasa disentuh seseorang, merasa tubuhnya ditusuk, atau merasa ada sesuatu bergerak di dalam tubuh. Halusinasi perabaan dapat menyebabkan pasien menggaruk kulit berlebihan, memukul bagian tubuh tertentu, atau merasa sangat tidak nyaman. Jika tidak dikaji dengan baik, kondisi ini dapat disalahartikan sebagai keluhan fisik semata. Oleh karena itu, perawat perlu membedakan apakah keluhan tersebut memiliki penyebab fisik yang jelas atau berkaitan dengan gangguan persepsi sensori.

Faktor penyebab halusinasi sangat kompleks dan dapat berasal dari faktor biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual. Faktor biologis berkaitan dengan kondisi tubuh dan fungsi otak yang memengaruhi persepsi seseorang. Gangguan keseimbangan zat kimia otak, riwayat gangguan jiwa dalam keluarga, gangguan neurologis, penggunaan zat psikoaktif, kurang tidur berat, atau kondisi medis tertentu dapat meningkatkan risiko munculnya halusinasi. Pada pasien dengan

gangguan jiwa berat, halusinasi sering kali berkaitan dengan perubahan fungsi otak dalam memproses rangsangan dan membedakan antara pengalaman internal dengan realitas eksternal. Selain itu, ketidakpatuhan minum obat atau penghentian pengobatan secara tiba-tiba juga dapat memicu kekambuhan gejala halusinasi.

Faktor psikologis juga berperan besar dalam terjadinya halusinasi. Pengalaman traumatis, tekanan emosional yang berat, kehilangan orang yang dicintai, konflik batin, kecemasan berkepanjangan, atau mekanisme koping yang tidak efektif dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap gangguan persepsi. Pada beberapa pasien, halusinasi dapat muncul sebagai respons terhadap stres yang tidak mampu diatasi secara adaptif. Ketika pasien tidak mampu mengekspresikan perasaan atau menyelesaikan konflik secara sehat, tekanan psikologis dapat berkembang menjadi gejala yang lebih berat, termasuk halusinasi. Oleh karena itu, pengkajian terhadap riwayat trauma, pengalaman hidup, pola koping, dan kondisi emosional pasien sangat penting dalam memahami latar belakang munculnya halusinasi.

Faktor sosial juga dapat memengaruhi muncul dan berulangnya halusinasi. Lingkungan yang tidak mendukung, konflik keluarga, penolakan sosial, stigma terhadap gangguan jiwa, kesepian, kehilangan pekerjaan, kemiskinan, serta kurangnya dukungan sosial dapat memperburuk kondisi pasien. Pasien yang mengalami isolasi sosial lebih rentan tenggelam dalam pengalaman internalnya, termasuk halusinasi. Kurangnya komunikasi dengan orang lain juga dapat membuat pasien semakin sulit membedakan kenyataan dengan pengalaman halusinatif. Dalam konteks ini, keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membantu pasien mempertahankan orientasi realitas, minum obat secara teratur, mengikuti kontrol kesehatan, dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Faktor spiritual juga perlu diperhatikan dalam pengkajian halusinasi. Pada sebagian pasien, pengalaman halusinasi dapat dimaknai secara spiritual atau religius, misalnya pasien merasa mendengar suara dari makhluk tertentu, mendapatkan pesan khusus, atau merasa dihukum karena kesalahan masa lalu. Pemaknaan spiritual ini dapat memengaruhi respons pasien terhadap halusinasi, baik memperkuat keyakinan pasien terhadap pengalaman tersebut maupun menjadi sumber ketenangan bagi pasien. Perawat perlu mengkaji aspek spiritual dengan hati-hati, tanpa menghakimi keyakinan pasien. Tujuannya bukan untuk memperdebatkan keyakinan pasien, tetapi untuk memahami bagaimana pasien memaknai pengalamannya dan bagaimana aspek spiritual dapat digunakan secara positif dalam proses pemulihan.

Dampak halusinasi terhadap fungsi kehidupan sehari-hari pasien dapat sangat luas. Pada aspek perawatan diri, pasien yang sering mengalami halusinasi

dapat menjadi kurang memperhatikan kebersihan diri, malas mandi, jarang mengganti pakaian, tidak teratur makan, atau mengalami gangguan tidur. Hal ini terjadi karena perhatian pasien lebih banyak tersita oleh pengalaman halusinatif yang dialami. Pasien juga dapat merasa lelah secara mental akibat terus-menerus mendengar suara atau melihat sesuatu yang mengganggu. Akibatnya, kemampuan pasien dalam menjalankan aktivitas harian menjadi menurun dan membutuhkan bantuan atau pengawasan dari keluarga maupun tenaga kesehatan.

Pada aspek hubungan sosial, halusinasi dapat menyebabkan pasien menarik diri dari lingkungan. Pasien mungkin merasa malu, takut dianggap aneh, atau merasa orang lain tidak memahami apa yang dialaminya. Perilaku seperti berbicara sendiri, tertawa sendiri, atau tampak merespons sesuatu yang tidak terlihat dapat membuat orang di sekitar merasa bingung atau takut. Jika keluarga dan masyarakat tidak memahami kondisi ini, pasien dapat mengalami stigma dan penolakan. Kondisi tersebut dapat memperburuk rasa kesepian, menurunkan harga diri, dan meningkatkan risiko kekambuhan. Oleh karena itu, edukasi keluarga menjadi bagian penting dalam membantu pasien dengan halusinasi.

Halusinasi juga berdampak pada kemampuan pasien dalam bekerja, belajar, atau menjalankan peran sosial. Pasien dapat mengalami kesulitan berkonsentrasi karena perhatian terganggu oleh suara atau bayangan yang muncul. Pasien juga dapat kehilangan motivasi, mudah lelah, sulit menyelesaikan tugas, atau tidak mampu mengikuti instruksi dengan baik. Apabila halusinasi muncul secara sering dan intens, pasien dapat mengalami hambatan dalam menjalankan pekerjaan, pendidikan, atau tanggung jawab keluarga. Kondisi ini dapat menurunkan kemandirian pasien dan meningkatkan ketergantungan pada orang lain.

Dampak yang paling serius dari halusinasi berkaitan dengan keselamatan. Halusinasi yang bersifat mengancam atau memerintah dapat meningkatkan risiko pasien melakukan tindakan berbahaya. Pasien dapat melukai diri sendiri karena merasa diperintah oleh suara tertentu, menyerang orang lain karena merasa terancam, atau melakukan tindakan impulsif untuk menghindari halusinasi. Selain itu, halusinasi dapat menyebabkan pasien menolak makan, menolak obat, kabur dari rumah, atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan realitas. Oleh karena itu, pengkajian terhadap isi halusinasi, tingkat keyakinan pasien, kemampuan mengontrol halusinasi, dan riwayat perilaku berisiko harus menjadi perhatian utama dalam praktik keperawatan jiwa.

konsep dasar halusinasi, perawat dapat melakukan pengkajian dan intervensi secara lebih tepat. Halusinasi bukan sekadar gejala yang perlu dicatat, tetapi merupakan pengalaman kompleks yang memengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, hubungan sosial, dan keselamatan pasien. Pemahaman yang baik mengenai

pengertian, perbedaan dengan gangguan lain, jenis-jenis halusinasi, faktor penyebab, serta dampaknya terhadap kehidupan pasien akan membantu perawat memberikan asuhan yang lebih manusiawi, aman, dan efektif. Pendekatan yang tepat dapat membantu pasien mengenali halusinasinya, mengontrol respons terhadap halusinasi, mempertahankan orientasi realitas, serta meningkatkan kualitas hidupnya secara bertahap.

D. Tanda dan Gejala Pasien dengan Halusinasi

Tanda dan gejala pasien dengan halusinasi dapat terlihat dari perubahan perilaku, ekspresi emosi, pola komunikasi, kemampuan berinteraksi, hingga aktivitas sehari-hari. Halusinasi merupakan pengalaman persepsi yang dirasakan nyata oleh pasien, meskipun tidak terdapat rangsangan nyata dari lingkungan. Oleh karena itu, pasien sering memberikan respons terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak dapat dilihat, didengar, atau dirasakan oleh orang lain. Dalam pengkajian keperawatan jiwa, perawat perlu memperhatikan tanda-tanda tersebut secara cermat karena sebagian pasien tidak selalu mampu atau bersedia mengungkapkan pengalaman halusinasinya secara langsung. Beberapa pasien merasa takut, malu, bingung, atau curiga sehingga memilih menyembunyikan apa yang dialami. Karena itu, observasi perilaku menjadi bagian penting dalam mengenali adanya halusinasi.

Salah satu tanda yang sering tampak pada pasien dengan halusinasi adalah berbicara atau tertawa sendiri. Perilaku ini biasanya muncul karena pasien sedang merespons suara, percakapan, atau stimulus internal yang dirasakannya. Pada halusinasi pendengaran, misalnya, pasien dapat mendengar suara yang memanggil namanya, mengomentari perilakunya, mengejek, mengancam, atau bahkan mengajaknya berbicara. Karena suara tersebut terasa nyata, pasien dapat menjawab suara itu seolah-olah sedang berkomunikasi dengan orang lain. Pasien dapat berbicara pelan seperti bergumam, berbicara dengan nada marah, menjawab pertanyaan yang tidak terdengar oleh orang lain, atau tertawa tanpa sebab yang jelas. Bagi perawat, perilaku ini menjadi data objektif yang penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama mengenai isi halusinasi dan respons pasien terhadap pengalaman tersebut.

Pasien dengan halusinasi juga dapat tampak seperti sedang mendengarkan sesuatu tanpa adanya stimulus nyata. Perilaku ini dapat terlihat dari pasien yang tiba-tiba terdiam, memiringkan kepala, menoleh ke arah tertentu, tampak fokus pada suara yang tidak didengar orang lain, atau berhenti berbicara saat sedang diajak komunikasi. Pasien mungkin terlihat seperti sedang memperhatikan sesuatu dengan serius, padahal lingkungan sekitar tidak menunjukkan adanya sumber

suara. Kondisi ini dapat mengganggu proses komunikasi antara perawat dan pasien karena perhatian pasien terbagi antara percakapan nyata dengan stimulus halusinatif yang dialaminya. Dalam situasi seperti ini, perawat perlu bersikap tenang dan tidak langsung memaksa pasien menjawab. Perawat dapat melakukan pendekatan terapeutik dengan menanyakan apa yang sedang pasien dengar atau rasakan secara perlahan dan tidak menghakimi.

Tanda lain yang sering muncul adalah pasien lebih banyak menyendiri. Pasien dengan halusinasi sering menarik diri dari lingkungan karena merasa lebih nyaman berada sendiri, merasa takut terhadap orang lain, atau lebih fokus pada pengalaman internal yang dialaminya. Menyendiri juga dapat terjadi karena pasien merasa orang lain tidak memahami apa yang dirasakan. Pada beberapa kondisi, pasien memilih menghindari interaksi sosial karena malu apabila orang lain mengetahui bahwa dirinya mendengar suara atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Jika perilaku menyendiri berlangsung terus-menerus, pasien dapat mengalami penurunan kemampuan sosial, kehilangan minat terhadap aktivitas, dan semakin sulit membedakan realitas dengan pengalaman halusinatif. Oleh karena itu, perawat perlu mengkaji pola interaksi pasien, perubahan hubungan dengan keluarga, serta kemampuan pasien dalam mengikuti aktivitas sosial.

Selain menyendiri, pasien juga dapat menunjukkan kegelisahan, ketakutan, atau kecurigaan. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh isi halusinasi yang dialami. Apabila halusinasi berisi ancaman, hinaan, atau perintah yang menakutkan, pasien dapat merasa cemas dan tidak aman. Pasien mungkin terlihat mondar-mandir, sulit duduk tenang, wajah tampak tegang, mudah terkejut, atau sering melihat ke sekeliling seolah-olah sedang mengawasi sesuatu. Rasa curiga dapat muncul jika pasien mengaitkan halusinasi dengan orang di sekitarnya. Misalnya, pasien mendengar suara yang mengatakan bahwa dirinya akan disakiti, kemudian pasien menjadi curiga terhadap keluarga, perawat, atau pasien lain. Kecurigaan ini dapat menghambat proses perawatan karena pasien mungkin menolak diajak bicara, menolak minum obat, atau menolak menerima bantuan.

Perilaku menutup telinga juga sering terlihat pada pasien dengan halusinasi, terutama halusinasi pendengaran. Pasien menutup telinga karena berusaha menghindari suara yang mengganggu atau menakutkan. Tindakan ini menunjukkan bahwa halusinasi yang dialami dapat menimbulkan tekanan emosional yang kuat. Selain menutup telinga, pasien dapat tampak menoleh ke arah tertentu, mencari sumber suara, atau berbicara dengan nada membantah. Pasien mungkin mengatakan "diam", "jangan ganggu saya", atau "pergi" kepada suara yang didengarnya. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa pasien sedang berusaha melawan atau mengontrol halusinasi, meskipun belum tentu berhasil.

Dalam pengkajian, perawat perlu menggali apakah pasien memiliki cara tertentu untuk mengurangi halusinasi, misalnya berdoa, berbicara dengan orang lain, melakukan aktivitas, atau minum obat.

Pasien juga dapat tampak mengikuti suara atau perintah yang muncul dari halusinasinya. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus karena dapat meningkatkan risiko perilaku berbahaya. Halusinasi yang bersifat memerintah disebut halusinasi perintah. Isi perintah dapat bermacam-macam, mulai dari perintah sederhana hingga perintah yang membahayakan, seperti menyakiti diri sendiri, melukai orang lain, membuang barang, pergi dari rumah, atau menolak makan dan minum. Tidak semua pasien langsung mengikuti perintah halusinasi, tetapi semakin kuat keyakinan pasien terhadap suara tersebut, semakin besar kemungkinan pasien bertindak sesuai perintahnya. Oleh karena itu, perawat harus mengkaji isi halusinasi secara hati-hati, termasuk apakah suara tersebut menyuruh pasien melakukan sesuatu, apakah pasien pernah mengikuti perintah tersebut, dan apakah pasien mampu menolak suara yang muncul.

Gangguan tidur merupakan gejala yang juga sering dialami pasien dengan halusinasi. Halusinasi dapat muncul lebih sering saat malam hari, saat pasien sendirian, atau ketika suasana lingkungan menjadi sepi. Pada kondisi tersebut, pasien dapat sulit tidur karena mendengar suara, merasa takut, atau merasa terganggu oleh stimulus yang tidak nyata. Kurang tidur kemudian dapat memperburuk kondisi mental pasien, meningkatkan kecemasan, menurunkan konsentrasi, dan membuat pasien semakin sulit mengontrol halusinasi. Siklus ini dapat berlangsung berulang, yaitu halusinasi menyebabkan gangguan tidur, lalu kurang tidur memperberat halusinasi. Perawat perlu mengkaji pola tidur pasien, jumlah jam tidur, kualitas tidur, waktu munculnya halusinasi, dan kebiasaan pasien sebelum tidur.

Gangguan konsentrasi juga sering muncul karena perhatian pasien terpecah oleh halusinasi. Pasien mungkin sulit fokus ketika diajak berbicara, tidak mampu mengikuti instruksi, sering meminta pertanyaan diulang, atau memberikan jawaban yang tidak sesuai. Hal ini bukan selalu karena pasien tidak mau bekerja sama, melainkan karena pasien sedang terganggu oleh pengalaman sensori internal. Pada saat halusinasi muncul, pasien dapat lebih memperhatikan suara atau bayangan yang dialami daripada pembicaraan dengan perawat. Gangguan konsentrasi ini dapat memengaruhi kemampuan pasien dalam mengikuti kegiatan terapi, memahami edukasi kesehatan, menjalankan aktivitas sehari-hari, dan menjaga kepatuhan pengobatan.

Halusinasi juga dapat memengaruhi kemampuan perawatan diri pasien. Pasien yang terus-menerus terganggu oleh halusinasi dapat kehilangan minat

untuk mandi, mengganti pakaian, merapikan rambut, makan teratur, atau menjaga kebersihan lingkungan. Penurunan perawatan diri dapat terjadi karena pasien merasa takut, tidak bertenaga, tidak peduli terhadap penampilan, atau terlalu fokus pada stimulus halusinatif. Pada beberapa pasien, isi halusinasi juga dapat memengaruhi perilaku makan dan minum. Misalnya, pasien menolak makan karena mendengar suara yang mengatakan makanan tersebut berbahaya, atau pasien merasa makanan berbau dan berasa aneh akibat halusinasi penciuman atau pengecapan. Oleh karena itu, pengkajian perawatan diri perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk kebersihan diri, pola makan, pola tidur, aktivitas, dan kepatuhan terhadap pengobatan.

Pada kondisi yang lebih berat, pasien dengan halusinasi dapat menunjukkan perilaku agresif. Perilaku agresif dapat muncul apabila halusinasi bersifat mengancam, menakutkan, atau memerintah pasien untuk melakukan kekerasan. Pasien dapat menjadi mudah marah, berteriak, memukul benda, mengancam orang lain, atau melakukan tindakan yang membahayakan. Agresivitas juga dapat terjadi karena pasien merasa sedang membela diri dari ancaman yang sebenarnya berasal dari halusinasi. Misalnya, pasien mendengar suara yang mengatakan bahwa seseorang akan menyakitinya, sehingga pasien menyerang orang tersebut karena merasa terancam. Dalam keadaan ini, perawat perlu memprioritaskan keselamatan pasien, orang lain, dan lingkungan. Pengkajian risiko perilaku kekerasan harus dilakukan dengan serius, terutama jika pasien tampak gelisah, curiga, sulit diarahkan, atau memiliki riwayat mengikuti perintah halusinasi.

Tanda dan gejala halusinasi tidak selalu muncul secara sama pada setiap pasien. Ada pasien yang menunjukkan gejala secara jelas, seperti berbicara sendiri atau menutup telinga, tetapi ada juga pasien yang tampak tenang namun sebenarnya mengalami halusinasi yang intens. Oleh karena itu, perawat perlu menggabungkan data subjektif dari pasien, data objektif dari observasi, informasi dari keluarga, serta catatan rekam medis. Pengkajian yang baik tidak hanya mencatat bahwa pasien mengalami halusinasi, tetapi juga menggambarkan bagaimana halusinasi tersebut memengaruhi emosi, perilaku, hubungan sosial, tidur, konsentrasi, perawatan diri, dan keselamatan pasien. Dengan memahami tanda dan gejala secara mendalam, perawat dapat menentukan prioritas masalah dan merancang intervensi yang tepat untuk membantu pasien mengenali, mengontrol, dan mengurangi dampak halusinasi dalam kehidupan sehari-hari.

E. Faktor Predisposisi dan Presipitasi Halusinasi

Faktor predisposisi dan presipitasi merupakan dua aspek penting yang perlu dipahami dalam pengkajian keperawatan jiwa pada pasien dengan halusinasi. Faktor predisposisi adalah faktor yang membuat seseorang lebih rentan mengalami halusinasi, sedangkan faktor presipitasi adalah faktor pencetus yang memicu munculnya halusinasi pada seseorang yang sudah memiliki kerentanan tersebut. Dalam praktik keperawatan jiwa, pemahaman terhadap kedua faktor ini sangat penting karena halusinasi biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa latar belakang tertentu. Gejala halusinasi sering kali muncul sebagai hasil interaksi antara kondisi biologis, psikologis, sosial, spiritual, serta tekanan hidup yang dialami pasien. Oleh karena itu, pengkajian tidak cukup hanya berfokus pada gejala yang tampak, tetapi juga harus menggali riwayat hidup, kondisi keluarga, stresor, pola koping, dukungan sosial, serta riwayat pengobatan pasien.

Faktor predisposisi biologis merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kerentanan seseorang mengalami halusinasi. Faktor biologis berkaitan dengan kondisi tubuh, sistem saraf, fungsi otak, faktor genetik, serta keseimbangan zat kimia dalam otak. Riwayat gangguan jiwa dalam keluarga menjadi salah satu hal yang perlu dikaji karena adanya anggota keluarga dengan gangguan jiwa dapat menunjukkan kemungkinan kerentanan genetik. Meskipun tidak semua orang yang memiliki riwayat keluarga dengan gangguan jiwa pasti mengalami halusinasi, faktor keturunan dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan persepsi sensori apabila disertai tekanan psikologis atau lingkungan yang tidak mendukung. Dalam hal ini, perawat perlu menanyakan apakah ada anggota keluarga yang pernah mengalami gangguan jiwa, pernah dirawat di rumah sakit jiwa, menunjukkan perilaku serupa, atau memiliki riwayat penggunaan obat psikiatri.

Selain faktor keturunan, gangguan neurokimia juga berperan dalam munculnya halusinasi. Otak bekerja melalui komunikasi antar-sel saraf yang dipengaruhi oleh zat kimia tertentu. Ketidakseimbangan zat kimia otak dapat memengaruhi cara seseorang menerima, memproses, dan menafsirkan rangsangan. Pada pasien dengan halusinasi, proses persepsi dapat terganggu sehingga pengalaman internal seperti pikiran, suara batin, atau gambaran tertentu dipersepsikan seolah-olah berasal dari luar dirinya. Akibatnya, pasien dapat mendengar suara yang tidak nyata, melihat sesuatu yang tidak ada, atau merasakan sensasi yang tidak memiliki sumber nyata. Faktor biologis ini juga dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik tertentu, kelelahan berat, gangguan tidur, penyakit neurologis, riwayat cedera kepala, penggunaan obat tertentu, atau penyalahgunaan zat yang memengaruhi sistem saraf pusat.

Faktor predisposisi psikologis juga memiliki peran besar dalam munculnya halusinasi. Pengalaman traumatis, kehilangan, penolakan, kekerasan, pola asuh yang tidak mendukung, atau pengalaman masa lalu yang menyakitkan dapat meninggalkan tekanan emosional yang mendalam. Trauma yang tidak terselesaikan dapat memengaruhi cara seseorang memandang dirinya, orang lain, dan lingkungan. Pada sebagian pasien, pengalaman traumatis dapat berkembang menjadi kecemasan berat, rasa takut berkepanjangan, perasaan tidak aman, atau konflik batin yang sulit diungkapkan. Ketika tekanan psikologis tersebut tidak mampu diatasi secara sehat, pasien dapat mengalami gangguan dalam proses berpikir dan persepsi, termasuk munculnya halusinasi. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kekerasan atau ancaman dapat mendengar suara yang menakutkan atau merasa terus-menerus diawasi.

Kehilangan juga dapat menjadi faktor predisposisi psikologis yang penting. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan peran dalam keluarga, kehilangan harga diri, atau kehilangan harapan dapat menimbulkan tekanan emosional yang berat. Jika individu tidak memiliki kemampuan koping yang baik, kehilangan tersebut dapat menimbulkan kesedihan mendalam, kecemasan, rasa bersalah, atau perasaan hampa. Pada pasien yang rentan, kondisi ini dapat memperburuk gangguan jiwa yang sudah ada atau memicu munculnya halusinasi. Dalam pengkajian, perawat perlu menggali apakah pasien pernah mengalami peristiwa kehilangan yang bermakna, bagaimana respons pasien terhadap peristiwa tersebut, serta apakah setelah kejadian itu pasien mulai menunjukkan perubahan perilaku atau gejala halusinasi.

Pengalaman tidak menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari juga dapat menjadi latar belakang munculnya halusinasi. Pengalaman tersebut dapat berupa konflik berkepanjangan, kegagalan, tekanan pekerjaan, masalah ekonomi, perundungan, kekerasan dalam rumah tangga, atau perlakuan diskriminatif. Pengalaman yang terus-menerus menekan dapat menyebabkan pasien merasa tidak berdaya dan kehilangan kemampuan untuk menghadapi masalah secara adaptif. Jika kondisi ini berlangsung lama, pasien dapat mengalami penurunan fungsi psikologis, menarik diri, mudah curiga, dan akhirnya mengalami gangguan persepsi. Oleh karena itu, pengkajian psikologis pada pasien halusinasi perlu dilakukan secara hati-hati, empatik, dan tidak menghakimi agar pasien merasa aman untuk menceritakan pengalaman hidupnya.

Faktor predisposisi sosial juga sangat berpengaruh terhadap muncul dan berulangnya halusinasi. Manusia membutuhkan dukungan sosial untuk mempertahankan kesehatan jiwa. Kurangnya dukungan keluarga, hubungan sosial yang buruk, penolakan dari lingkungan, stigma terhadap gangguan jiwa, serta

isolasi sosial dapat membuat pasien semakin rentan mengalami gangguan persepsi. Keluarga yang tidak memahami kondisi pasien dapat memberikan respons yang kurang tepat, seperti memarahi, mengucilkan, mengabaikan, atau menganggap pasien sengaja berperilaku aneh. Sikap seperti ini dapat memperburuk perasaan kesepian, tidak berharga, dan tidak aman pada pasien. Akibatnya, pasien semakin menarik diri dan lebih banyak berinteraksi dengan pengalaman internalnya, termasuk halusinasi.

Isolasi sosial merupakan faktor sosial yang sering berkaitan erat dengan halusinasi. Pasien yang jarang berinteraksi dengan orang lain, tidak memiliki teman bicara, atau merasa ditolak oleh keluarga cenderung lebih banyak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ketika pasien tidak mendapatkan rangsangan sosial yang sehat, stimulus internal dapat menjadi lebih dominan. Pada kondisi ini, pasien dapat lebih sering mendengar suara, berbicara sendiri, atau merasa ditemani oleh halusinasinya. Isolasi sosial juga dapat menghambat pasien dalam mencari bantuan ketika gejala mulai muncul. Oleh karena itu, perawat perlu mengkaji kualitas hubungan pasien dengan keluarga, teman, tetangga, dan lingkungan sosialnya.

Faktor presipitasi adalah faktor pencetus yang dapat memicu munculnya halusinasi atau memperberat gejala yang sebelumnya sudah ada. Salah satu faktor presipitasi yang paling sering adalah stres berat. Stres dapat berasal dari berbagai sumber, seperti masalah keluarga, tekanan ekonomi, konflik pekerjaan, kehilangan orang terdekat, penyakit fisik, atau perubahan hidup yang mendadak. Pada individu yang memiliki kerentanan biologis, psikologis, atau sosial, stres berat dapat melemahkan kemampuan adaptasi dan memicu munculnya gejala gangguan jiwa. Halusinasi dapat muncul ketika pasien tidak mampu lagi mengelola tekanan yang dialami. Misalnya, pasien yang sebelumnya stabil dapat kembali mendengar suara setelah mengalami tekanan emosional berat atau peristiwa yang sangat mengganggu.

Konflik keluarga juga merupakan faktor presipitasi yang penting. Keluarga seharusnya menjadi sumber dukungan, tetapi pada beberapa kondisi justru menjadi sumber stres bagi pasien. Pertengkaran, komunikasi yang buruk, tuntutan berlebihan, kekerasan verbal, penolakan, atau kurangnya perhatian dapat memperburuk kondisi pasien. Pasien dengan gangguan jiwa sering membutuhkan suasana yang tenang, dukungan emosional, dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika lingkungan keluarga penuh konflik, pasien dapat merasa terancam, tidak diterima, atau tidak aman. Kondisi ini dapat memicu kecemasan, kemarahan, kecurigaan, dan memperkuat pengalaman halusinatif. Dalam pengkajian, perawat perlu menilai pola komunikasi keluarga, hubungan

antaranggota keluarga, serta adanya konflik yang mungkin menjadi pencetus kekambuhan.

Putus obat atau ketidakpatuhan terhadap pengobatan merupakan faktor presipitasi yang sangat sering menyebabkan kekambuhan halusinasi. Pada pasien yang telah mendapatkan terapi farmakologis, obat berperan membantu menstabilkan gejala dan mengurangi gangguan persepsi. Ketika pasien menghentikan obat tanpa arahan tenaga kesehatan, mengurangi dosis sendiri, lupa minum obat, atau menolak kontrol, gejala dapat muncul kembali. Alasan putus obat dapat bermacam-macam, seperti merasa sudah sembuh, tidak nyaman dengan efek samping, kurang dukungan keluarga, tidak memiliki biaya, atau kurang memahami pentingnya pengobatan jangka panjang. Oleh karena itu, perawat perlu mengkaji riwayat penggunaan obat, kepatuhan pasien, efek samping yang dirasakan, serta dukungan keluarga dalam mengawasi pengobatan.

Penyalahgunaan zat juga dapat menjadi pencetus halusinasi. Zat seperti alkohol, narkotika, obat-obatan terlarang, atau zat psikoaktif tertentu dapat memengaruhi fungsi otak dan mengganggu persepsi. Pada beberapa pasien, penggunaan zat dapat menimbulkan halusinasi secara langsung, sedangkan pada pasien dengan riwayat gangguan jiwa, penyalahgunaan zat dapat memperberat gejala dan meningkatkan risiko kekambuhan. Selain itu, penggunaan zat dapat menurunkan kemampuan pasien mengontrol diri, meningkatkan impulsivitas, dan memperbesar risiko perilaku agresif. Dalam pengkajian, perawat perlu menanyakan riwayat penggunaan zat secara hati-hati dan tidak menghakimi agar pasien atau keluarga bersedia memberikan informasi yang jujur.

Kemampuan koping yang tidak efektif memiliki hubungan yang sangat erat dengan munculnya halusinasi. Koping adalah cara individu menghadapi tekanan, masalah, atau perubahan dalam hidup. Koping yang efektif membantu seseorang mengelola stres secara sehat, misalnya dengan berbicara kepada orang terpercaya, mencari solusi, berdoa, melakukan aktivitas positif, atau meminta bantuan tenaga kesehatan. Sebaliknya, koping yang tidak efektif dapat berupa menarik diri, menyangkal masalah, marah berlebihan, menyalahkan orang lain, menggunakan zat, berhenti minum obat, atau membiarkan masalah tanpa penyelesaian. Pada pasien yang memiliki kerentanan terhadap gangguan jiwa, koping yang tidak efektif dapat membuat stres semakin menumpuk dan akhirnya memicu munculnya halusinasi.

Pasien dengan halusinasi sering kali mengalami kesulitan dalam mengenali tanda awal kekambuhan dan tidak memiliki strategi yang tepat untuk mengendalikan gejala. Ketika suara atau bayangan mulai muncul, pasien mungkin merasa takut, bingung, atau percaya sepenuhnya pada halusinasi tersebut. Jika

pasien tidak memiliki koping yang baik, ia dapat mengikuti isi halusinasi, menarik diri, menjadi agresif, atau menolak bantuan. Oleh karena itu, pengkajian kemampuan koping harus mencakup cara pasien menghadapi stres, cara pasien mengontrol halusinasi, aktivitas yang biasa dilakukan saat gejala muncul, serta siapa orang yang dapat dihubungi ketika pasien membutuhkan bantuan. Data ini penting untuk menyusun intervensi keperawatan yang berfokus pada peningkatan kemampuan pasien mengelola halusinasi.

Hubungan antara faktor predisposisi, faktor presipitasi, dan koping dapat dipahami sebagai proses yang saling berkaitan. Faktor predisposisi membuat pasien lebih rentan, faktor presipitasi memicu munculnya gejala, sedangkan kemampuan koping menentukan bagaimana pasien merespons tekanan dan gejala yang muncul. Misalnya, seseorang memiliki riwayat keluarga dengan gangguan jiwa dan pernah mengalami trauma masa kecil. Selama hidupnya, ia mungkin masih dapat berfungsi cukup baik. Namun, ketika mengalami konflik keluarga berat, berhenti minum obat, dan tidak memiliki dukungan sosial, halusinasi dapat muncul atau kambuh. Jika pasien tidak memiliki koping yang efektif, gejala dapat semakin berat dan menimbulkan risiko terhadap keselamatan diri maupun orang lain.

Dalam keperawatan jiwa, pengkajian faktor predisposisi dan presipitasi tidak bertujuan untuk mencari kesalahan pasien atau keluarga, tetapi untuk memahami latar belakang masalah secara menyeluruh. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, perawat dapat membantu pasien dan keluarga mengenali penyebab kekambuhan, mengurangi faktor pencetus, memperkuat dukungan sosial, meningkatkan kepatuhan pengobatan, dan mengembangkan strategi koping yang lebih sehat. Pengkajian yang mendalam juga membantu perawat menyusun intervensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasien, baik melalui edukasi, komunikasi terapeutik, latihan mengontrol halusinasi, pelibatan keluarga, maupun kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya.

faktor predisposisi dan presipitasi halusinasi merupakan bagian penting dalam pemahaman terhadap kondisi pasien. Faktor biologis, psikologis, sosial, dan spiritual dapat membentuk kerentanan, sedangkan stres berat, konflik keluarga, putus obat, dan penyalahgunaan zat dapat menjadi pemicu munculnya gejala. Kemampuan koping yang tidak efektif dapat memperburuk kondisi pasien karena pasien tidak mampu menghadapi tekanan dan mengontrol halusinasi secara adaptif. Oleh sebab itu, perawat perlu melakukan pengkajian yang komprehensif, empatik, dan sistematis agar dapat membantu pasien mencapai kondisi yang lebih stabil, aman, dan mampu berfungsi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

F. Pengkajian Status Mental pada Pasien Halusinasi

Pengkajian status mental merupakan bagian penting dalam pengkajian keperawatan jiwa karena membantu perawat memahami kondisi psikologis, emosional, kognitif, dan perilaku pasien saat dilakukan pemeriksaan. Pada pasien dengan halusinasi, pengkajian status mental tidak hanya bertujuan mengetahui ada atau tidaknya gangguan persepsi, tetapi juga menilai bagaimana halusinasi memengaruhi penampilan, cara berbicara, suasana perasaan, proses pikir, kemampuan memahami realitas, orientasi, daya ingat, konsentrasi, kemampuan mengambil keputusan, dan daya tilik diri pasien. Pemeriksaan ini perlu dilakukan secara sistematis, hati-hati, dan terapeutik agar data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi pasien. Perawat harus memperhatikan bahwa pasien dengan halusinasi sering kali tidak langsung menceritakan pengalaman halusinasinya karena merasa takut, malu, curiga, atau menganggap pengalaman tersebut benar-benar nyata. Oleh sebab itu, pengkajian status mental dilakukan melalui kombinasi wawancara, observasi perilaku, komunikasi terapeutik, serta informasi pendukung dari keluarga atau rekam medis.

Penampilan umum pasien menjadi aspek awal yang dapat diamati oleh perawat saat pertama kali bertemu pasien. Penampilan umum mencerminkan kemampuan pasien dalam merawat diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mempertahankan fungsi sehari-hari. Pada pasien dengan halusinasi, penampilan dapat bervariasi. Sebagian pasien tampak rapi dan mampu menjaga kebersihan diri, tetapi sebagian lainnya terlihat kurang terawat, pakaian tidak sesuai, rambut tidak disisir, badan berbau, kuku panjang, atau tampak tidak memperhatikan kebersihan diri. Kondisi ini dapat terjadi karena pasien terlalu fokus pada pengalaman halusinasinya sehingga mengabaikan kebutuhan dasar, seperti mandi, mengganti pakaian, makan, atau beristirahat. Penurunan perawatan diri juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya motivasi, gangguan konsentrasi, rasa takut, atau perintah halusinasi yang membuat pasien enggan melakukan aktivitas tertentu.

Cara berpakaian juga perlu diperhatikan dalam pengkajian status mental. Perawat dapat menilai apakah pakaian pasien bersih, sesuai ukuran, sesuai cuaca, sesuai situasi, dan digunakan dengan benar. Pada pasien dengan gangguan jiwa, termasuk pasien halusinasi, kadang ditemukan cara berpakaian yang tidak sesuai, misalnya memakai pakaian berlapis-lapis saat cuaca panas, mengenakan pakaian yang tidak serasi, atau tidak peduli terhadap penampilan. Hal ini tidak boleh langsung dinilai sebagai kemalasan, tetapi perlu dipahami sebagai kemungkinan akibat gangguan proses pikir, penurunan perhatian terhadap diri, atau pengaruh halusinasi. Misalnya, pasien mungkin mengenakan pakaian tertentu karena merasa

diperintah oleh suara yang didengarnya, atau menolak mengganti pakaian karena merasa takut terjadi sesuatu jika ia melakukannya. Oleh karena itu, observasi penampilan harus selalu dikaitkan dengan hasil wawancara dan data lain yang ditemukan.

Kontak mata pasien juga menjadi bagian penting dalam pengkajian. Kontak mata dapat menggambarkan tingkat kenyamanan, kecemasan, kecurigaan, atau kemampuan pasien berinteraksi. Pasien dengan halusinasi dapat menunjukkan kontak mata yang kurang, sering menunduk, melihat ke arah lain, atau tampak tidak fokus saat diajak bicara. Hal ini dapat terjadi karena perhatian pasien sedang tertuju pada stimulus internal, seperti suara atau bayangan yang hanya dirasakan oleh pasien. Ada pula pasien yang tampak menatap tajam, curiga, atau waspada terhadap orang di sekitarnya. Kontak mata yang tidak stabil dapat menjadi tanda bahwa pasien merasa tidak aman, sedang cemas, atau terganggu oleh halusinasi. Perawat perlu mengamati apakah pasien mampu mempertahankan kontak mata secara wajar, apakah pasien sering menoleh saat berbicara, atau apakah pasien tampak seperti sedang memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain.

Pembicaraan pasien merupakan aspek penting berikutnya dalam pengkajian status mental. Cara pasien berbicara dapat memberikan gambaran mengenai kondisi emosi, proses pikir, dan tingkat gangguan persepsi yang dialami. Pada pasien dengan halusinasi, pembicaraan dapat tampak cepat, lambat, terputus-putus, tidak relevan, atau sulit dipahami. Pembicaraan yang cepat dapat muncul ketika pasien sedang gelisah, cemas, takut, atau berada dalam kondisi emosi yang meningkat. Sebaliknya, pembicaraan yang lambat dapat menunjukkan adanya penurunan energi, depresi, ketakutan, atau hambatan dalam proses berpikir. Pasien juga dapat berhenti berbicara tiba-tiba karena mendengar suara halusinasi, kemudian tampak diam sejenak seperti sedang menyimak sesuatu. Dalam kondisi ini, perawat perlu mengamati apakah perubahan pola bicara terjadi bersamaan dengan perilaku seperti menoleh, bergumam, atau menjawab sesuatu yang tidak didengar orang lain.

Pembicaraan yang tidak relevan atau terputus-putus dapat menunjukkan adanya gangguan proses pikir. Pasien mungkin menjawab pertanyaan dengan jawaban yang tidak sesuai, berpindah dari satu topik ke topik lain tanpa hubungan yang jelas, atau sulit menyelesaikan satu kalimat. Pada pasien dengan halusinasi, gangguan ini dapat terjadi karena pikiran pasien terganggu oleh suara atau pengalaman persepsi yang muncul. Misalnya, ketika perawat bertanya tentang pola tidur, pasien tiba-tiba menjawab tentang suara yang memanggilnya atau tentang orang yang dianggap mengawasinya. Pembicaraan seperti ini perlu dikaji dengan sabar. Perawat tidak boleh langsung memotong atau memaksa pasien

mengikuti alur pembicaraan secara keras, tetapi dapat mengarahkan pasien kembali ke topik dengan kalimat sederhana dan tenang. Kemampuan perawat menjaga komunikasi tetap terarah sangat penting agar data pengkajian tetap dapat diperoleh tanpa membuat pasien merasa tertekan.

Mood dan afek pasien juga harus dikaji secara mendalam. Mood adalah suasana perasaan yang dirasakan pasien secara subjektif, sedangkan afek adalah ekspresi emosi yang tampak dari luar dan dapat diamati oleh perawat. Pada pasien dengan halusinasi, mood dapat berupa cemas, takut, sedih, marah, bingung, atau merasa terancam. Perasaan tersebut biasanya berkaitan erat dengan isi halusinasi. Jika pasien mendengar suara yang mengejek atau mengancam, pasien dapat merasa takut, marah, atau tidak aman. Jika halusinasi muncul terus-menerus, pasien dapat merasa lelah, putus asa, atau tidak berdaya. Oleh karena itu, perawat perlu menanyakan secara terapeutik bagaimana perasaan pasien ketika halusinasi muncul, apakah pasien merasa terganggu, takut, marah, atau justru merasa ditemani oleh suara tersebut.

Afek pasien dapat tampak sesuai atau tidak sesuai dengan situasi. Afek yang sesuai berarti ekspresi emosi pasien sejalan dengan isi pembicaraan atau keadaan yang dialami. Misalnya, pasien tampak takut ketika menceritakan suara yang mengancamnya. Namun, pada beberapa pasien, afek dapat tampak datar, yaitu ekspresi emosi sangat terbatas, wajah kurang menunjukkan perubahan, suara monoton, dan respons emosional tampak berkurang. Afek juga dapat labil, yaitu perubahan emosi terjadi cepat dan tidak stabil, misalnya pasien tiba-tiba tertawa, kemudian marah, lalu menangis. Pada pasien dengan halusinasi, afek labil dapat terjadi karena pasien merespons stimulus internal yang berubah-ubah. Perawat perlu membedakan apakah ekspresi emosi pasien berkaitan dengan percakapan nyata atau dengan halusinasi yang sedang dialami. Pengkajian afek membantu perawat memahami tingkat gangguan emosi dan kebutuhan pendekatan yang lebih aman serta menenangkan.

Proses pikir merupakan cara pasien menghubungkan ide, menyusun pikiran, dan menyampaikan isi pikirannya. Pada pasien dengan halusinasi, proses pikir dapat menjadi terganggu karena perhatian pasien terpecah antara realitas dan pengalaman halusinatif. Perawat dapat mengamati apakah alur pikir pasien logis, terarah, mudah diikuti, atau justru kacau dan tidak berhubungan. Gangguan proses pikir dapat tampak dalam bentuk pembicaraan yang melompat-lompat, jawaban yang tidak sesuai pertanyaan, pengulangan kata tertentu, atau kesulitan menyampaikan maksud dengan jelas. Bila pasien sering berhenti berbicara seolah-olah mendengarkan sesuatu, hal ini dapat menunjukkan bahwa halusinasi sedang memengaruhi proses pikirnya. Pengkajian proses pikir penting karena akan

membantu perawat menentukan apakah pasien mampu memahami instruksi, mengikuti terapi, dan mengambil keputusan secara aman.

Isi pikir pasien juga perlu dikaji karena halusinasi sering berkaitan dengan keyakinan tertentu yang menyertai pengalaman persepsi. Isi pikir mencakup apa yang dipikirkan pasien, termasuk adanya kecurigaan, ketakutan, ide bersalah, ide tidak berharga, atau keyakinan yang tidak sesuai kenyataan. Pada pasien dengan halusinasi, isi pikir dapat dipengaruhi oleh suara atau bayangan yang dialami. Misalnya, pasien mendengar suara yang mengatakan bahwa dirinya akan disakiti, kemudian pasien menjadi yakin bahwa orang lain berniat jahat kepadanya. Dalam kondisi ini, halusinasi dapat memperkuat kecurigaan atau waham. Perawat perlu menanyakan dengan hati-hati apakah pasien memiliki pikiran tertentu yang mengganggu, apakah pasien merasa ada yang mengancam, apakah pasien merasa diperintah melakukan sesuatu, atau apakah pasien memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Pengkajian isi pikir sangat penting untuk menilai risiko keselamatan.

Persepsi sensori merupakan aspek utama yang harus dikaji pada pasien dengan halusinasi. Pengkajian persepsi bertujuan mengetahui jenis pengalaman halusinasi yang dialami pasien, apakah berupa suara, penglihatan, bau, rasa, sentuhan, atau sensasi tubuh tertentu. Pada halusinasi pendengaran, perawat perlu menggali apakah pasien mendengar suara manusia, bisikan, perintah, percakapan, atau suara lain yang tidak didengar orang lain. Perawat juga perlu mengetahui isi suara tersebut, apakah suara bersifat menyenangkan, mengganggu, mengejek, mengancam, atau memerintah. Halusinasi yang berisi perintah untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain harus dikaji dengan sangat serius karena dapat meningkatkan risiko perilaku kekerasan atau bunuh diri. Dalam pengkajian, perawat dapat menggunakan pertanyaan yang sederhana dan tidak menghakimi, misalnya menanyakan apakah pasien pernah mendengar suara saat tidak ada orang lain di sekitar, kapan suara itu muncul, dan apa yang biasanya pasien lakukan saat suara tersebut datang.

Pada halusinasi penglihatan, perawat perlu menggali apakah pasien melihat bayangan, orang, hewan, cahaya, atau bentuk tertentu yang tidak terlihat oleh orang lain. Perawat juga perlu menilai apakah penglihatan tersebut membuat pasien takut, marah, atau merasa terancam. Pada halusinasi penciuman dan pengecapan, pasien mungkin mencium bau tertentu atau merasakan rasa tertentu tanpa sumber nyata, yang dapat memengaruhi pola makan dan minum. Pada halusinasi perabaan, pasien dapat merasa disentuh, digigit, ditusuk, atau merasakan sesuatu bergerak di tubuhnya. Semua bentuk halusinasi ini perlu dikaji karena masing-masing dapat berdampak berbeda terhadap perilaku pasien.

Pengkajian persepsi tidak hanya mencatat jenis halusinasi, tetapi juga frekuensi, durasi, waktu kemunculan, pencetus, respons pasien, serta kemampuan pasien mengontrol halusinasi.

Orientasi pasien juga perlu diperiksa dalam pengkajian status mental. Orientasi mencakup kemampuan pasien mengenali waktu, tempat, orang, dan situasi. Pasien yang orientasinya baik mampu menyebutkan hari, tanggal, waktu, lokasi tempat ia berada, mengenali orang di sekitarnya, dan memahami situasi yang sedang terjadi. Pada pasien dengan halusinasi, orientasi dapat tetap baik, tetapi pada kondisi tertentu dapat terganggu, terutama jika pasien sangat tenggelam dalam pengalaman halusinatif atau mengalami gangguan jiwa berat. Misalnya, pasien mungkin tidak menyadari bahwa ia sedang berada di ruang perawatan karena merasa sedang berada di tempat lain sesuai isi halusinasinya. Gangguan orientasi dapat meningkatkan risiko keselamatan karena pasien mungkin tidak memahami lingkungan, tidak mengenali perawat, atau salah menafsirkan situasi.

Orientasi terhadap orang juga penting dikaji karena pasien yang mengalami kecurigaan atau halusinasi mengancam dapat salah mengenali orang di sekitarnya. Pasien mungkin menganggap perawat sebagai orang yang akan menyakiti dirinya atau menganggap pasien lain sebagai sumber ancaman. Sementara itu, orientasi terhadap situasi menggambarkan apakah pasien memahami alasan dirinya berada di fasilitas kesehatan dan tujuan perawatan yang diberikan. Jika pasien tidak memahami situasi, ia mungkin menolak terapi, menolak minum obat, atau mencoba pergi dari tempat perawatan. Oleh sebab itu, perawat perlu mengkaji orientasi dengan cara yang sederhana dan tidak membuat pasien merasa diuji secara berlebihan. Pengkajian orientasi juga membantu perawat menentukan tingkat kebutuhan pengawasan dan pendampingan pasien.

Daya ingat atau memori pasien juga menjadi bagian penting dalam pengkajian status mental. Perawat perlu menilai apakah pasien mampu mengingat kejadian masa lalu, kejadian baru-baru ini, dan informasi yang baru saja diberikan. Pada pasien dengan halusinasi, daya ingat dapat terganggu apabila pasien sulit berkonsentrasi atau terlalu fokus pada stimulus internal. Misalnya, pasien mungkin lupa instruksi yang baru diberikan karena pada saat yang sama ia sedang mendengar suara halusinasi. Gangguan daya ingat dapat memengaruhi kepatuhan pasien dalam minum obat, mengikuti jadwal kontrol, atau menjalankan latihan mengontrol halusinasi. Oleh karena itu, perawat perlu menilai kemampuan pasien mengingat informasi penting dan menyesuaikan edukasi dengan kemampuan pasien.

Konsentrasi pasien juga perlu dinilai karena halusinasi sering mengganggu perhatian. Pasien dapat tampak mudah teralihkan, sulit mengikuti pembicaraan, tidak mampu menjawab pertanyaan dengan tepat, atau memerlukan pengulangan instruksi. Gangguan konsentrasi dapat menyebabkan pasien sulit mengikuti aktivitas terapi kelompok, latihan keterampilan, atau edukasi kesehatan. Dalam pengkajian, perawat dapat menilai konsentrasi melalui percakapan sehari-hari, kemampuan pasien mengikuti arahan sederhana, atau kemampuan pasien mempertahankan fokus selama wawancara. Bila pasien tampak teralihkan oleh halusinasi, perawat dapat membantu mengarahkan kembali perhatian pasien pada realitas, misalnya dengan memanggil nama pasien, berbicara singkat, dan menggunakan kalimat yang jelas.

Kemampuan menilai atau judgment adalah kemampuan pasien dalam membuat keputusan yang sesuai dengan kenyataan dan mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Pada pasien dengan halusinasi, kemampuan menilai dapat terganggu terutama jika pasien sangat percaya pada isi halusinasi. Misalnya, pasien yang mendengar suara menyuruhnya menolak makan dapat benar-benar menolak makan karena menganggap suara tersebut sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Pasien yang mendengar suara mengancam dapat menyerang orang lain karena merasa sedang membela diri. Pengkajian kemampuan menilai penting untuk mengetahui apakah pasien mampu mengambil keputusan yang aman, memahami konsekuensi tindakan, dan menolak perintah halusinasi yang berbahaya. Jika kemampuan menilai pasien buruk, perawat perlu meningkatkan pengawasan dan melibatkan tim kesehatan untuk mencegah risiko.

Daya tilik diri atau insight merupakan kemampuan buruk, perawat perlu meningkatkan pengawasan dan mel pasien memahami bahwa dirinya sedang mengalami masalah kesehatan jiwa dan membutuhkan bantuan. Pada pasien dengan halusinasi, daya tilik diri dapat bervariasi. Ada pasien yang menyadari bahwa suara yang didengarnya merupakan gejala penyakit dan berusaha mengontrolnya. Namun, ada juga pasien yang tidak menyadari bahwa pengalaman tersebut merupakan halusinasi dan meyakini sepenuhnya bahwa suara atau bayangan itu nyata. Daya tilik diri yang rendah dapat menyebabkan pasien menolak pengobatan, tidak mau kontrol, tidak percaya pada tenaga kesehatan, atau tidak mau mengikuti latihan mengontrol halusinasi. Sebaliknya, daya tilik diri yang baik dapat membantu pasien lebih kooperatif dalam perawatan dan lebih mampu menggunakan strategi koping yang diajarkan.

Pengkajian status mental pada pasien halusinasi harus dilakukan secara berkesinambungan karena kondisi pasien dapat berubah dari waktu ke waktu. Halusinasi dapat meningkat saat pasien stres, lelah, kurang tidur, mengalami

konflik, atau tidak minum obat. Sebaliknya, gejala dapat berkurang ketika pasien merasa aman, mendapatkan dukungan, mengikuti terapi, dan mampu menggunakan teknik mengontrol halusinasi. Oleh karena itu, pengkajian status mental tidak cukup dilakukan satu kali, tetapi perlu diulang sesuai perkembangan kondisi pasien. Perawat harus mencatat perubahan penampilan, pembicaraan, mood, afek, proses pikir, persepsi, orientasi, memori, konsentrasi, kemampuan menilai, dan daya tilik diri secara objektif dalam dokumentasi keperawatan.

Pengkajian status mental pada pasien dengan halusinasi merupakan proses yang menyeluruh untuk memahami keadaan jiwa pasien saat ini. Setiap aspek yang dikaji saling berhubungan dan memberikan gambaran mengenai tingkat gangguan yang dialami pasien. Penampilan umum dapat menunjukkan kemampuan perawatan diri, pembicaraan mencerminkan proses pikir, mood dan afek menggambarkan kondisi emosi, persepsi sensori menunjukkan pengalaman halusinasi, orientasi menggambarkan kemampuan mengenali realitas, sedangkan daya ingat, konsentrasi, judgment, dan insight menunjukkan fungsi kognitif serta kemampuan pasien dalam memahami kondisinya. Melalui pengkajian yang teliti, empatik, dan sistematis, perawat dapat menentukan masalah keperawatan dengan lebih tepat, menilai risiko keselamatan, serta merencanakan intervensi yang sesuai untuk membantu pasien mengontrol halusinasi dan meningkatkan fungsi kehidupannya.

G. Pengkajian Terfokus pada Halusinasi

Pengkajian terfokus pada halusinasi merupakan bagian penting dalam pengkajian keperawatan jiwa karena bertujuan untuk menggali secara lebih mendalam pengalaman halusinasi yang dialami pasien. Setelah perawat memperoleh gambaran umum mengenai status mental pasien, pengkajian perlu diarahkan secara khusus pada karakteristik halusinasi, mulai dari jenis, isi, waktu kemunculan, frekuensi, durasi, pencetus, respons pasien, hingga cara pasien mengatasi halusinasi tersebut. Pengkajian ini harus dilakukan dengan pendekatan terapeutik, tenang, empatik, dan tidak menghakimi, karena pasien sering kali merasa takut, malu, atau curiga ketika diminta menceritakan pengalaman yang tidak dialami oleh orang lain. Oleh karena itu, perawat perlu membangun hubungan saling percaya terlebih dahulu agar pasien merasa aman untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya.

Hal pertama yang perlu dikaji adalah jenis halusinasi yang dialami pasien. Halusinasi dapat terjadi pada berbagai sistem sensori, seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap, perabaan, maupun sensasi tubuh tertentu. Pada pasien gangguan jiwa, halusinasi pendengaran merupakan jenis yang paling

sering ditemukan. Pasien dapat mengatakan bahwa ia mendengar suara orang berbicara, memanggil namanya, memberi komentar, mengejek, mengancam, atau menyuruh melakukan sesuatu. Selain itu, pasien juga dapat mengalami halusinasi penglihatan, misalnya melihat bayangan, sosok orang, cahaya, hewan, atau benda tertentu yang sebenarnya tidak ada. Halusinasi penciuman dapat berupa mencium bau busuk, bau asap, atau bau tertentu tanpa sumber nyata, sedangkan halusinasi pengecapan dapat membuat pasien merasa ada rasa pahit, asam, logam, atau rasa aneh di mulut. Halusinasi perabaan dapat membuat pasien merasa disentuh, digigit, ditusuk, atau ada sesuatu yang merayap di tubuhnya.

Pengkajian jenis halusinasi penting dilakukan karena setiap jenis halusinasi dapat menimbulkan respons dan risiko yang berbeda. Pasien dengan halusinasi pendengaran yang berisi perintah mungkin lebih berisiko melakukan tindakan tertentu sesuai suara yang didengarnya. Sementara itu, pasien dengan halusinasi pengecapan atau penciuman dapat menolak makan karena merasa makanan berbau atau berasa tidak wajar. Pasien dengan halusinasi perabaan dapat terus-menerus menggaruk kulit atau memukul bagian tubuh tertentu karena merasa ada sesuatu yang mengganggu. Dengan mengetahui jenis halusinasi yang dialami, perawat dapat memahami bentuk gangguan persepsi pasien dan menentukan pendekatan pengkajian serta intervensi yang lebih sesuai.

Selain jenis halusinasi, perawat perlu menggali isi halusinasi secara hati-hati. Isi halusinasi merupakan hal yang sangat penting karena dapat menunjukkan tingkat bahaya dan dampaknya terhadap perilaku pasien. Pada halusinasi pendengaran, isi suara dapat berupa suara yang memanggil nama pasien, mengomentari tindakan pasien, mengejek, menyalahkan, mengancam, atau menyuruh pasien melakukan sesuatu. Isi halusinasi yang bersifat netral mungkin hanya membuat pasien terganggu, tetapi isi halusinasi yang bersifat mengancam atau memerintah dapat meningkatkan risiko keselamatan. Misalnya, pasien mendengar suara yang menyuruhnya memukul orang lain, melukai diri sendiri, menolak makan, melarikan diri, atau melakukan tindakan berbahaya lainnya. Dalam kondisi seperti ini, perawat harus melakukan pengkajian risiko secara lebih mendalam.

Menggali isi halusinasi harus dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan tidak menakutkan. Perawat dapat menanyakan secara perlahan tentang apa yang didengar, dilihat, atau dirasakan pasien. Ketika pasien mengatakan mendengar suara, perawat dapat menggali lebih lanjut mengenai suara tersebut, apakah suara itu dikenal atau tidak, apakah suara laki-laki atau perempuan, apakah suara tersebut berbicara langsung kepada pasien, dan apa yang dikatakan suara tersebut. Namun, perawat perlu menjaga sikap agar tidak terlihat terlalu ingin tahu

secara berlebihan atau membuat pasien merasa diinterogasi. Tujuan pengkajian bukan untuk memperkuat keyakinan pasien terhadap halusinasinya, melainkan untuk memahami pengalaman pasien dan menilai risiko yang mungkin muncul.

Waktu munculnya halusinasi juga perlu dikaji secara rinci. Perawat perlu mengetahui apakah halusinasi lebih sering muncul pada pagi, siang, sore, malam, atau waktu tertentu. Beberapa pasien mengalami halusinasi lebih sering pada malam hari ketika suasana sepi, menjelang tidur, atau saat pasien sedang sendiri. Ada juga pasien yang mengalami halusinasi ketika berada dalam situasi tertentu, misalnya setelah bertengkar, ketika merasa tertekan, atau ketika tidak melakukan aktivitas. Informasi mengenai waktu kemunculan halusinasi sangat penting karena dapat membantu perawat dan pasien mengenali pola munculnya gejala. Jika pola tersebut dapat diketahui, perawat dapat membantu pasien menyusun strategi pencegahan atau pengendalian sebelum halusinasi menjadi lebih kuat.

Halusinasi yang muncul saat pasien sendiri juga perlu mendapat perhatian khusus. Kesendirian dapat membuat pasien lebih fokus pada stimulus internal sehingga suara atau bayangan yang dialami terasa semakin jelas. Pasien yang tidak memiliki aktivitas atau tidak berinteraksi dengan orang lain lebih mudah tenggelam dalam pengalaman halusinasinya. Oleh karena itu, pengkajian mengenai waktu munculnya halusinasi harus dikaitkan dengan aktivitas pasien sehari-hari. Perawat perlu mengetahui apakah halusinasi muncul ketika pasien sedang melamun, setelah bangun tidur, saat menjelang tidur, ketika berada di kamar sendiri, atau ketika tidak ada orang yang mengajak berbicara. Data ini dapat menjadi dasar bagi perawat untuk merancang kegiatan terstruktur sebagai salah satu cara membantu pasien mengalihkan perhatian dari halusinasi.

Frekuensi halusinasi merupakan aspek berikutnya yang perlu dikaji. Frekuensi menunjukkan seberapa sering halusinasi muncul dalam periode tertentu. Ada pasien yang mengalami halusinasi hanya sesekali, misalnya satu atau dua kali dalam sehari. Ada pula pasien yang mengalami halusinasi sangat sering, bahkan hampir sepanjang hari. Semakin sering halusinasi muncul, semakin besar kemungkinan halusinasi tersebut mengganggu aktivitas, konsentrasi, istirahat, hubungan sosial, dan kemampuan pasien dalam merawat diri. Frekuensi halusinasi juga dapat menggambarkan tingkat keparahan gejala dan menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan pasien setelah mendapatkan intervensi keperawatan dan terapi medis.

Selain frekuensi, durasi halusinasi juga perlu dikaji. Durasi adalah lamanya halusinasi berlangsung setiap kali muncul. Ada halusinasi yang hanya berlangsung beberapa detik atau menit, tetapi ada juga yang berlangsung lama dan sulit dihentikan. Durasi yang panjang dapat menyebabkan pasien semakin lelah secara

emosional, sulit berkonsentrasi, dan lebih sulit mengontrol diri. Misalnya, pasien yang mendengar suara selama beberapa jam mungkin menjadi sangat gelisah, marah, takut, atau kehilangan kemampuan membedakan realitas. Pengkajian durasi membantu perawat memahami seberapa besar halusinasi menguasai perhatian pasien. Perawat juga dapat menilai apakah durasi halusinasi berkurang setelah pasien menggunakan teknik tertentu, seperti menghardik halusinasi, bercakap-cakap dengan orang lain, melakukan aktivitas, atau minum obat secara teratur.

Situasi pencetus munculnya halusinasi merupakan bagian penting yang harus digali dalam pengkajian terfokus. Halusinasi sering kali muncul atau memburuk ketika pasien mengalami stres, kesepian, konflik keluarga, kurang tidur, kelelahan, cemas, marah, atau putus obat. Pada beberapa pasien, halusinasi juga dapat muncul ketika pasien merasa tidak diterima, merasa bersalah, mengalami tekanan ekonomi, atau menghadapi pengalaman yang mengingatkan pada trauma masa lalu. Dengan mengetahui pencetusnya, perawat dapat membantu pasien mengenali situasi yang perlu diwaspadai. Pengkajian pencetus juga membantu keluarga memahami kondisi pasien, sehingga keluarga dapat mengurangi situasi yang memperburuk gejala dan menciptakan lingkungan yang lebih aman serta suportif.

Situasi pencetus tidak selalu berupa peristiwa besar. Halusinasi dapat muncul karena hal-hal sederhana yang bagi pasien memiliki makna emosional tertentu. Misalnya, suasana kamar yang terlalu sepi dapat membuat pasien lebih mudah mendengar suara. Percakapan keluarga yang keras dapat ditafsirkan sebagai ancaman. Kurangnya aktivitas dapat membuat pasien semakin fokus pada pikiran dan suara yang muncul. Bahkan rasa lapar, kurang tidur, atau kelelahan fisik dapat memperburuk kemampuan pasien dalam mengontrol halusinasi. Oleh karena itu, perawat perlu menggali pencetus dengan sabar dan tidak hanya bertanya secara umum. Pengkajian harus diarahkan pada kondisi sebelum halusinasi muncul, perasaan pasien saat itu, aktivitas yang sedang dilakukan, serta kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar.

Respons pasien terhadap halusinasi juga menjadi data penting dalam pengkajian. Respons pasien dapat berbeda-beda, tergantung pada isi halusinasi, tingkat keyakinan pasien, kemampuan mengontrol diri, dan pengalaman sebelumnya. Sebagian pasien merasa takut dan berusaha menghindari halusinasi. Sebagian lainnya merasa marah, membantah suara yang didengar, atau tampak gelisah. Ada pasien yang mengikuti perintah halusinasi karena percaya bahwa suara tersebut harus dipatuhi. Ada pula pasien yang mulai mampu mengenali bahwa suara tersebut adalah gejala penyakit dan berusaha mengontrolnya.

Respons pasien ini perlu dikaji karena menunjukkan sejauh mana halusinasi memengaruhi perilaku dan keselamatan pasien.

Pasien yang takut terhadap halusinasi biasanya tampak cemas, wajah tegang, sulit tidur, sering meminta ditemani, atau menghindari tempat tertentu. Pasien yang marah terhadap halusinasi dapat terlihat berbicara keras, membentak, memaki, atau melakukan tindakan agresif terhadap lingkungan. Pasien yang mengikuti halusinasi perlu mendapat perhatian khusus karena berisiko melakukan tindakan yang membahayakan, terutama jika halusinasi bersifat memerintah. Sementara itu, pasien yang mampu mengontrol halusinasi menunjukkan tanda perkembangan positif. Misalnya, pasien mengatakan dapat mengabaikan suara, mengalihkan perhatian dengan aktivitas, berbicara dengan orang lain, atau menggunakan teknik yang telah diajarkan perawat. Pengkajian respons pasien membantu perawat menentukan tingkat kemandirian pasien dalam menghadapi halusinasi.

Cara pasien mengatasi halusinasi yang dialami juga harus dikaji secara mendalam. Setiap pasien mungkin memiliki cara yang berbeda untuk menghadapi halusinasi. Ada pasien yang berusaha menutup telinga, berteriak, tidur, menyendiri, berdoa, mendengarkan musik, berbicara dengan orang lain, melakukan aktivitas, atau minum obat. Tidak semua cara tersebut efektif atau aman. Misalnya, menyendiri mungkin membuat pasien merasa tenang sementara, tetapi dapat memperkuat halusinasi jika pasien semakin fokus pada suara yang didengar. Berteriak atau membanting barang dapat meningkatkan risiko perilaku kekerasan. Sebaliknya, bercakap-cakap dengan orang lain, melakukan aktivitas terarah, mematuhi pengobatan, dan menggunakan teknik menghardik halusinasi dapat menjadi strategi yang lebih adaptif.

Pengkajian cara mengatasi halusinasi bertujuan untuk mengetahui kemampuan koping pasien. Jika pasien sudah memiliki cara yang sehat dan efektif, perawat dapat memperkuat cara tersebut melalui dukungan dan latihan berulang. Jika pasien menggunakan cara yang kurang adaptif, perawat perlu membantu pasien mempelajari strategi yang lebih aman. Dalam keperawatan jiwa, pasien biasanya diajarkan mengenali halusinasi, menghardik halusinasi, bercakap-cakap dengan orang lain, melakukan aktivitas terjadwal, serta minum obat secara teratur. Namun, sebelum mengajarkan strategi tersebut, perawat harus mengetahui terlebih dahulu apa yang selama ini dilakukan pasien ketika halusinasi muncul. Dengan demikian, intervensi yang diberikan tidak bersifat umum semata, tetapi sesuai dengan kemampuan, kebiasaan, dan kebutuhan pasien.

Pengkajian terfokus pada halusinasi juga harus memperhatikan tingkat keyakinan pasien terhadap halusinasi. Pasien yang sepenuhnya percaya bahwa

suara atau bayangan tersebut nyata biasanya lebih sulit diarahkan dan lebih berisiko mengikuti halusinasi. Sebaliknya, pasien yang mulai menyadari bahwa halusinasi merupakan gejala yang perlu dikontrol biasanya lebih mudah diajak bekerja sama. Perawat perlu menggali apakah pasien percaya pada suara yang didengar, apakah pasien merasa harus mengikuti suara tersebut, dan apakah pasien mampu mengatakan bahwa suara itu bagian dari gejala yang dialaminya. Informasi ini sangat penting untuk menilai daya tilik diri pasien dan menentukan pendekatan edukasi yang tepat.

Dalam melakukan pengkajian terfokus, perawat harus tetap menjaga prinsip komunikasi terapeutik. Perawat perlu menunjukkan bahwa ia percaya pasien sedang mengalami sesuatu yang mengganggu, tetapi tidak membenarkan isi halusinasi sebagai kenyataan. Misalnya, perawat dapat mengatakan bahwa ia tidak mendengar suara tersebut, tetapi memahami bahwa pasien merasa takut karena suara itu terasa nyata bagi pasien. Sikap seperti ini membantu pasien merasa dihargai tanpa memperkuat halusinasi. Perawat juga perlu menghindari perdebatan dengan pasien mengenai benar atau salahnya halusinasi, karena perdebatan dapat meningkatkan kecemasan, kecurigaan, atau kemarahan pasien.

pengkajian terfokus pada halusinasi mencakup penggalan yang menyeluruh mengenai jenis, isi, waktu, frekuensi, durasi, pencetus, respons, dan cara pasien mengatasi halusinasi. Data tersebut sangat penting untuk menentukan tingkat keparahan halusinasi, risiko keselamatan, kemampuan koping, serta kebutuhan intervensi keperawatan. Pengkajian yang dilakukan secara teliti dan terapeutik akan membantu perawat memahami pengalaman pasien secara lebih mendalam, menyusun diagnosis keperawatan yang tepat, dan merancang tindakan yang sesuai untuk membantu pasien mengontrol halusinasi. Melalui pengkajian yang baik, pasien diharapkan dapat lebih mengenali gejala yang dialaminya, meningkatkan kemampuan mengendalikan halusinasi, mempertahankan orientasi realitas, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih aman serta produktif.

H. Pengkajian Risiko pada Pasien dengan Halusinasi

Pengkajian risiko pada pasien dengan halusinasi merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan jiwa karena halusinasi dapat memengaruhi cara pasien berpikir, merasakan, mengambil keputusan, dan bertindak. Pasien yang mengalami halusinasi tidak hanya menghadapi gangguan persepsi, tetapi juga dapat mengalami perubahan perilaku yang berpotensi membahayakan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Risiko ini dapat meningkat terutama apabila halusinasi yang dialami bersifat mengancam, memerintah, menakutkan, atau membuat pasien kehilangan kemampuan

membedakan antara kenyataan dan pengalaman halusinatif. Oleh karena itu, perawat harus melakukan pengkajian risiko secara menyeluruh, hati-hati, dan berkesinambungan agar dapat menentukan prioritas keselamatan dan intervensi yang tepat.

Salah satu risiko utama pada pasien dengan halusinasi adalah risiko mencederai diri sendiri. Risiko ini dapat muncul ketika pasien merasa terganggu, takut, tertekan, atau dikendalikan oleh halusinasi yang dialaminya. Misalnya, pasien mendengar suara yang menyuruhnya memukul kepala, melukai tubuh, menolak makan, melompat dari tempat tinggi, atau melakukan tindakan lain yang dapat membahayakan keselamatan dirinya. Pada beberapa kondisi, pasien tidak secara langsung berniat menyakiti diri, tetapi perilakunya tetap berisiko karena dilakukan sebagai respons terhadap halusinasi. Misalnya, pasien berlari keluar rumah karena merasa dikejar oleh suara atau bayangan tertentu, menutup telinga secara keras, membenturkan kepala untuk menghentikan suara, atau melakukan tindakan impulsif karena merasa sangat ketakutan. Dalam pengkajian, perawat perlu menanyakan secara hati-hati apakah halusinasi pernah menyuruh pasien melakukan sesuatu terhadap dirinya sendiri, apakah pasien pernah mengikuti perintah tersebut, dan apakah pasien merasa mampu menolak dorongan dari halusinasi.

Risiko mencederai diri sendiri juga dapat dipengaruhi oleh tingkat kecemasan dan tekanan emosional yang dialami pasien. Halusinasi yang muncul terus-menerus dapat membuat pasien merasa lelah, putus asa, dan kehilangan harapan. Pasien dapat merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan suara atau sensasi yang mengganggu adalah dengan menyakiti dirinya sendiri. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena pasien mungkin tidak selalu menyampaikan keinginannya secara terbuka. Perawat perlu mengamati tanda-tanda seperti pasien tampak murung, menarik diri, sering mengatakan ingin menghilang, merasa tidak berguna, menolak makan, tidak mau berbicara, atau menunjukkan luka pada tubuh. Data objektif seperti adanya benda tajam di sekitar pasien, perilaku gelisah, atau riwayat tindakan mencederai diri sebelumnya juga harus dikaji sebagai bagian dari penilaian risiko keselamatan.

Selain risiko terhadap diri sendiri, pasien dengan halusinasi juga dapat berisiko mencederai orang lain. Risiko ini dapat terjadi apabila pasien merasa terancam oleh isi halusinasi atau salah menafsirkan keberadaan orang di sekitarnya. Misalnya, pasien mendengar suara yang mengatakan bahwa orang lain akan menyakitinya, mencelakainya, atau bersekongkol melawannya. Akibatnya, pasien dapat menjadi curiga, mudah marah, defensif, dan menyerang orang lain sebagai bentuk perlindungan diri. Dalam situasi ini, tindakan agresif pasien bukan

semata-mata karena keinginan untuk menyerang, tetapi dapat muncul karena pasien benar-benar merasa dirinya sedang dalam bahaya. Oleh sebab itu, perawat perlu mengkaji apakah pasien memiliki kecurigaan terhadap orang tertentu, apakah pasien merasa terancam, apakah pasien pernah memukul atau mengancam orang lain, serta apakah halusinasi yang dialami berisi perintah untuk menyerang.

Risiko perilaku kekerasan akibat perintah halusinasi merupakan kondisi yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Halusinasi perintah adalah halusinasi yang berisi instruksi atau perintah kepada pasien untuk melakukan tindakan tertentu. Perintah tersebut dapat bersifat ringan, seperti menyuruh pasien diam atau pergi, tetapi dapat pula bersifat berbahaya, seperti menyuruh pasien memukul, membakar, menusuk, membunuh, atau melukai diri sendiri dan orang lain. Semakin kuat keyakinan pasien terhadap suara tersebut, semakin tinggi kemungkinan pasien mengikuti perintahnya. Perawat perlu mengetahui isi perintah, seberapa sering perintah muncul, seberapa kuat pasien percaya pada suara tersebut, apakah pasien merasa takut jika tidak mengikuti perintah, dan apakah pasien pernah melakukan tindakan sesuai perintah halusinasi. Pengkajian ini harus dilakukan dengan tenang, tidak menghakimi, dan tetap memperhatikan keamanan perawat serta lingkungan sekitar.

Dalam mengkaji risiko perilaku kekerasan, perawat juga perlu memperhatikan tanda-tanda perilaku yang menunjukkan peningkatan ketegangan. Pasien yang berisiko melakukan kekerasan dapat tampak gelisah, mondar-mandir, berbicara keras, mengepalkan tangan, rahang mengatup, wajah tegang, menatap tajam, mudah tersinggung, atau menolak diarahkan. Pasien juga dapat menunjukkan perilaku mengancam, seperti berkata akan memukul, merusak barang, atau mendekati orang lain dengan sikap agresif. Pada pasien dengan halusinasi, tanda-tanda ini dapat muncul bersamaan dengan respons terhadap suara yang mengganggu. Oleh karena itu, perawat perlu menggabungkan data wawancara dan observasi untuk menilai tingkat risiko. Jika pasien tampak sangat gelisah atau agresif, pengkajian harus dilakukan dengan menjaga jarak aman, menghindari konfrontasi, serta melibatkan tim kesehatan bila diperlukan.

Risiko bunuh diri juga perlu dikaji secara serius pada pasien dengan halusinasi, terutama apabila halusinasi bersifat mengancam, menyalahkan, mengejek, atau menyuruh pasien mengakhiri hidup. Pasien yang mendengar suara yang terus-menerus mengatakan bahwa dirinya tidak berguna, berdosa, harus mati, atau harus melukai diri dapat mengalami tekanan psikologis yang sangat berat. Risiko bunuh diri meningkat apabila pasien merasa tidak mampu mengendalikan halusinasi, merasa putus asa, memiliki riwayat percobaan bunuh diri, mengalami depresi, tidak memiliki dukungan sosial, atau sedang menghadapi

stres berat. Dalam pengkajian, perawat perlu menanyakan secara langsung namun tetap empatik mengenai adanya pikiran untuk mengakhiri hidup, rencana yang dimiliki, alat atau cara yang tersedia, serta seberapa besar keinginan pasien untuk melaksanakan rencana tersebut. Pertanyaan tentang bunuh diri tidak boleh dihindari karena informasi ini sangat penting untuk keselamatan pasien.

Pengkajian risiko bunuh diri harus dilakukan dengan sikap penuh empati dan tidak menghakimi. Pasien mungkin merasa takut atau malu mengungkapkan pikiran bunuh diri, sehingga perawat perlu menciptakan suasana yang aman dan mendukung. Perawat dapat mengawali dengan menanyakan perasaan pasien ketika halusinasi muncul, apakah pasien merasa sangat tertekan, apakah pernah merasa hidupnya tidak berarti, atau apakah pernah berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Apabila pasien mengungkapkan adanya pikiran bunuh diri, perawat harus menilai tingkat kedaruratan dan segera mengambil tindakan pengamanan sesuai prosedur. Lingkungan pasien perlu diperiksa agar bebas dari benda tajam, tali, obat-obatan berlebihan, atau benda lain yang dapat digunakan untuk melukai diri. Selain itu, pasien dengan risiko tinggi perlu mendapatkan pengawasan lebih intensif dan kolaborasi dengan tim kesehatan jiwa.

Halusinasi juga dapat menyebabkan risiko isolasi sosial. Pasien yang lebih fokus pada halusinasi sering kali mengurangi interaksi dengan orang lain. Ia dapat lebih banyak menyendiri, berbicara dengan suara yang didengarnya, menghindari keluarga, atau tidak tertarik mengikuti kegiatan sosial. Isolasi sosial dapat terjadi karena pasien merasa takut, malu, curiga, atau merasa bahwa orang lain tidak memahami pengalamannya. Selain itu, perilaku pasien yang tampak berbicara sendiri atau merespons stimulus yang tidak nyata sering kali membuat keluarga atau lingkungan menjauh karena tidak memahami kondisi tersebut. Jika isolasi sosial berlangsung lama, pasien dapat semakin tenggelam dalam dunia internalnya, sehingga halusinasi menjadi lebih dominan dan sulit dikontrol. Oleh karena itu, pengkajian risiko isolasi sosial perlu mencakup pola hubungan pasien, frekuensi interaksi, dukungan keluarga, kemampuan komunikasi, dan minat pasien terhadap aktivitas bersama.

Risiko isolasi sosial juga dapat memperburuk kondisi emosional pasien. Pasien yang merasa sendiri dan tidak didukung dapat mengalami penurunan harga diri, kesepian, kecemasan, dan perasaan tidak berdaya. Dalam kondisi seperti ini, halusinasi dapat menjadi seolah-olah “teman” atau sumber interaksi bagi pasien, meskipun sebenarnya bersifat mengganggu. Perawat perlu mengkaji apakah pasien lebih memilih menyendiri, apakah pasien memiliki teman bicara, apakah pasien merasa diterima oleh keluarga, dan apakah pasien pernah mengalami penolakan atau stigma dari lingkungan. Data tersebut penting untuk

merencanakan intervensi yang melibatkan keluarga, latihan interaksi sosial, serta kegiatan terstruktur yang membantu pasien kembali berhubungan dengan realitas dan lingkungan sosial.

Risiko defisit perawatan diri juga sering ditemukan pada pasien dengan halusinasi. Defisit perawatan diri terjadi ketika pasien mengalami penurunan kemampuan atau kemauan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti mandi, berpakaian, makan, berhias, buang air dengan benar, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pada pasien dengan halusinasi, penurunan perawatan diri dapat terjadi karena perhatian pasien tersita oleh suara atau bayangan yang dialaminya. Pasien dapat merasa takut pergi ke kamar mandi, menolak makan karena mendengar suara yang melarang, atau tidak peduli terhadap penampilan karena merasa tidak berharga. Gangguan tidur dan konsentrasi yang menyertai halusinasi juga dapat membuat pasien tampak lemah, tidak bertenaga, dan kurang mampu menjalankan aktivitas harian.

Dalam pengkajian risiko defisit perawatan diri, perawat perlu mengamati kebersihan tubuh, pakaian, rambut, kuku, bau badan, pola makan, pola eliminasi, dan kemampuan pasien melakukan aktivitas dasar secara mandiri. Perawat juga perlu menanyakan apakah ada halusinasi yang menghambat pasien merawat diri. Misalnya, apakah pasien mendengar suara yang melarang mandi, apakah pasien merasa ada sesuatu di kamar mandi, atau apakah pasien takut makan karena merasa makanan tidak aman. Pengkajian ini penting karena defisit perawatan diri tidak hanya berdampak pada penampilan, tetapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik, seperti infeksi kulit, gangguan nutrisi, dehidrasi, dan penurunan kondisi umum pasien.

Risiko ketidakpatuhan minum obat dan kekambuhan merupakan aspek penting lain yang harus dikaji. Banyak pasien dengan halusinasi membutuhkan pengobatan secara teratur untuk membantu mengontrol gejala. Namun, ketidakpatuhan minum obat sering terjadi karena berbagai alasan, seperti pasien merasa sudah sembuh, tidak memahami manfaat obat, mengalami efek samping, merasa bosan, lupa, tidak memiliki dukungan keluarga, atau mendengar halusinasi yang menyuruhnya berhenti minum obat. Ketika pasien tidak minum obat sesuai anjuran, gejala halusinasi dapat muncul kembali atau menjadi lebih berat. Kekambuhan yang berulang dapat menurunkan fungsi sosial, meningkatkan risiko perawatan ulang, dan memperburuk kualitas hidup pasien.

Pengkajian kepatuhan minum obat perlu dilakukan secara terbuka dan tidak menyalahkan. Perawat perlu menanyakan obat apa yang dikonsumsi pasien, kapan terakhir minum obat, apakah pernah menghentikan obat sendiri, apakah ada efek samping yang dirasakan, serta siapa yang membantu mengingatkan pasien minum

obat. Keluarga juga perlu dilibatkan karena sering kali keluarga mengetahui pola kepatuhan pasien di rumah. Selain itu, perawat perlu mengkaji pemahaman pasien tentang penyakit dan pengobatannya. Pasien dengan daya tilik diri yang rendah mungkin tidak percaya bahwa dirinya sakit, sehingga menolak obat. Pasien yang mengalami halusinasi perintah juga dapat berhenti minum obat karena suara yang didengarnya melarang. Data ini menjadi dasar untuk memberikan edukasi, meningkatkan motivasi, serta menyusun strategi agar pasien lebih patuh terhadap pengobatan.

Kekambuhan pada pasien dengan halusinasi tidak hanya dipengaruhi oleh ketidakpatuhan obat, tetapi juga oleh stres, kurang tidur, konflik keluarga, penyalahgunaan zat, dan kurangnya dukungan sosial. Oleh karena itu, pengkajian risiko kekambuhan harus mencakup tanda-tanda awal kekambuhan yang biasa muncul pada pasien. Misalnya, pasien mulai sulit tidur, lebih sering menyendiri, mudah marah, berbicara sendiri, menolak makan, atau mulai curiga terhadap orang lain. Jika tanda awal ini dikenali sejak dini, keluarga dan tenaga kesehatan dapat segera melakukan tindakan pencegahan. Perawat berperan penting dalam membantu pasien dan keluarga memahami tanda peringatan kekambuhan serta cara mencari pertolongan sebelum kondisi menjadi lebih berat.

Pengawasan lingkungan merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan pasien dengan halusinasi. Lingkungan yang aman dapat mengurangi risiko pasien melakukan tindakan berbahaya akibat pengaruh halusinasi. Perawat perlu memastikan bahwa lingkungan sekitar pasien bebas dari benda tajam, tali, korek api, pecahan kaca, obat-obatan yang tidak diawasi, atau benda lain yang dapat digunakan untuk mencederai diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, lingkungan sebaiknya tenang, tidak terlalu ramai, tidak banyak rangsangan yang membingungkan, dan mudah diawasi oleh perawat atau keluarga. Pengawasan lingkungan bukan berarti membatasi pasien secara berlebihan, tetapi bertujuan menciptakan kondisi yang aman dan mendukung pemulihan.

Pengawasan juga harus dilakukan terhadap interaksi pasien dengan orang lain. Jika pasien tampak curiga, mudah marah, atau sedang mengalami halusinasi yang mengancam, perawat perlu mengatur jarak aman dan menghindari situasi yang dapat memicu konflik. Komunikasi dengan pasien harus dilakukan dengan tenang, jelas, dan tidak provokatif. Keluarga juga perlu diberi edukasi agar tidak mengejek, membantah secara kasar, menakut-nakuti, atau memaksa pasien saat halusinasi muncul. Respons keluarga yang tidak tepat dapat meningkatkan kecemasan dan memperburuk perilaku pasien. Sebaliknya, lingkungan yang suportif dapat membantu pasien merasa lebih aman, lebih mudah diarahkan, dan lebih mampu mengontrol halusinasi.

Pengkajian risiko pada pasien dengan halusinasi harus dilakukan secara berulang karena tingkat risiko dapat berubah sesuai kondisi pasien. Pada satu waktu pasien mungkin tampak tenang, tetapi risiko dapat meningkat ketika halusinasi muncul lebih sering, isi halusinasi berubah menjadi mengancam, pasien kurang tidur, mengalami konflik, atau berhenti minum obat. Oleh karena itu, perawat harus terus memantau perubahan perilaku, emosi, pola tidur, kepatuhan obat, dan kemampuan pasien mengontrol halusinasi. Dokumentasi hasil pengkajian risiko harus ditulis secara jelas, objektif, dan lengkap agar seluruh tim kesehatan dapat memahami kondisi pasien dan menentukan tindakan yang konsisten.

Dengan demikian, pengkajian risiko pada pasien dengan halusinasi mencakup penilaian terhadap risiko mencederai diri sendiri, mencederai orang lain, perilaku kekerasan akibat perintah halusinasi, bunuh diri, isolasi sosial, defisit perawatan diri, ketidakpatuhan minum obat, serta kekambuhan. Pengkajian ini harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan data subjektif, data objektif, informasi keluarga, dan kondisi lingkungan. Perawat memiliki peran penting dalam mengenali tanda bahaya, menjaga keselamatan, memberikan edukasi, melibatkan keluarga, serta menciptakan lingkungan yang aman. Melalui pengkajian risiko yang tepat, tindakan keperawatan dapat diarahkan untuk melindungi pasien dan orang sekitar, mengurangi dampak halusinasi, serta mendukung proses pemulihan pasien secara lebih optimal.

I. Teknik Komunikasi Terapeutik dalam Pengkajian Halusinasi

Teknik komunikasi terapeutik dalam pengkajian halusinasi merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki perawat jiwa karena keberhasilan pengkajian sangat dipengaruhi oleh kemampuan perawat membangun hubungan yang aman, nyaman, dan penuh kepercayaan dengan pasien. Pasien yang mengalami halusinasi sering berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil, seperti takut, cemas, curiga, bingung, marah, atau merasa terancam. Pengalaman halusinasi yang dialami pasien terasa nyata bagi dirinya, meskipun tidak dapat dibuktikan oleh orang lain. Oleh karena itu, perawat tidak dapat melakukan pengkajian dengan cara yang kaku, memaksa, atau menghakimi. Pengkajian harus dilakukan melalui komunikasi yang terapeutik, yaitu komunikasi yang bertujuan membantu pasien merasa diterima, memahami kondisinya, mengungkapkan pengalaman yang dialami, serta perlahan-lahan mampu membedakan antara halusinasi dan kenyataan.

Langkah awal dalam komunikasi terapeutik pada pasien dengan halusinasi adalah membangun hubungan saling percaya. Hubungan saling percaya menjadi

dasar penting karena pasien dengan halusinasi sering kali sulit terbuka kepada orang lain. Sebagian pasien merasa malu menceritakan bahwa ia mendengar suara atau melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Sebagian lainnya merasa takut dianggap aneh, dimarahi, ditertawakan, atau tidak dipercaya. Bahkan pada pasien yang memiliki kecurigaan tinggi, kehadiran perawat dapat dipersepsikan sebagai ancaman. Oleh sebab itu, perawat perlu memulai komunikasi dengan sikap yang hangat, tenang, sopan, dan menghargai pasien sebagai individu. Perawat dapat memperkenalkan diri dengan jelas, menyebutkan nama pasien, menjelaskan tujuan pertemuan, serta membuat kontrak waktu yang sederhana. Misalnya, perawat dapat mengatakan bahwa ia ingin menemani pasien berbicara selama beberapa menit untuk memahami apa yang sedang pasien rasakan. Cara ini membantu pasien merasa lebih aman karena mengetahui siapa perawat, apa tujuan percakapan, dan berapa lama interaksi akan berlangsung.

Membangun hubungan saling percaya tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Pada beberapa pasien, kepercayaan baru terbentuk setelah beberapa kali interaksi. Perawat perlu konsisten dalam sikap, ucapan, dan tindakan. Jika perawat mengatakan akan kembali menemui pasien pada waktu tertentu, maka perawat sebaiknya menepati janji tersebut. Konsistensi sangat penting karena pasien dengan gangguan jiwa, terutama yang mengalami halusinasi disertai kecurigaan, mudah merasa tidak aman apabila lingkungan tidak dapat diprediksi. Perawat juga perlu menunjukkan penerimaan tanpa syarat, yaitu menerima pasien apa adanya tanpa memperlakukan atau menyalahkan. Ketika pasien merasa bahwa perawat hadir untuk membantu, bukan untuk menghakimi, pasien akan lebih mudah mengungkapkan pengalaman halusinasinya.

Dalam proses pengkajian, perawat perlu menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Pasien dengan halusinasi dapat mengalami gangguan konsentrasi karena perhatiannya terbagi antara percakapan dengan perawat dan stimulus internal yang sedang dialami. Jika perawat menggunakan kalimat yang terlalu panjang, istilah medis yang rumit, atau pertanyaan yang berlapis-lapis, pasien dapat menjadi bingung dan sulit menjawab. Oleh karena itu, pertanyaan sebaiknya disampaikan secara singkat, langsung, dan satu per satu. Misalnya, daripada bertanya panjang mengenai jenis, isi, frekuensi, dan respons halusinasi sekaligus, perawat dapat memulai dengan pertanyaan sederhana seperti, "Apakah saat ini Bapak/Ibu mendengar sesuatu?" Setelah pasien menjawab, perawat dapat melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, seperti, "Suara itu mengatakan apa?" atau "Kapan biasanya suara itu muncul?" Pendekatan bertahap membantu pasien lebih mudah memahami pertanyaan dan memberikan jawaban yang lebih jelas.

Bahasa yang sederhana juga membantu menurunkan kecemasan pasien. Pasien dengan halusinasi sering merasa kewalahan dengan pengalaman yang dialaminya. Bila perawat berbicara terlalu cepat, nada suara tinggi, atau menggunakan pertanyaan yang terlalu menekan, pasien dapat menjadi semakin gelisah. Sebaliknya, suara yang tenang, tempo bicara yang perlahan, dan pilihan kata yang mudah dipahami dapat membuat pasien merasa lebih nyaman. Perawat juga perlu memperhatikan respons nonverbal pasien. Jika pasien tampak bingung, diam terlalu lama, gelisah, atau menoleh ke arah tertentu, perawat dapat menghentikan pertanyaan sejenak dan memberikan waktu bagi pasien untuk menenangkan diri. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berfokus pada memperoleh data, tetapi juga menjaga kenyamanan dan kestabilan emosi pasien selama pengkajian.

Sikap empati merupakan inti dari komunikasi terapeutik. Empati berarti perawat berusaha memahami perasaan pasien dari sudut pandang pasien tanpa harus ikut larut dalam pengalaman halusinatif tersebut. Pasien dengan halusinasi mungkin merasa sangat takut ketika mendengar suara yang mengancam, atau merasa marah karena suara itu terus mengganggu. Perawat perlu menunjukkan bahwa perasaan pasien dipahami. Misalnya, perawat dapat mengatakan, "Saya mengerti Bapak merasa takut ketika suara itu muncul," atau "Ibu tampak sangat terganggu dengan suara tersebut." Kalimat seperti ini menunjukkan bahwa perawat memperhatikan emosi pasien dan tidak mengabaikan penderitaan yang dialami. Namun, empati tidak berarti membenarkan isi halusinasi. Perawat tetap harus menjaga batas antara menerima perasaan pasien dan memperkuat keyakinan pasien terhadap halusinasi.

Selain empati, perawat perlu menunjukkan sikap tenang dan tidak menghakimi. Sikap tenang sangat penting karena pasien dengan halusinasi dapat menangkap ekspresi cemas, takut, atau panik dari orang di sekitarnya. Jika perawat tampak takut atau bereaksi berlebihan, pasien dapat menjadi semakin gelisah atau merasa bahwa ancaman yang dirasakannya benar-benar nyata. Perawat harus menjaga ekspresi wajah, nada suara, dan gerak tubuh agar tetap stabil. Sikap tidak menghakimi juga sangat diperlukan karena pasien sering kali sudah mengalami stigma dari lingkungan. Kalimat seperti "Itu tidak mungkin," "Bapak mengada-ada," atau "Jangan bicara begitu" dapat membuat pasien merasa ditolak dan enggan melanjutkan komunikasi. Sebaliknya, perawat perlu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan respons yang menghargai, dan tidak menyalahkan pasien atas pengalaman yang dialaminya.

Salah satu prinsip penting dalam komunikasi dengan pasien halusinasi adalah mengakui perasaan pasien tanpa membenarkan isi halusinasi. Perawat perlu

membedakan antara validasi emosi dan validasi halusinasi. Validasi emosi berarti perawat mengakui bahwa pasien merasa takut, marah, sedih, atau terganggu. Namun, perawat tidak boleh mengatakan bahwa suara atau bayangan yang dialami pasien benar-benar ada. Misalnya, jika pasien mengatakan, "Ada suara yang menyuruh saya pergi," perawat tidak sebaiknya menjawab, "Iya, suara itu memang ada." Jawaban tersebut dapat memperkuat keyakinan pasien terhadap halusinasinya. Respons yang lebih terapeutik adalah, "Saya tidak mendengar suara itu, tetapi saya mengerti Bapak merasa terganggu dan takut. Saya akan menemani Bapak agar lebih tenang." Dengan respons seperti ini, perawat tetap menghargai pengalaman subjektif pasien sekaligus mempertahankan orientasi pada realitas.

Menghindari perdebatan mengenai nyata atau tidaknya halusinasi juga sangat penting. Pasien yang mengalami halusinasi sering memiliki keyakinan kuat bahwa apa yang didengar, dilihat, atau dirasakan adalah nyata. Jika perawat memaksa pasien menerima bahwa halusinasi itu tidak nyata, pasien dapat merasa tidak dipercaya, marah, defensif, atau semakin menarik diri. Perdebatan juga dapat meningkatkan kecurigaan pasien, terutama bila pasien merasa perawat menentang atau meremehkan pengalamannya. Oleh karena itu, perawat tidak perlu berdebat. Perawat cukup menyampaikan kenyataan dari sudut pandangnya secara tenang, misalnya, "Saya tidak melihat orang yang Bapak lihat, tetapi saya percaya Bapak sedang merasa takut." Kalimat ini tidak membenarkan halusinasi, tetapi juga tidak menyerang keyakinan pasien secara langsung.

Dalam pengkajian, perawat perlu mengarahkan pasien pada realitas secara perlahan. Orientasi realitas bertujuan membantu pasien mengenali kondisi nyata di sekitarnya tanpa membuat pasien merasa dipaksa. Mengarahkan pada realitas dapat dilakukan dengan mengajak pasien memperhatikan lingkungan, menyebutkan tempat, waktu, kegiatan yang sedang dilakukan, atau orang yang sedang bersama pasien. Misalnya, perawat dapat mengatakan, "Saat ini Bapak berada di ruang perawatan, saya perawat yang sedang menemani Bapak, dan kita sedang berbicara di kursi ini." Pengarahan realitas juga dapat dilakukan saat pasien tampak mulai larut dalam halusinasinya. Perawat dapat memanggil nama pasien dengan lembut, mengajak pasien menarik napas, atau meminta pasien memperhatikan benda nyata di sekitarnya. Pendekatan ini membantu pasien kembali fokus pada situasi saat ini.

Pengarahan realitas perlu dilakukan secara bertahap karena pasien mungkin belum siap langsung menerima bahwa pengalamannya adalah halusinasi. Perawat perlu menyesuaikan pendekatan dengan tingkat daya tilik diri pasien. Jika pasien sudah mulai menyadari bahwa suara yang didengarnya merupakan gejala, perawat dapat membantu pasien memperkuat kemampuan mengontrol halusinasi. Namun,

jika pasien masih sangat yakin bahwa halusinasi itu nyata, perawat perlu lebih berhati-hati dan fokus terlebih dahulu pada perasaan serta keselamatan pasien. Tujuan awal bukan memaksa pasien mengakui bahwa ia berhalusinasi, melainkan membantu pasien merasa aman, mau berkomunikasi, dan perlahan-lahan dapat membedakan pengalaman internal dengan kenyataan.

Memberikan kesempatan kepada pasien untuk menceritakan pengalamannya juga merupakan bagian penting dari komunikasi terapeutik. Pasien dengan halusinasi sering kali membutuhkan ruang untuk mengungkapkan apa yang dialami tanpa takut disalahkan. Ketika pasien diberi kesempatan bercerita, perawat dapat memperoleh data penting mengenai jenis halusinasi, isi, waktu muncul, frekuensi, durasi, pencetus, respons, dan kemampuan pasien mengontrol halusinasi. Selain itu, kesempatan bercerita dapat mengurangi beban emosional pasien karena ia merasa didengar dan dipahami. Perawat perlu menjadi pendengar aktif dengan menunjukkan perhatian melalui kontak mata yang wajar, anggukan, posisi tubuh yang terbuka, dan respons verbal singkat seperti "Saya mendengarkan" atau "Coba ceritakan pelan-pelan."

Namun, memberi kesempatan bercerita bukan berarti membiarkan pasien semakin tenggelam dalam halusinasi tanpa arah. Perawat tetap perlu mengarahkan pembicaraan agar pengkajian berjalan terstruktur. Jika pasien mulai berbicara terlalu jauh atau tampak semakin gelisah saat menceritakan halusinasi, perawat dapat membantu menenangkan dan mengarahkan kembali. Misalnya, perawat dapat mengatakan, "Kita berhenti sebentar, tarik napas dulu. Sekarang Bapak berada bersama saya di sini dan aman." Pendekatan ini membantu pasien tetap merasa didengarkan, tetapi tidak semakin larut dalam pengalaman halusinatif. Keseimbangan antara mendengarkan dan mengarahkan sangat penting dalam pengkajian halusinasi.

Dalam komunikasi terapeutik, perawat juga harus memperhatikan keamanan fisik selama pengkajian. Menjaga jarak aman sangat penting apabila pasien tampak gelisah, marah, curiga, atau berisiko melakukan kekerasan. Jarak aman bukan berarti menunjukkan rasa takut kepada pasien, tetapi merupakan tindakan profesional untuk melindungi pasien, perawat, dan orang lain. Perawat sebaiknya tidak berdiri terlalu dekat, tidak menyentuh pasien secara tiba-tiba, dan tidak menghalangi jalan keluar. Posisi perawat sebaiknya memungkinkan untuk bergerak dengan aman jika terjadi perubahan perilaku pasien. Bila pasien tampak sangat tegang, mengepalkan tangan, berbicara keras, menatap tajam, atau menunjukkan perilaku mengancam, perawat perlu menurunkan stimulasi lingkungan, berbicara dengan nada rendah, dan meminta bantuan tim jika diperlukan.

Keamanan dalam komunikasi juga mencakup pemilihan tempat pengkajian. Tempat yang terlalu ramai, bising, atau penuh stimulus dapat memperburuk halusinasi dan membuat pasien sulit berkonsentrasi. Sebaiknya pengkajian dilakukan di tempat yang tenang, cukup terbuka, tidak terlalu banyak gangguan, tetapi tetap mudah diawasi. Perawat juga perlu memastikan tidak ada benda berbahaya di sekitar pasien, seperti benda tajam, kaca, tali, atau alat yang dapat digunakan untuk mencederai diri sendiri atau orang lain. Jika pasien memiliki riwayat perilaku kekerasan atau sedang mengalami halusinasi perintah, pengkajian harus dilakukan dengan kewaspadaan lebih tinggi dan tidak dilakukan seorang diri apabila kondisi pasien tidak aman.

Teknik komunikasi terapeutik dalam pengkajian halusinasi juga harus memperhatikan penggunaan pertanyaan yang tepat. Perawat dapat menggunakan pertanyaan terbuka untuk memberi ruang pasien bercerita, seperti “Apa yang biasanya Bapak alami saat suara itu muncul?” atau “Bagaimana perasaan Ibu ketika melihat bayangan itu?” Setelah itu, perawat dapat menggunakan pertanyaan tertutup untuk memperjelas data, seperti “Apakah suara itu muncul setiap hari?” atau “Apakah suara itu pernah menyuruh Bapak menyakiti diri sendiri?” Kombinasi pertanyaan terbuka dan tertutup membantu perawat memperoleh data yang luas sekaligus spesifik. Perawat juga perlu melakukan klarifikasi apabila jawaban pasien kurang jelas, misalnya dengan mengatakan, “Maksud Bapak, suara itu muncul saat Bapak sedang sendirian?” Klarifikasi membantu mencegah salah pemahaman dalam pengkajian.

Respons perawat terhadap cerita pasien harus bersifat mendukung dan realistis. Jika pasien menceritakan halusinasi yang menakutkan, perawat dapat membantu pasien mengenali bahwa halusinasi tersebut merupakan gejala yang dapat dikontrol. Misalnya, perawat dapat mengatakan, “Saat suara itu muncul, Bapak dapat mencoba mengatakan dalam hati atau dengan suara tegas bahwa Bapak tidak mau mendengarkannya. Setelah itu, Bapak bisa segera berbicara dengan perawat atau melakukan aktivitas.” Respons seperti ini tidak hanya menggali data, tetapi juga mulai membantu pasien memahami cara menghadapi halusinasi. Namun, edukasi atau latihan sebaiknya diberikan sesuai kondisi pasien. Jika pasien masih sangat gelisah, fokus utama adalah menenangkan dan menjaga keselamatan terlebih dahulu.

Komunikasi terapeutik juga perlu melibatkan keluarga bila memungkinkan. Keluarga sering memiliki informasi penting mengenai perubahan perilaku pasien, waktu munculnya gejala, faktor pencetus, kepatuhan minum obat, serta cara pasien merespons halusinasi di rumah. Namun, perawat tetap harus menjaga kerahasiaan dan kenyamanan pasien. Pelibatan keluarga sebaiknya dilakukan dengan

persetujuan dan mempertimbangkan kondisi pasien. Dalam komunikasi dengan keluarga, perawat perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari sikap menyalahkan. Keluarga perlu diberi pemahaman bahwa halusinasi adalah gejala gangguan persepsi yang membutuhkan dukungan, bukan perilaku yang sengaja dibuat-buat oleh pasien. Dengan komunikasi yang baik, keluarga dapat menjadi bagian penting dalam pengawasan, dukungan emosional, dan pencegahan kekambuhan.

Teknik komunikasi terapeutik dalam pengkajian halusinasi harus dilakukan secara berkesinambungan. Setiap interaksi dengan pasien merupakan kesempatan untuk membangun kepercayaan, mengamati perubahan kondisi, dan memperkuat orientasi realitas. Perawat perlu mengevaluasi respons pasien terhadap komunikasi yang dilakukan. Jika pasien menjadi lebih tenang, lebih terbuka, dan mampu menceritakan pengalamannya, maka pendekatan yang digunakan dapat dipertahankan. Namun, jika pasien tampak semakin gelisah, marah, atau menolak bicara, perawat perlu menyesuaikan strategi, memperpendek waktu interaksi, atau memberikan jeda. Fleksibilitas sangat diperlukan karena kondisi pasien dengan halusinasi dapat berubah dari waktu ke waktu.

teknik komunikasi terapeutik dalam pengkajian halusinasi mencakup kemampuan membangun hubungan saling percaya, menggunakan bahasa sederhana, menunjukkan empati, bersikap tenang dan tidak menghakimi, mengakui perasaan pasien tanpa membenarkan isi halusinasi, menghindari perdebatan, mengarahkan pasien pada realitas, memberi kesempatan pasien bercerita, serta menjaga jarak aman bila terdapat risiko perilaku kekerasan. Komunikasi terapeutik bukan hanya alat untuk memperoleh data, tetapi juga merupakan bagian dari proses penyembuhan. Melalui komunikasi yang tepat, pasien dapat merasa diterima, lebih mampu mengungkapkan pengalaman halusinasinya, lebih mudah diarahkan pada realitas, dan lebih siap mengikuti intervensi keperawatan. Perawat yang mampu berkomunikasi secara terapeutik akan lebih mudah melakukan pengkajian yang akurat, menjaga keselamatan, serta membantu pasien mengembangkan kemampuan mengontrol halusinasi secara bertahap.

J. Analisis Data dan Perumusan Masalah Keperawatan

Analisis data merupakan tahap penting setelah perawat menyelesaikan proses pengkajian pada pasien dengan halusinasi. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan tidak hanya dicatat, tetapi juga ditelaah, dibandingkan, dikelompokkan, dan ditafsirkan agar dapat menggambarkan masalah keperawatan yang sebenarnya dialami pasien. Dalam keperawatan jiwa, analisis data

membutuhkan ketelitian karena gejala yang muncul sering kali tidak hanya tampak secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan pikiran, perasaan, persepsi, perilaku, hubungan sosial, dan kemampuan pasien dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada pasien dengan halusinasi, perawat harus mampu membedakan mana data yang menunjukkan gangguan persepsi sensori, mana data yang menunjukkan risiko keselamatan, dan mana data yang merupakan dampak lanjutan dari halusinasi, seperti isolasi sosial, ansietas, harga diri rendah, atau defisit perawatan diri.

Langkah awal dalam analisis data adalah mengelompokkan data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah data yang berasal dari ungkapan langsung pasien mengenai apa yang dirasakan, dipikirkan, didengar, dilihat, atau dialami. Pada pasien dengan halusinasi, data subjektif dapat berupa pernyataan pasien bahwa ia mendengar suara seseorang memanggil namanya, mendengar bisikan yang menyuruhnya melakukan sesuatu, melihat bayangan tertentu, mencium bau yang tidak dirasakan orang lain, atau merasa ada sesuatu yang menyentuh tubuhnya. Data subjektif juga dapat berupa ungkapan perasaan pasien, seperti takut, cemas, terganggu, marah, bingung, atau merasa tidak mampu mengendalikan suara yang muncul. Data ini penting karena halusinasi merupakan pengalaman internal yang sering kali hanya dapat diketahui jika pasien bersedia menceritakannya.

Sementara itu, data objektif adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan perawat, informasi keluarga, atau catatan kesehatan pasien. Data objektif pada pasien dengan halusinasi dapat terlihat dari perilaku pasien yang berbicara sendiri, tertawa sendiri, menutup telinga, menoleh ke arah tertentu, tampak mendengarkan sesuatu, tampak ketakutan tanpa stimulus nyata, gelisah, mondar-mandir, sulit berkonsentrasi, atau tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas. Data objektif juga dapat mencakup penurunan kemampuan merawat diri, gangguan tidur, penolakan makan, menarik diri dari lingkungan, atau perilaku agresif. Pengelompokan data subjektif dan objektif membantu perawat melihat hubungan antara apa yang dikatakan pasien dan apa yang tampak dalam perilaku pasien.

Setelah data dikelompokkan, perawat perlu mengidentifikasi data utama yang menunjukkan adanya halusinasi. Data utama biasanya berkaitan langsung dengan gangguan persepsi sensori, yaitu adanya pengalaman indrawi tanpa rangsangan nyata. Misalnya, pasien mengatakan mendengar suara yang menyuruhnya pergi, sementara perawat mengamati pasien sering berbicara sendiri dan tampak menoleh ke arah tertentu. Gabungan data subjektif dan objektif tersebut memperkuat dugaan bahwa pasien mengalami halusinasi pendengaran.

Contoh lain, pasien mengatakan melihat bayangan hitam di sudut ruangan, disertai perilaku tampak takut dan berusaha menghindari sudut ruangan tersebut. Data seperti ini menunjukkan bahwa pasien mengalami gangguan persepsi dalam bentuk halusinasi penglihatan. Semakin lengkap data yang diperoleh, semakin akurat pula perawat dalam merumuskan masalah keperawatan.

Dalam mengidentifikasi data utama, perawat juga perlu memperhatikan isi halusinasi, frekuensi, waktu muncul, durasi, situasi pencetus, dan respons pasien. Halusinasi yang hanya muncul sesekali dan masih dapat dikontrol tentu memiliki tingkat risiko yang berbeda dengan halusinasi yang muncul terus-menerus, berisi ancaman, atau memerintah pasien melakukan tindakan berbahaya. Oleh karena itu, data utama tidak hanya menunjukkan bahwa pasien mengalami halusinasi, tetapi juga menggambarkan tingkat keparahan dan dampaknya terhadap pasien. Misalnya, pasien yang mendengar suara mengejek mungkin mengalami ansietas dan harga diri rendah, sedangkan pasien yang mendengar suara menyuruh memukul orang lain memiliki risiko perilaku kekerasan yang lebih tinggi. Analisis seperti ini membantu perawat menentukan masalah utama dan masalah penyerta secara tepat.

Menentukan masalah keperawatan berdasarkan hasil pengkajian merupakan langkah berikutnya dalam proses analisis data. Masalah keperawatan dirumuskan berdasarkan respons pasien terhadap kondisi yang dialaminya. Pada pasien dengan halusinasi, masalah utama yang sering muncul adalah gangguan persepsi sensori. Masalah ini menggambarkan bahwa pasien mengalami perubahan dalam menerima atau menafsirkan stimulus sehingga merasakan sesuatu yang tidak berasal dari rangsangan nyata. Namun, perawat tidak boleh berhenti hanya pada satu masalah. Halusinasi dapat menimbulkan berbagai masalah lain yang saling berkaitan, seperti risiko perilaku kekerasan, isolasi sosial, ansietas, harga diri rendah, gangguan pola tidur, defisit perawatan diri, dan ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Setiap masalah harus didukung oleh data yang jelas agar perumusan diagnosis keperawatan tidak bersifat asertif.

Penetapan prioritas masalah harus dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan pasien. Dalam keperawatan jiwa, keselamatan menjadi prioritas utama. Jika pasien mengalami halusinasi yang berisi perintah untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, maka masalah risiko perilaku kekerasan atau risiko bunuh diri harus menjadi perhatian pertama. Perawat perlu segera memastikan keamanan pasien, menjauhkan benda berbahaya, meningkatkan pengawasan, dan melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan. Setelah risiko keselamatan terkendali, perawat dapat memprioritaskan masalah lain seperti gangguan persepsi sensori, kecemasan, isolasi sosial, atau defisit perawatan diri. Dengan demikian, prioritas

tidak ditentukan hanya berdasarkan banyaknya data, tetapi berdasarkan seberapa besar masalah tersebut mengancam keselamatan, fungsi, dan kebutuhan dasar pasien.

Gangguan persepsi sensori merupakan masalah keperawatan yang paling khas pada pasien dengan halusinasi. Masalah ini dapat ditegakkan apabila ditemukan data yang menunjukkan pasien mengalami pengalaman sensori tanpa stimulus nyata. Pasien mungkin mengatakan mendengar suara, melihat bayangan, mencium bau, merasakan rasa tertentu, atau merasakan sentuhan yang tidak dirasakan orang lain. Data objektif yang mendukung dapat berupa pasien berbicara sendiri, tertawa sendiri, menutup telinga, tampak mendengarkan sesuatu, menoleh ke arah kosong, atau menunjukkan respons emosional terhadap stimulus yang tidak terlihat. Masalah ini penting untuk segera ditangani karena halusinasi dapat mengganggu konsentrasi, tidur, aktivitas, hubungan sosial, dan kemampuan pasien membedakan kenyataan.

Risiko perilaku kekerasan juga sering muncul pada pasien dengan halusinasi, terutama jika isi halusinasi bersifat mengancam atau memerintah. Risiko ini dapat ditunjukkan oleh data seperti pasien mengatakan ada suara yang menyuruhnya memukul orang lain, pasien tampak marah, gelisah, mengepalkan tangan, berbicara keras, mudah tersinggung, atau memiliki riwayat melakukan kekerasan. Risiko perilaku kekerasan harus dianalisis secara serius karena dapat membahayakan pasien, keluarga, perawat, dan orang lain di sekitar pasien. Dalam hal ini, perawat perlu menilai kemampuan pasien mengontrol dorongan, tingkat keyakinan pasien terhadap halusinasi, serta apakah pasien pernah mengikuti perintah dari suara yang didengarnya.

Isolasi sosial dapat menjadi masalah keperawatan apabila pasien menarik diri dari lingkungan akibat halusinasi. Pasien mungkin lebih banyak menyendiri, enggan berkomunikasi, tidak mau mengikuti aktivitas kelompok, atau merasa orang lain tidak memahami dirinya. Halusinasi dapat membuat pasien lebih fokus pada suara atau bayangan yang dialami daripada pada interaksi nyata dengan orang sekitar. Selain itu, pasien mungkin merasa malu karena sering berbicara sendiri atau takut mendapat penolakan. Data objektif yang mendukung isolasi sosial dapat berupa pasien tampak menyendiri di kamar, jarang berbicara, menghindari kontak mata, tidak berminat berinteraksi, dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan. Masalah ini penting karena isolasi sosial dapat memperburuk halusinasi dan menghambat proses pemulihan.

Ansietas juga dapat muncul sebagai respons terhadap halusinasi. Pasien yang mendengar suara mengancam atau melihat bayangan menakutkan dapat merasa cemas, takut, gelisah, dan tidak aman. Ansietas dapat terlihat dari wajah tegang,

sulit tidur, sering mondar-mandir, berkeringat, mudah terkejut, atau sulit berkonsentrasi. Jika tidak ditangani, kecemasan dapat memperberat halusinasi karena pasien semakin sulit mengontrol pikiran dan emosinya. Dalam analisis data, perawat perlu melihat hubungan antara munculnya halusinasi dengan peningkatan kecemasan pasien. Misalnya, pasien mengatakan suara muncul terutama saat malam hari, kemudian pasien menjadi takut tidur dan tampak gelisah. Data tersebut menunjukkan bahwa ansietas menjadi salah satu masalah yang perlu direncanakan intervensinya.

Harga diri rendah dapat terjadi pada pasien dengan halusinasi, terutama jika pasien merasa malu, tidak berguna, ditolak, atau merasa berbeda dari orang lain. Pasien mungkin mengatakan dirinya tidak berharga, merasa menjadi beban keluarga, malu karena mengalami gangguan jiwa, atau merasa tidak mampu sembuh. Halusinasi yang berisi ejekan atau hinaan dapat memperkuat perasaan rendah diri. Secara objektif, pasien dapat tampak murung, menunduk, kurang kontak mata, berbicara pelan, menarik diri, atau tidak memiliki motivasi melakukan aktivitas. Perawat perlu menganalisis apakah harga diri rendah merupakan penyebab yang memperberat halusinasi atau dampak dari halusinasi yang dialami. Pemahaman ini penting agar intervensi tidak hanya berfokus pada gejala halusinasi, tetapi juga pada penguatan konsep diri pasien.

Defisit perawatan diri merupakan masalah yang dapat ditemukan ketika pasien tidak mampu atau tidak mau memenuhi kebutuhan kebersihan diri, berpakaian, makan, berhias, atau menjaga kebersihan lingkungan. Pada pasien dengan halusinasi, defisit perawatan diri dapat terjadi karena pasien terlalu fokus pada stimulus internal, kehilangan motivasi, mengalami gangguan konsentrasi, atau mengikuti isi halusinasi yang melarangnya melakukan aktivitas tertentu. Data yang mendukung dapat berupa pasien tampak kotor, pakaian tidak rapi, rambut kusut, bau badan, kuku panjang, jarang mandi, makan tidak teratur, atau membutuhkan bantuan dalam aktivitas sehari-hari. Masalah ini perlu diperhatikan karena perawatan diri yang buruk dapat menurunkan kesehatan fisik, harga diri, dan penerimaan sosial pasien.

Setelah masalah keperawatan dirumuskan dan prioritas ditentukan, perawat perlu menyusun dasar perencanaan intervensi keperawatan. Perencanaan intervensi harus disusun berdasarkan masalah yang ditemukan, bukan berdasarkan asumsi umum. Jika masalah utama adalah gangguan persepsi sensori, maka intervensi diarahkan untuk membantu pasien mengenali halusinasi, mengidentifikasi isi dan waktu munculnya halusinasi, melatih cara mengontrol halusinasi, mengalihkan perhatian melalui aktivitas, bercakap-cakap dengan orang lain, serta meningkatkan kepatuhan minum obat. Jika masalah yang menonjol

adalah risiko perilaku kekerasan, maka intervensi harus memprioritaskan keamanan, pengawasan, penurunan rangsangan lingkungan, komunikasi yang menenangkan, serta kolaborasi dengan tim kesehatan. Jika masalahnya isolasi sosial, maka intervensi diarahkan untuk melatih interaksi bertahap dan meningkatkan dukungan sosial.

Dasar perencanaan intervensi juga harus mempertimbangkan kemampuan pasien, dukungan keluarga, kondisi lingkungan, dan tingkat keparahan gejala. Pasien yang masih sangat dikuasai halusinasi mungkin belum mampu langsung mengikuti edukasi panjang atau aktivitas kelompok. Pada kondisi tersebut, intervensi perlu dimulai dari pendekatan sederhana, seperti membangun hubungan saling percaya, membantu pasien merasa aman, dan mengajarkan cara mengenali halusinasi. Sebaliknya, pasien yang sudah mulai mampu mengontrol halusinasi dapat dilibatkan dalam aktivitas yang lebih terstruktur, latihan komunikasi, dan perencanaan pulang bersama keluarga. Dengan demikian, analisis data tidak hanya menghasilkan daftar masalah, tetapi juga menjadi dasar untuk menyusun tindakan keperawatan yang realistis, bertahap, dan sesuai kebutuhan pasien.

Analisis data dan perumusan masalah keperawatan harus didokumentasikan secara jelas. Dokumentasi yang baik mencantumkan data subjektif, data objektif, masalah keperawatan, prioritas masalah, serta dasar pertimbangan dalam menyusun intervensi. Dokumentasi ini penting agar seluruh tim kesehatan memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi pasien dan dapat memberikan asuhan secara berkesinambungan. Pada pasien dengan halusinasi, perubahan kondisi dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga dokumentasi yang akurat membantu perawat berikutnya mengetahui apakah halusinasi berkurang, bertambah, berubah isi, atau menimbulkan risiko baru.

analisis data dan perumusan masalah keperawatan pada pasien dengan halusinasi merupakan proses berpikir kritis yang menghubungkan data pengkajian dengan respons pasien terhadap gangguan yang dialaminya. Perawat harus mampu mengelompokkan data subjektif dan objektif, mengidentifikasi data utama yang menunjukkan halusinasi, menentukan masalah keperawatan yang sesuai, menetapkan prioritas berdasarkan risiko dan kebutuhan pasien, serta menyusun dasar perencanaan intervensi. Melalui analisis yang tepat, asuhan keperawatan menjadi lebih terarah, aman, dan efektif dalam membantu pasien mengenali halusinasi, mengontrol gejala, mencegah risiko, serta meningkatkan kemampuan menjalani kehidupan sehari-hari secara lebih adaptif.

K. Simpulan

Pengkajian keperawatan jiwa pada pasien dengan halusinasi merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses asuhan keperawatan karena menjadi dasar dalam memahami kondisi pasien secara menyeluruh. Halusinasi sebagai gangguan persepsi sensori dapat memengaruhi cara pasien berpikir, merasakan, berperilaku, berinteraksi, serta menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pengkajian tidak hanya berfokus pada keberadaan halusinasi, tetapi juga perlu menggali jenis, isi, waktu muncul, frekuensi, durasi, faktor pencetus, respons pasien, serta kemampuan pasien dalam mengontrol halusinasi. Data yang diperoleh melalui pengkajian yang komprehensif akan membantu perawat menentukan masalah keperawatan secara tepat dan menyusun intervensi yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

Pengkajian pada pasien dengan halusinasi harus dilakukan secara terapeutik, empatik, objektif, aman, rahasia, dan tidak menghakimi. Perawat perlu membangun hubungan saling percaya agar pasien merasa aman untuk menceritakan pengalaman yang dialaminya. Selain memperoleh data dari pasien, perawat juga perlu mempertimbangkan informasi dari keluarga, rekam medis, dan hasil observasi langsung. Pengkajian status mental, pengkajian terfokus pada halusinasi, serta pengkajian risiko menjadi bagian penting untuk menilai kondisi pasien secara lebih mendalam. Risiko yang perlu diperhatikan meliputi risiko mencederai diri sendiri, mencederai orang lain, perilaku kekerasan akibat perintah halusinasi, bunuh diri, isolasi sosial, defisit perawatan diri, ketidakpatuhan minum obat, dan kekambuhan.

Analisis data dan perumusan masalah keperawatan menjadi langkah lanjutan yang menentukan arah asuhan keperawatan. Perawat perlu mengelompokkan data subjektif dan objektif, mengidentifikasi data utama yang menunjukkan adanya halusinasi, menentukan masalah keperawatan, serta menetapkan prioritas berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan pasien. Masalah keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan halusinasi antara lain gangguan persepsi sensori, risiko perilaku kekerasan, isolasi sosial, ansietas, harga diri rendah, dan defisit perawatan diri. Dengan pengkajian yang tepat, komunikasi terapeutik yang efektif, serta analisis data yang cermat, perawat dapat memberikan asuhan yang lebih aman, manusiawi, terarah, dan mendukung proses pemulihan pasien secara optimal.

L. Referensi

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric

- Association Publishing. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>
- Butcher, H. K., Bulechek, G. M., Dochterman, J. M. M., & Wagner, C. M. (Eds.). (2018). *Nursing interventions classification (NIC)* (7th ed.). Elsevier.
- Damaiyanti, M., & Iskandar. (2012). *Asuhan keperawatan jiwa*. Refika Aditama.
- Halter, M. J. (2022). *Varcarolis' foundations of psychiatric-mental health nursing: A clinical approach* (9th ed.). Elsevier.
- Herdman, T. H., Kamitsuru, S., & Lopes, C. T. (Eds.). (2021). *NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification 2021–2023* (12th ed.). Thieme.
- Keliat, B. A. (2014). *Proses keperawatan jiwa* (Edisi 2). EGC.
- Keliat, B. A., & Akemat. (2012). *Keperawatan kesehatan jiwa komunitas: CMHN (basic course)*. EGC.
- Keliat, B. A., Akemat, & Nurhalimah. (2013). *Keperawatan kesehatan jiwa: Konsep dan aplikasi praktik klinik*. EGC.
- Moorhead, S., Swanson, E., Johnson, M., & Maas, M. L. (Eds.). (2018). *Nursing outcomes classification (NOC): Measurement of health outcomes* (6th ed.). Elsevier.
- Nasir, A., & Muhith, A. (2011). *Dasar-dasar keperawatan jiwa: Pengantar dan teori*. Salemba Medika.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz, P. (2015). *Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry* (11th ed.). Wolters Kluwer.
- Stuart, G. W. (2022). *Prinsip dan praktik keperawatan kesehatan jiwa Stuart* (Edisi Indonesia 11; B. A. Keliat & J. Pasaribu, Eds.). Elsevier Health Sciences.
- Sutejo. (2018). *Keperawatan jiwa: Konsep dan praktik asuhan keperawatan kesehatan jiwa: Gangguan jiwa dan psikososial*. Pustaka Baru Press.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar intervensi keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Townsend, M. C., & Morgan, K. I. (2020). *Essentials of psychiatric mental health*

nursing: Concepts of care in evidence-based practice (8th ed.). F. A. Davis Company.

Videbeck, S. L. (2020). *Psychiatric-mental health nursing* (8th ed.). Wolters Kluwer.

World Health Organization. (2019). *International classification of diseases for mortality and morbidity statistics* (11th Revision). <https://icd.who.int/>

World Health Organization. (2022). *World mental health report: Transforming mental health for all*. World Health Organization.

Yusuf, A., Fitryasari, R., & Nihayati, H. E. (2015). *Buku ajar keperawatan kesehatan jiwa*. Salemba Medika.

M. Glosarium

- **Pengkajian Keperawatan Jiwa**

Proses awal dalam asuhan keperawatan jiwa untuk mengumpulkan data biologis, psikologis, sosial, spiritual, perilaku, dan lingkungan pasien sebagai dasar penentuan masalah keperawatan.

- **Halusinasi**

Gangguan persepsi sensori ketika seseorang merasakan adanya suara, bayangan, bau, rasa, sentuhan, atau sensasi tertentu tanpa adanya rangsangan nyata dari lingkungan.

- **Gangguan Persepsi Sensori**

Keadaan ketika seseorang mengalami perubahan dalam menerima, menafsirkan, atau merespons rangsangan, sehingga persepsi yang muncul tidak sesuai dengan kenyataan.

- **Halusinasi Pendengaran**

Jenis halusinasi berupa pengalaman mendengar suara, bisikan, panggilan, percakapan, ancaman, atau perintah yang tidak didengar oleh orang lain.

- **Halusinasi Penglihatan**

Jenis halusinasi berupa pengalaman melihat bayangan, orang, cahaya, benda, atau bentuk tertentu yang sebenarnya tidak ada.

- **Halusinasi Perintah**

Halusinasi yang berisi instruksi atau perintah kepada pasien untuk melakukan tindakan tertentu, baik yang bersifat ringan maupun yang berisiko membahayakan diri sendiri atau orang lain.

- **Ilusi**

Kesalahan dalam menafsirkan rangsangan nyata dari lingkungan, misalnya melihat bayangan benda lalu menganggapnya sebagai seseorang.

- **Waham**

Keyakinan yang salah, menetap, tidak sesuai kenyataan, dan tetap diyakini kuat oleh pasien meskipun telah diberikan penjelasan yang logis.

- **Faktor Predisposisi**

Faktor yang membuat seseorang lebih rentan mengalami gangguan jiwa atau halusinasi, seperti riwayat keluarga, trauma, gangguan neurokimia, kurang dukungan sosial, atau pengalaman tidak menyenangkan.

- **Faktor Presipitasi**

Faktor pencetus yang memicu munculnya atau kambuhnya halusinasi, seperti stres berat, konflik keluarga, putus obat, kurang tidur, atau penyalahgunaan zat.

- **Status Mental**

Gambaran kondisi psikologis, emosional, kognitif, dan perilaku pasien yang dikaji melalui penampilan, pembicaraan, mood, afek, proses pikir, persepsi, orientasi, memori, konsentrasi, dan daya tilik diri.

- **Komunikasi Terapeutik**

Komunikasi profesional antara perawat dan pasien yang bertujuan membangun hubungan saling percaya, membantu pasien mengungkapkan perasaan, serta mendukung proses pemulihan.

- **Daya Tilik Diri**

Kemampuan pasien untuk menyadari bahwa dirinya mengalami masalah kesehatan jiwa dan memahami perlunya bantuan atau pengobatan.

- **Risiko Perilaku Kekerasan**

Kemungkinan pasien melakukan tindakan yang dapat mencederai diri sendiri, orang lain, atau lingkungan, terutama bila halusinasi bersifat mengancam atau memerintah.

- **Defisit Perawatan Diri**

Penurunan kemampuan atau kemauan pasien dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti mandi, berpakaian, makan, berhias, dan menjaga kebersihan diri.

CHAPTER 3

PERAN KELUARGA DALAM MENDUKUNG KEPATUHAN TERAPI DAN PERAWATAN PASIEN SCHIZOPHRENIA

Dr. Isak JH. Tukayo, M.Sc.

A. Pendahuluan

Schizophrenia merupakan gangguan mental berat yang ditandai dengan distorsi realitas, halusinasi, waham, serta gangguan proses pikir dan perilaku (Ilham, 2024). Penyakit ini tidak hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga memberikan beban psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan bagi keluarga dan masyarakat (Cheng et al., 2024). Data Global Burden of Disease Study 2019 menunjukkan bahwa schizophrenia menyumbang beban disabilitas yang tinggi, terutama di negara-negara dengan populasi lanjut usia dan sistem kesehatan yang belum sepenuhnya terintegrasi (Cheng et al., 2024).

Kepatuhan terhadap terapi, khususnya konsumsi antipsikotik secara teratur, merupakan faktor kunci dalam mencegah kekambuhan dan menurunkan angka rawat inap ulang (Mannarini et al., 2020). Namun, kepatuhan terapi pada pasien schizophrenia seringkali rendah akibat berbagai faktor: kurangnya insight terhadap penyakit, efek samping obat, stigma masyarakat, serta lemahnya dukungan keluarga (Subu, Holmes, et al., 2022; Suratmini et al., 2024).

Di Indonesia, tantangan kepatuhan terapi semakin kompleks dengan masih adanya praktik *pasung* (pemasungan), rendahnya literasi kesehatan mental, serta keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa di daerah terpencil (Hidayat et al., 2020, 2023). Keluarga, sebagai sistem pendukung terdekat, memiliki posisi strategis untuk memastikan pasien menjalani terapi secara konsisten. Namun, keluarga juga kerap mengalami stigma internal (*internalized stigma*) dan beban pengasuhan yang berat (Mubin et al., 2023; Suratmini et al., 2024).

Artikel ini menguraikan secara komprehensif peran keluarga dalam mendukung kepatuhan terapi pasien schizophrenia, dengan meninjau fenomena global dan nasional, tren dukungan terkini, peran perawat, kebijakan pemerintah, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi strategis.

Tujuan

Tujuan penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fenomena global dan nasional terkait kepatuhan terapi pasien schizophrenia serta beban yang dialami keluarga.
2. Menjelaskan berbagai tren dukungan kepatuhan terapi berbasis keluarga yang telah terbukti efektif.
3. Menganalisis peran perawat jiwa dalam memberdayakan keluarga pasien schizophrenia.
4. Menguraikan peran profesi lain, kebijakan pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung kepatuhan terapi berbasis keluarga.
5. Mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi keluarga dalam mendukung kepatuhan terapi.
6. Memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan peran keluarga dalam perawatan schizophrenia.

B. Fenomena Global dan Nasional

1. Fenomena Global

Secara global, schizophrenia mempengaruhi sekitar 24 juta orang di dunia, dengan prevalensi lebih tinggi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah (Cheng et al., 2024). Studi lintas negara menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap antipsikotik berkisar antara 40% hingga 60% setelah satu tahun pengobatan (Mannarini et al., 2020). Faktor yang paling konsisten terkait dengan kepatuhan adalah dukungan keluarga dan hubungan terapeutik yang baik dengan tenaga kesehatan (Potts et al., 2022; Ross & Wright, 2023)(Potts et al., 2022; Ross & Wright, 2023).

Di negara maju, pendekatan *family psychoeducation* dan *assertive community treatment* telah terbukti menurunkan angka kekambuhan hingga 50% (Soltis-Jarrett, 2023). Namun, di negara berkembang, keterbatasan sumber daya dan stigma yang kuat menjadi penghambat utama (Subu, Holmes, et al., 2022).

2. Fenomena Nasional di Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam penanganan schizophrenia. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2022, angka prevalensi gangguan mental berat termasuk schizophrenia mencapai sekitar 6,7 per 1.000 penduduk (Ministry of Health of the Republic of Indonesia, 2023). Sayangnya, *treatment gap* (kesenjangan pengobatan) masih sangat tinggi, terutama di daerah pedesaan (Hidayat et al., 2023).

Salah satu fenomena paling memprihatinkan adalah praktik *pasung*—pemasangan atau pengekangan fisik terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Studi sistematis oleh Hidayat et al. (2020) menemukan bahwa pasung masih terjadi di berbagai provinsi di Indonesia, terutama karena kurangnya akses layanan, beban ekonomi keluarga, dan keyakinan bahwa gangguan jiwa tidak dapat disembuhkan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan program *Indonesia Bebas Pasung* sejak 2014, implementasinya masih belum merata (Hidayat et al., 2023).

Selain itu, stigma terhadap gangguan jiwa sangat kuat dalam masyarakat Indonesia. Penelitian oleh Natalia & Fridari (2022) menunjukkan bahwa budaya kolektivis di Indonesia justru dapat memperkuat stigma karena keluarga merasa "malu" jika salah satu anggotanya mengalami gangguan jiwa (Sarah Josephine Natalia & I Gusti Ayu Diah Fridari, 2022). Stigma ini tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga dari keluarga sendiri, yang termanifestasi sebagai *internalized stigma* (Suratmini et al., 2024).

Pandemi COVID-19 juga memperburuk kondisi kesehatan mental di Indonesia. Hafrida et al. (2021) dan Harjana et al. (2021) melaporkan peningkatan signifikan gangguan mental di kalangan pekerja migran dan masyarakat umum akibat isolasi sosial, kehilangan pekerjaan, dan ketakutan akan penyakit (Hafrida et al., 2021; Harjana et al., 2021).

C. Tren Dukungan Kepatuhan Terapi

Dalam dekade terakhir, berbagai pendekatan inovatif telah dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan terapi pasien schizophrenia melalui dukungan keluarga. Berikut adalah tren utama:

1. Family Psychoeducation (FPE)

FPE merupakan intervensi berbasis bukti yang melibatkan keluarga sebagai mitra dalam perawatan. Program ini mencakup edukasi tentang schizophrenia, manajemen gejala, komunikasi efektif, serta pemecahan masalah (Mannarini et al., 2020; Susanti et al., 2024). Studi di Indonesia menunjukkan bahwa FPE dapat mengurangi beban keluarga dan menurunkan angka kekambuhan (Amir et al., 2021).

2. Telehealth dan Dukungan Jarak Jauh

Pasca pandemi, layanan telehealth untuk kesehatan mental berkembang pesat. Hernandez (2022) menyatakan bahwa akses jarak jauh memungkinkan keluarga di daerah terpencil mendapatkan konsultasi dan supervisi tanpa harus ke fasilitas kesehatan (Hernandez, 2022). Di Indonesia, program SICEPOT (Sistem

Inovasi Cepat Penanganan ODGJ Terpadu) di Kota Sukabumi merupakan contoh integrasi teknologi dalam pendampingan keluarga (Rachmawati et al., 2023).

3. Intervensi Spiritual

Mengingat budaya Indonesia yang religius, intervensi spiritual seperti *Happy Spiritual Intervention* telah dikembangkan untuk mengurangi ketidakpastian dan stres pada keluarga yang merawat pasien schizophrenia (Dwidiyanti et al., 2024). Pendekatan ini membantu keluarga menemukan makna dan ketenangan dalam pengasuhan.

4. Pelibatan Kader Kesehatan Jiwa Masyarakat (*Cadres*)

Di Indonesia, kader kesehatan jiwa masyarakat (lay mental health workers) telah dilatih untuk membantu keluarga dalam memantau kepatuhan minum obat dan memberikan dukungan psikososial dasar (Susanti et al., 2024). Model ini terbukti efektif di daerah dengan keterbatasan tenaga profesional.

5. Edukasi Anti-Stigma untuk Keluarga

Program anti-stigma yang ditargetkan pada keluarga, seperti yang dikembangkan oleh Potts et al. (2022), telah terbukti mengurangi rasa malu dan meningkatkan kemauan keluarga untuk mencari bantuan (Potts et al., 2022). Di Indonesia, edukasi pelepasan pasung (*shackle release education*) juga mulai diberikan kepada keluarga (Rasmawati et al., 2022).

D. Peran Perawat Jiwa

Perawat jiwa memiliki posisi sentral dalam memberdayakan keluarga untuk mendukung kepatuhan terapi pasien schizophrenia. Berdasarkan literatur, peran perawat jiwa meliputi:

1. Edukator dan Fasilitator

Perawat jiwa bertanggung jawab memberikan edukasi tentang schizophrenia, manfaat pengobatan jangka panjang, efek samping antipsikotik, serta tanda-tanda kekambuhan dini (Hussien et al., 2023; Yosep et al., 2021). Edukasi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan mempertimbangkan tingkat literasi kesehatan keluarga (Pangiras et al., 2021).

2. Pendamping Psikososial

Perawat jiwa membantu keluarga mengembangkan keterampilan koping, manajemen stres, dan komunikasi asertif dengan pasien (Amir et al., 2021). *Working alliance* antara perawat dan keluarga merupakan prediktor keberhasilan intervensi (Yosep et al., 2021).

3. Advokat

Perawat jiwa berperan dalam mengadvokasi hak-hak pasien dan keluarga, termasuk akses terhadap layanan kesehatan jiwa yang terjangkau melalui

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Quigley et al., 2018; Septiansyah et al., 2023). Mereka juga membantu keluarga melaporkan kasus pasung atau kekerasan terhadap ODGJ (Hidayat et al., 2023).

4. Koordinator Layanan

Perawat jiwa seringkali menjadi *case manager* yang menghubungkan keluarga dengan layanan kesehatan, pekerja sosial, dan program rehabilitasi berbasis masyarakat (Soltis-Jarrett, 2023; Tasijawa et al., 2021).

5. Peneliti dan Inovator

Perawat jiwa juga berperan dalam mengembangkan dan menguji model intervensi berbasis keluarga yang sesuai dengan konteks lokal Indonesia, seperti model perawatan defisit perawatan diri (self-deficit nursing) (Amir et al., 2021), dan intervensi spiritual (Dwidiyanti et al., 2024).

E. Peran Profesi Lain, Kebijakan Pemerintah, Dan Masyarakat

1. Profesi Lain

Selain perawat, berbagai profesi lain juga berkontribusi:

- a. Psikiater: Memberikan diagnosis akurat, meresepkan antipsikotik yang tepat, dan melakukan titrasi dosis untuk meminimalkan efek samping (Mannarini et al., 2020).
- b. Pekerja Sosial: Membantu keluarga mengakses bantuan sosial, subsidi biaya pengobatan, serta program rehabilitasi vokasi (Hidayat et al., 2023).
- c. Psikolog Klinis: Menyediakan terapi kognitif-perilaku (CBT) untuk pasien dan keluarga, serta melatih manajemen stres (Subu, Holmes, et al., 2022).
- d. Tenaga Hukum: Memberikan perlindungan hukum bagi ODGJ yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi (Murtantyo Hutomo & Sura Anabertha Sembiring, 2023).

2. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan penting:

- a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa – Mengamanatkan penghapusan pasung, penyediaan layanan kesehatan jiwa di puskesmas, serta keterlibatan keluarga dalam perawatan (Hidayat et al., 2023).
- b. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Menjamin akses ODGJ ke layanan kesehatan jiwa, termasuk rawat inap di rumah sakit jiwa dan konsumsi antipsikotik (Septiansyah et al., 2023; Wiseman et al., 2018).

- c. Program Indonesia Bebas Pasung – Target nasional untuk menghilangkan praktik pasung dengan pendekatan berbasis masyarakat (Hidayat et al., 2020).
- d. Integrasi Layanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas – Melalui program *Puskesmas Siaga Jiwa*, keluarga dapat mengakses skrining, edukasi, dan rujukan lebih mudah (Susanti et al., 2024).

Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala: kurangnya tenaga kesehatan jiwa spesialis, distribusi layanan yang timpang antara Jawa dan luar Jawa, serta anggaran yang terbatas (Hidayat et al., 2023; Sari & Montessori, 2021)(Putri et al., 2021; Hidayat et al., 2023).

3. Peran Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan terapi:

- a. Mengurangi stigma melalui kampanye literasi kesehatan mental (Endriyani et al., 2024).
- b. Berpartisipasi dalam program deteksi dini dan rujukan ODGJ (Rachmawati et al., 2023).
- c. Mendukung kegiatan rehabilitasi berbasis komunitas seperti kelompok dukungan keluarga (family support group) (Habita et al., 2020; Marthoenis et al., 2023).

F. Studi Kasus Dan Cara Penanganan

Studi Kasus: Keluarga Bapak S dengan Pasien Skizofrenia di Daerah Pedesaan
Identitas Pasien & Keluarga

1. Pasien Tn. R (32 tahun), diagnosis skizofrenia sejak 5 tahun lalu.
2. Tinggal bersama orang tua (Bapak S, 60 tahun; Ibu S, 58 tahun) dan satu adik.
3. Keluarga tinggal di desa terpencil, akses ke puskesmas 2 jam perjalanan.

Masalah Utama yang Dihadapi Keluarga

1. Kepatuhan terapi rendah: Tn. R sering berhenti minum obat karena efek samping (ngantuk berat, gemetar) dan keyakinan bahwa penyakitnya akibat guna-guna.
2. Stigma dan isolasi: Keluarga malu membawa Tn. R ke fasilitas kesehatan; tetangga menjauhi.
3. Beban ekonomi: Biaya transportasi ke rumah sakit jiwa terlalu mahal; Bapak S harus berhenti kerja serabutan untuk menjaga Tn. R.

4. Keterbatasan pengetahuan: Keluarga tidak tahu tanda kekambuhan dini dan menganggap pasung sebagai solusi saat Tn. R agresif.

Cara Penanganan (Intervensi Berbasis Keluarga)

1. Family Psychoeducation (FPE) oleh perawat jiwa puskesmas:
 - a. Edukasi tentang skizofrenia sebagai gangguan otak, bukan kutukan.
 - b. Ajarkan identifikasi tanda kekambuhan dini (insomnia, menarik diri, curiga berlebihan).
 - c. Diskusi efek samping obat dan cara mengatasinya (misal: minum obat malam hari untuk mengurangi sedasi).
2. Telehealth & kunjungan rumah terjadwal:
 - a. Perawat memberikan konsultasi via WhatsApp setiap 2 minggu.
 - b. Kunjungan rumah setiap bulan untuk supervisi langsung.
3. Pelibatan kader kesehatan jiwa desa:
 - a. Kader memantau kepatuhan minum obat setiap hari dan melaporkan ke perawat.
 - b. Kader membantu keluarga mengakses JKN agar obat gratis.
4. Intervensi spiritual & dukungan kelompok:
 - a. Perawat berkolaborasi dengan tokoh agama setempat untuk mengubah keyakinan salah tentang penyebab sakit.
 - b. Keluarga diikutsertakan dalam *family support group* yang difasilitasi perawat.
5. Advokasi dan bantuan sosial:
 - a. Perawat membantu mengusulkan Bapak S ke program bantuan sosial bagi keluarga miskin dengan ODGJ.
 - b. Perawat berkoordinasi dengan pekerja sosial untuk penyaluran sembako.

Hasil yang Dicapai (3 bulan)

1. Tn. R meminum obat secara teratur (kepatuhan >90%).
2. Keluarga mampu mengatasi efek samping tanpa menghentikan obat.
3. Tidak terjadi pasung atau kekambuhan berat.
4. Bapak S kembali bekerja sambil karena beban pengasuhan berkurang.

G. Tantangan

Meskipun peran keluarga sangat krusial, terdapat berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi dukungan keluarga terhadap kepatuhan terapi pasien schizophrenia:

1. Stigma dan Diskriminasi

Stigma terhadap gangguan jiwa masih sangat kuat di Indonesia. Keluarga seringkali menyembunyikan anggota keluarganya yang sakit karena takut dikucilkan masyarakat (Sarah Josephine Natalia & I Gusti Ayu Diah Fridari, 2022; Subu, Wati, et al., 2022). *Internalized stigma* menyebabkan keluarga sendiri merasa bersalah atau malu, sehingga enggan mencari bantuan profesional (Suratmini et al., 2024).

2. Beban Ekonomi

Biaya pengobatan, transportasi ke fasilitas kesehatan, serta kehilangan produktivitas karena satu anggota keluarga harus merawat pasien, menjadi beban berat terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah (Agberotimi et al., 2020; Akseer et al., 2020). Hal ini seringkali menjadi pemicu keputusan keluarga untuk melakukan pasung (Hidayat et al., 2020).

3. Kurangnya Pengetahuan tentang Gangguan Jiwa

Literasi kesehatan mental di Indonesia masih rendah. Banyak keluarga meyakini bahwa schizophrenia disebabkan oleh kerasukan roh jahat, kutukan, atau kurangnya iman (Pangiras et al., 2021; Subu, Holmes, et al., 2022). Akibatnya, mereka lebih memilih pengobatan tradisional atau pergi ke dukun daripada ke fasilitas kesehatan (Habita et al., 2020).

4. Keterbatasan Akses Layanan Kesehatan

Di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, akses terhadap psikiater, perawat jiwa, dan obat antipsikotik sangat terbatas (Putri et al., 2021). Meskipun JKN menjamin biaya, jarak geografis dan biaya transportasi masih menjadi penghalang.

5. Efek Samping Obat yang Tidak Terkelola

Antipsikotik memiliki efek samping seperti sedasi berlebihan, peningkatan berat badan, tremor, dan disfungsi seksual. Tanpa edukasi dan manajemen efek samping yang baik dari tenaga kesehatan, keluarga dan pasien cenderung menghentikan pengobatan (Hussien et al., 2023; Mannarini et al., 2020).

6. Beban Psikologis Keluarga

Merawat anggota keluarga dengan schizophrenia sangat melelahkan secara fisik dan emosional. Keluarga sering mengalami burnout, depresi, dan ansietas (Mubin et al., 2023). Tanpa dukungan psikososial yang memadai, keluarga dapat mengalami *caregiver burden* yang berat.

7. Lemahnya Koordinasi Lintas Sektor

Meskipun kebijakan sudah ada, koordinasi antara dinas kesehatan, dinas sosial, kepolisian, dan lembaga masyarakat masih lemah. Akibatnya, program seperti *Indonesia Bebas Pasung* tidak berjalan optimal (Hidayat et al., 2023; Rachmawati et al., 2023).

Tabel 3.1: Rencana Keperawatan

Diagnosa Keperawatan (Masalah Utama)	Tujuan (Setelah intervensi ...)	Tindakan Keperawatan yang Melibatkan Keluarga	Parameter Evaluasi
Kepatuhan terapi menurun berhubungan dengan kurangnya pengetahuan keluarga tentang skizofrenia dan efek samping obat	Keluarga mampu menjelaskan manfaat obat rutin dan cara mengatasi efek samping	1. Perawat memberikan FPE tentang penyakit, obat, dan efek samping. 2. Keluarga diajarkan membuat jadwal minum obat harian. 3. Keluarga dilatih melaporkan efek samping ke perawat.	Keluarga menyebutkan minimal 3 tanda kekambuhan dini; laporan kepatuhan minum obat >80%
Stigma keluarga internal (internalized stigma) berhubungan dengan keyakinan budaya dan rasa malu	Keluarga bersikap terbuka dalam mencari layanan kesehatan jiwa	1. Perawat melakukan konseling anti-stigma bertahap. 2. Keluarga diikutsertakan dalam group support dengan keluarga lain. 3. Perawat memfasilitasi pertemuan dengan tokoh masyarakat untuk mengubah stigma lingkungan.	Keluarga bersedia datang ke puskesmas; skor stigma menurun (kuesioner)
Beban pengasuhan keluarga (caregiver burden) berhubungan	Keluarga mampu mengelola stres dan memiliki waktu istirahat yang cukup	1. Perawat mengajarkan teknik relaksasi napas dalam dan manajemen stres. 2. Perawat membantu membagi tugas	Skor beban pengasuhan (Zarit Burden Interview) menurun; keluarga

dengan perawatan jangka panjang dan kurangnya dukungan sosial		pengasuhan dengan anggota keluarga lain. 3. Perawat merujuk ke pekerja sosial untuk bantuan ekonomi dan caregiver support group.	melaporkan istirahat rutin
Resiko pasung berhubungan dengan akses layanan terbatas dan keyakinan bahwa penyakit tidak bisa disembuhkan	Tidak terjadi praktik pasung dalam 6 bulan ke depan	1. Perawat memberikan edukasi pelepasan pasung dan hak ODGJ. 2. Keluarga dilatih menenangkan pasien saat agitasi (de-eskalasi). 3. Perawat menyusun rencana rujukan cepat ke rumah sakit jika pasien agresif.	Tidak ada laporan pasung; keluarga memiliki nomor darurat yang dapat dihubungi 24 jam
Kurangnya deteksi dini kekambuhan berhubungan dengan rendahnya literasi keluarga	Keluarga mampu mengidentifikasi tanda kekambuhan minimal 3 hari sebelum episode berat	1. Perawat mengajarkan family early warning sign checklist. 2. Keluarga berlatih melakukan observasi perilaku pasien setiap hari. 3. Perawat dan keluarga menyepakati rencana aksi cepat (minum obat ekstra + kontak perawat).	Keluarga secara mandiri menghubungi perawat saat tanda awal muncul; angka rawat inap ulang menurun

H. Simpulan

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dan tidak tergantikan dalam mendukung kepatuhan terapi pasien schizofrenia. Sebagai sistem pendukung utama, keluarga bertanggung jawab memastikan konsumsi obat teratur, memantau tanda-tanda kekambuhan, memberikan dukungan emosional, serta mengakses layanan kesehatan. Berbagai tren intervensi berbasis keluarga—seperti *family psychoeducation*, telehealth, intervensi spiritual, dan pelibatan kader kesehatan—telah terbukti efektif meningkatkan kepatuhan dan menurunkan angka kekambuhan.

Namun, di Indonesia, optimalisasi peran keluarga masih menghadapi tantangan besar: stigma yang mengakar, beban ekonomi, rendahnya literasi kesehatan mental, keterbatasan akses layanan, efek samping obat yang tidak terkelola, serta beban psikologis pengasuh. Perawat jiwa, bersama profesi lain dan kebijakan pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan keluarga melalui edukasi, pendampingan, advokasi, dan koordinasi layanan.

I. Referensi

- Agberotimi, S. F., Akinsola, O. S., Oguntayo, R., & Olaseni, A. O. (2020). Interactions Between Socioeconomic Status and Mental Health Outcomes in the Nigerian Context Amid COVID-19 Pandemic: A Comparative Study. *Frontiers in Psychology*, 11(January), 1–7. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.559819>
- Akseer, N., Mehta, S., Wigle, J., Chera, R., Brickman, Z. J., Al-Gashm, S., Sorichetti, B., Vandermorris, A., Hipgrave, D. B., Schwalbe, N., & Bhutta, Z. A. (2020). Non-communicable diseases among adolescents: current status, determinants, interventions and policies. *BMC Public Health*, 20(1), 1–20. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09988-5>
- Amir, F., Suhron, M., & Sulaihah, S. (2021). Family care model development in treating schizophrenia patients that have self-deficit nursing based system. *International Journal of Health & Medical Sciences*, 5(1), 7–14. <https://doi.org/10.21744/ijhms.v5n1.1808>
- Cheng, Y., Fang, Y., Zheng, J., Guan, S., Wang, M., & Hong, W. (2024). The burden of depression, anxiety and schizophrenia among the older population in ageing and aged countries: An analysis of the Global Burden of Disease Study 2019. *General Psychiatry*, 37(1), 1–11. <https://doi.org/10.1136/gpsych-2023-101078>
- Dwidiyanti, M., Sawitri, D. R., Munif, B., Fitri, A., & Wijayanti, D. Y. (2024). the Happy Spiritual Intervention for Overcoming Intolerance of Uncertainty Among Families of Patients With Mental Disorders. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 19(2), 72–77. <https://doi.org/10.20884/1.jks.2024.19.2.11032>
- Endriyani, S., Martini, S., & Pastari, M. (2024). Youth Mental Health Education and Screening with Application. *Madaniya*, 5(1), 192–198. <https://doi.org/10.53696/27214834.687>
- Habita, N. K., Yusuf, A., & Tristiana, R. D. (2020). Society perception of pasung behavior in people with mental disorders. *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 14(2), 1826–1831. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i2.3204>
- Hafrida, H., Helmi, H., Kusniati, R., Hardy, S., Tukayo, I. J. H., Maulana, R., Afzal, R., Mailani, F., Huriani, E., Muthia, R., Sarfika, R., Mahendradhata, Y., Andayani, N. L. P. E., Hasri, E. T., Arifi, M. D., Siahaan, R. G. M., Solikha, D. A., Ali, P. B.,

- Winurini, S., ... Prashanti, P. (2021). Mental Health Problems Due To Covid-19 Pandemic. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1–5. <https://doi.org/10.31983/jrk.v10i2.7542>
- Harjana, N. P. A., Januraga, P. P., Indrayathi, P. A., Gesesew, H. A., & Ward, P. R. (2021). Prevalence of Depression, Anxiety, and Stress Among Repatriated Indonesian Migrant Workers During the COVID-19 Pandemic. *Frontiers in Public Health*, 9(May), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.630295>
- Hernandez, J. (2022). Impacts of Telehealth on Access-to-Care for Mental Health Patients. *International Neuropsychiatric Disease Journal*, 18(2), 1–7. <https://doi.org/10.9734/indj/2022/v18i2345>
- Hidayat, M. T., Lawn, S., Muir-Cochrane, E., & Oster, C. (2020). The use of pasung for people with mental illness: a systematic review and narrative synthesis. *International Journal of Mental Health Systems*, 14(1), 1–21. <https://doi.org/10.1186/s13033-020-00424-0>
- Hidayat, M. T., Oster, C., Muir-Cochrane, E., & Lawn, S. (2023). Indonesia free from pasung: a policy analysis. *International Journal of Mental Health Systems*, 17(1), 1–22. <https://doi.org/10.1186/s13033-023-00579-6>
- Hussien, R. M., Al Mansoor, K. M., Ahmed, H., & Ahmed, A. (2023). Quality of Psychiatric Nursing Care: Perceptions of Nurses and Patients with Mental Illness. *The Open Nursing Journal*, 1–13. <https://doi.org/10.2174/18744346-v17-230823-2022-197>
- Ilham, R. (2024). Prevalence Of Schizophrenia Incident Rates Based On Age And Gender In RSKD Dadi South Sulawesi Province In 2022. *Jurnal EduhealthEduhealth*, 15(02), 1358–1362. <https://doi.org/10.54209/eduhealth.v15i02>
- Mannarini, S., Rossi, A., & Munari, C. (2020). How do education and experience with mental illness interact with causal beliefs, eligible treatments and stigmatising attitudes towards schizophrenia? A comparison between mental health professionals, psychology students, relatives and patients. *BMC Psychiatry*, 20(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12888-020-02580-6>
- Marthoenis, M., Sari, H., Martina, M., Alfiandi, R., Asnuriati, R., Hasniah, H., Safitri, S. D., & Fathiariani, L. (2023). The prevalence of and perception toward mental illness: a cross-sectional study among Indonesian mental health nurses. *BMC Psychiatry*, 23(1), 1–6. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-05063-6>
- Mubin, M. F., Rahayu, D. A., Dhamanik, R., Hsieh, C. J., & Basuki, R. (2023). the Experience of Families Who Care for Relatives With Mental Disorders Post Arbitrary Coercion: a Qualitative Study. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 18(2), 76–81. <https://doi.org/10.20884/1.jks.2023.18.2.8079>
- Murtantyo Hutomo, H., & Sura Anabertha Sembiring, M. (2023). Legal Protection for People with Mental Illness as Victims and Perpetrators of Criminal Acts.

ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities, 3(4), 499–505.
<https://doi.org/10.35877/soshum1967>

- Pangiras, G., Ibrahim, I. M. B., & Latif, T. B. A. (2021). A Review of the Perceptions of Mental Illness and Mental Health Literacy in Indonesia. *European Journal of Behavioral Sciences*, 4(2), 18–25. <https://doi.org/10.33422/ejbs.v4i2.612>
- Potts, L. C., Bakolis, I., Deb, T., Lempp, H., Vince, T., Benbow, Y., Waugh, W., Kim, S., Raza, S., Henderson, C., Thornicroft, G., Ando, S., Kondo, S., Ichihashi, K., Kasai, K., Yamaguchi, S., Matsunaga, A., Ojio, Y., Ogawa, M., ... de Avelar, P. P. N. (2022). Anti-stigma training and positive changes in mental illness stigma outcomes in medical students in ten countries: a mediation analysis on pathways via empathy development and anxiety reduction. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 57(9), 1861–1873. <https://doi.org/10.1007/s00127-022-02284-0>
- Putri, A. K., Gustriawanto, N., Rahapsari, S., Sholikhah, A. R., Prabaswara, S., Kusumawardhani, A. C., & Kristina, S. A. (2021). Exploring the perceived challenges and support needs of Indonesian mental health stakeholders: a qualitative study. *International Journal of Mental Health Systems*, 15(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s13033-021-00504-9>
- Quigley, D., Wiseman, S., & Farley, D. (2018). Improving Hospital Inpatient Nursing Care: A Case Study of One Hospital's Intervention to Improve the Patient's Care Experience. *Improving Hospital Inpatient Nursing Care: A Case Study of One Hospital's Intervention to Improve the Patient's Care Experience*, January. <https://doi.org/10.7249/wr751>
- Rachmawati, I., Meigawati, D., & Trang, P. D. K. (2023). The implementation of the Sistem Inovasi Cepat Penanganan ODGJ Terpadu (SICEPOT) in Sukabumi City. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 13(3), 262–272. <https://doi.org/10.21831/jpv.v13i3.70160>
- Rasmawati, AS, A. N. A., Wahyuni, Indargairi, Palinrungi, K., Hamka, M., Jumriani, & Chairul, N. (2022). Education on Shackle Release for Families with Mental Disorders. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(2), 452–459. <https://doi.org/10.30653/002.202272.92>
- Ross, L. T., & Wright, J. C. (2023). Humility, Personality, and Psychological Functioning. *Psychological Reports*, 126(2), 688–711. <https://doi.org/10.1177/00332941211062819>
- Sarah Josephine Natalia, & I Gusti Ayu Diah Fridari. (2022). The Role of Collectivist Culture and Mental Health Literacy in Mental Illness Stigma Among University Students in Indonesia. *Journal of Psychology Research*, 12(4), 166–175. <https://doi.org/10.17265/2159-5542/2022.04.002>
- Sari, R. P. P., & Montessori, M. (2021). Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengatasi Masalah Stunting pada Anak Balita. *Journal of Civic Education*,

- 4(2), 129–136. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i2.491>
- Septiansyah, D. A., Wuryaningsih, E. W., & Deviantony, F. (2023). Relationship between National Health Insurance Ownership and Compliance with Access to Health Services for Patients with Severe Mental Disorders (PSMD) "Pasung" in Blitar Regency, Indonesia. *Journal of Community Empowerment for Health*, 6(3), 128. <https://doi.org/10.22146/jcoemph.66649>
- Soltis-Jarrett, V. (2023). The Future of Psychiatric-Mental Health Nursing: Observe, Reflect, and Take Action to Empower Knowledge for the Greater Good. *Issues in Mental Health Nursing*, 44(10), 1071–1079. <https://doi.org/10.1080/01612840.2023.2270066>
- Subu, M. A., Holmes, D., Arumugam, A., Al-Yateem, N., Maria Dias, J., Rahman, S. A., Waluyo, I., Ahmed, F. R., & Abraham, M. S. (2022). Traditional, religious, and cultural perspectives on mental illness: a qualitative study on causal beliefs and treatment use. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*, 17(1). <https://doi.org/10.1080/17482631.2022.2123090>
- Subu, M. A., Wati, D. F., Netrida, N., Priscilla, V., Dias, J. M., Abraham, M. S., Slewa-Younan, S., Al-Yateem, N., Renwick, L., Susanti, H., Brooks, H., Keliat, B. anna, Bradshaw, T., Bee, P., Lovell, K., Kuusisto, A., Santavirta, J., Saranto, K., Suominen, T., ... AMU, D. E. (2022). Nursing staff's assessments of medication management process in the psychiatric and operative domains: A cross-sectional study after introduction of an electronic medication chart. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 9(1), 40–84. <https://doi.org/10.1111/scs.12989>
- Suratmini, D., Daulima, N. H. C., & Wardani, I. Y. (2024). Validity and Reliability of the Indonesian Version of the Internalized Stigma Mental Illness Instrument: Substance Abuse in Adolescents. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 19(2), 65–71. <https://doi.org/10.20884/1.jks.2024.19.2.7680>
- Susanti, H., Brooks, H., Yulia, I., Windarwati, H. D., Yuliastuti, E., Hasniah, H., & Keliat, B. A. (2024). An exploration of the Indonesian lay mental health workers' (cadres) experiences in performing their roles in community mental health services: a qualitative study. *International Journal of Mental Health Systems*, 18(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s13033-024-00622-0>
- Tasijawa, F. A., Suryani, Sutini, T., & Maelissa, S. R. (2021). Recovery from "schizophrenia": Perspectives of mental health nurses in the Eastern island of Indonesia. *Belitung Nursing Journal*, 7(4), 336–345. <https://doi.org/10.33546/bnj.1621>
- Wiseman, V., Thabrany, H., Asante, A., Haemmerli, M., Kosen, S., Gilson, L., Mills, A., Hayen, A., Tangcharoensathien, V., & Patcharanarumol, W. (2018). An evaluation of health systems equity in Indonesia: Study protocol. *International Journal for Equity in Health*, 17(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12939-018->

0822-0

Yosep, I., Mediani, H. S., & Abstract, L. L. (2021). Working alliance among mental health nurses in Indonesia: A comparative analysis of socio-demographic characteristics. *Belitung Nursing Journal*, 7(2), 125–130. <https://doi.org/10.33546/bnj.1259>

PROFIL PENULIS



Ns. Akbar Suseno, M.Kep. lahir di Manna, Bengkulu Selatan pada tanggal 20 September 1982. Penulis menyelesaikan pendidikan Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Andalas tahun 2007 dan pendidikan Magister Keperawatan peminatan Keperawatan Jiwa dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tahun 2024. Penulis bertugas sebagai PNS di RS Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi. Penulis pernah bekerja sebagai tenaga dosen tidak tetap di Akademi Keperawatan Pemprov.

Riau di Rengat, Indragiri Hulu, serta beberapa kampus lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: arkan2aditya14@gmail.com

Motto: Berusahalah yang terbaik untuk akhiratmu



Ns. Reta Renylda, S. Kep., M. Kep Lahir di Jambi pada 23 Maret 1981. Menyelesaikan Pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners di STIK Bina Husada Palembang Tahun 2002-2007 dan S2 Keperawatan di Universitas Andalas Padang Tahun 2014-2016. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi.

PROFIL PENULIS



Dr. Isak Jurun Hans Tukayo, S.Kp., M.Sc. Lahir di tahun 1962 di Jayapura, Papua. Pendidikan tinggi dimulai dari D-III Keperawatan FISIP UNCEN Jayapura lulus tahun 1987, kemudian melanjutkan S-1 Keperawatan FIK UI Jakarta lulus tahun 1997, S-2 Keperawatan LJMU Liverpool – Inggris lulus tahun 2000, dan menyelesaikan pendidikan S-3 Kedokteran PS-FK UNHAS Makassar pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1982–1984 di RS Effata Angguruk sebagai petugas Unit Laboratorium & Ruang Rontgen. Pada tahun 1988 diangkat sebagai PNS Kanwil Kesehatan Papua dan ditempatkan kembali di RS Effata Angguruk, dengan jabatan sebagai Kepala Keperawatan (1988–1992), Koordinator Pengembangan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) yang wilayah kerjanya meliputi Angguruk, Pronggoli, Panggema, Kosarek, Welarek, Mimbaham, Walma, Apalapsili, Pagai dan sekitarnya (1988–1997), serta Pengelola Pendidikan Dikswa (1988–1997). Tahun 1997, beliau bergabung di Akademi Kesehatan Terpadu (sekarang Poltekkes Kemenkes Jayapura) sebagai dosen tetap. Berbagai jabatan strategis telah diemban, antara lain Ketua Jurusan Keperawatan (2005–2006), Pembantu Direktur I (2001–2006), Pembantu Direktur II (2007–2010), kemudian dipercaya sebagai Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura selama dua periode (2010–2014 dan 2014–2018). Sebagai konsultan keperawatan Uncen (2008–2018). Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Program Pendidikan Ners PSIK-FK Uncen (2008–2010) dan Anggota Senat Uncen (2008–2010). Saat ini beliau aktif sebagai dosen tetap dengan pangkat fungsional Lektor Kepala serta menjabat sebagai Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan (2019–sekarang) dan Konsultan Keperawatan di Universitas Cenderawasih (2008–sekarang). Penulis juga aktif dalam organisasi profesi, antara lain sebagai Dewan Pengurus Pusat PPNI Jakarta periode 2015–2020 dan 2021–2026, Ketua DPW PPNI Papua dua periode (2012–2023), serta Ketua AIPVIKI Regional XI Papua & Papua Barat periode 2015–2023. Penulis telah menulis puluhan buku, di antaranya *Konsep Dasar Evaluasi Aplikasi Kesehatan Digital* (2026), *Malaria Tukayo: Aplikasi Inovatif untuk Deteksi dan Pencegahan Malaria* (2025), *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (2022), *Manajemen Pendidikan Keperawatan Berbasis Karakter* (2021), serta berbagai judul lainnya. Penulis juga aktif mempublikasikan karya ilmiah di jurnal nasional dan internasional, antara lain *Acceleration of Malaria Monitoring Program Led by Nurses Using Electronic Data Systems on the Shore of Lake Sentani* (2025), *Determination of Fit to Work Status for Thyroid Cancer Survivor* (2022), *The Occupational Health Nursing Education Components Most Influenced by Informatics Technology* (2022), dan masih banyak lagi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: tukayoisak123@gmail.com

Motto: "Living your life well"

Sinopsis

Bunga Rampai "Peran Perawat dalam Manajemen Halusinasi pada Pasien Skizofrenia" membahas secara komprehensif peran perawat dalam memahami, mengkaji, dan menangani halusinasi sebagai salah satu gejala utama yang sering dialami oleh pasien skizofrenia. Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar skizofrenia dan halusinasi, meliputi pengertian skizofrenia, konsep halusinasi, tanda dan gejala, jenis-jenis halusinasi, rentang respons, penatalaksanaan, serta rencana tindakan keperawatan. Pembahasan ini memberikan dasar penting bagi pembaca untuk memahami bagaimana halusinasi memengaruhi persepsi, emosi, perilaku, hubungan sosial, dan keselamatan pasien.

Selanjutnya, buku ini menguraikan pengkajian keperawatan jiwa pada pasien dengan halusinasi secara sistematis dan aplikatif. Materi yang dibahas mencakup konsep dasar pengkajian keperawatan jiwa, faktor predisposisi dan presipitasi halusinasi, tanda dan gejala pasien dengan halusinasi, pengkajian status mental, pengkajian terfokus pada isi dan karakteristik halusinasi, serta pengkajian risiko yang dapat muncul pada pasien. Buku ini juga menekankan pentingnya teknik komunikasi terapeutik dalam membangun hubungan saling percaya, menggali pengalaman pasien, mengarahkan pasien pada realitas, serta membantu perawat dalam melakukan analisis data dan merumuskan masalah keperawatan secara tepat.

Pada bagian akhir, buku ini membahas peran keluarga dalam mendukung kepatuhan terapi dan perawatan pasien skizofrenia. Dukungan keluarga menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pengobatan, mencegah kekambuhan, meningkatkan kemampuan pasien dalam mengontrol halusinasi, serta memperkuat proses pemulihan. Selain itu, buku ini juga menyoroti peran perawat jiwa, kolaborasi dengan profesi lain, kebijakan pemerintah, keterlibatan masyarakat, studi kasus, serta tantangan dalam perawatan pasien skizofrenia. Dengan penyajian yang sistematis, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat jiwa, tenaga kesehatan, keluarga pasien, dan pembaca yang ingin memahami manajemen halusinasi pada pasien skizofrenia secara holistik dan berkelanjutan.

Bunga Rampai “Peran Perawat dalam Manajemen Halusinasi pada Pasien Skizofrenia” membahas secara komprehensif peran perawat dalam memahami, mengkaji, dan menangani halusinasi sebagai salah satu gejala utama yang sering dialami oleh pasien skizofrenia. Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar skizofrenia dan halusinasi, meliputi pengertian skizofrenia, konsep halusinasi, tanda dan gejala, jenis-jenis halusinasi, rentang respons, penatalaksanaan, serta rencana tindakan keperawatan. Pembahasan ini memberikan dasar penting bagi pembaca untuk memahami bagaimana halusinasi memengaruhi persepsi, emosi, perilaku, hubungan sosial, dan keselamatan pasien.

Selanjutnya, buku ini menguraikan pengkajian keperawatan jiwa pada pasien dengan halusinasi secara sistematis dan aplikatif. Materi yang dibahas mencakup konsep dasar pengkajian keperawatan jiwa, faktor predisposisi dan presipitasi halusinasi, tanda dan gejala pasien dengan halusinasi, pengkajian status mental, pengkajian terfokus pada isi dan karakteristik halusinasi, serta pengkajian risiko yang dapat muncul pada pasien. Buku ini juga menekankan pentingnya teknik komunikasi terapeutik dalam membangun hubungan saling percaya, menggali pengalaman pasien, mengarahkan pasien pada realitas, serta membantu perawat dalam melakukan analisis data dan merumuskan masalah keperawatan secara tepat.

Pada bagian akhir, buku ini membahas peran keluarga dalam mendukung kepatuhan terapi dan perawatan pasien skizofrenia. Dukungan keluarga menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pengobatan, mencegah kekambuhan, meningkatkan kemampuan pasien dalam mengontrol halusinasi, serta memperkuat proses pemulihan. Selain itu, buku ini juga menyoroti peran perawat jiwa, kolaborasi dengan profesi lain, kebijakan pemerintah, keterlibatan masyarakat, studi kasus, serta tantangan dalam perawatan pasien skizofrenia. Dengan penyajian yang sistematis, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat jiwa, tenaga kesehatan, keluarga pasien, dan pembaca yang ingin memahami manajemen halusinasi pada pasien skizofrenia secara holistik dan berkelanjutan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-24-4 (PDF)



9

786347

756244